

LES PIEGES FREQUENTS A EVITER EN QCD

Bien lire lentement les énoncés des questions

1. Le problème peut se trouver au niveau des unités

Par exemple dans le cours on peut avoir écrit 1507 m et dans le devoir on vous propose dans la réponse : 1507 cm.

Visuellement, vous avez vu le vrai nombre qui est **1507** mais vous pouvez cocher sans vous rendre compte que l'unité est fausse.

2. On peut avoir le bon chiffre mais la virgule ou la puissance peut être fausse

Exemple 1 : dans le cours on peut avoir écrit 152,1 mètres et dans le devoir on vous propose 15,21 mètres

Exemple 2 : dans le cours on peut avoir écrit 12m^2 et dans le devoir proposer 12 m ou 12m^3

3. La réponse peut vous paraître fausse alors qu'elle est juste, tout simplement parce que vous n'avez pas été vigilant sur la conversion des unités.

Exemple 1: Dans le cours on vous dit ceci : pour une population de plus de 12000 habitants il faut effectuer 1 séance de vaccination par semaine.

Dans le devoir, on vous propose ceci : pour une population de plus de 12000 habitants il faut effectuer 4 séances de vaccination par mois

Exemple 2: Dans le cours on vous dit : le rayon du puits est 0,70 m et dans le devoir on propose 70 cm

4. Méfiez-vous des anciens sujets qui peuvent être reconduits sans changement des questions mais avec un libellé différent.

Exemple : On vous donne une série de questions avec le libellé suivant :

Cochez les réponses justes ou correctes.

On peut vous redonner la même série de questions soit en deuxième session ou une autre année plus tard avec le libellé suivant : **Cochez les réponses fausses.**

5. Le piège peut être inséré dans une négation que l'on ne perçoit pas.

Par exemple : Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui n'apparaissent pas en cas de paludisme

L'étudiant peut être tenté de rechercher parmi les propositions, les signes du paludisme

6. Faites attention aux mots forts comme jamais, uniquement, toujours

En général, les propositions contenant ces mots forts sont faux car il existe très souvent des exceptions

7. Faire attention aux mots qui se ressemblent

Exemple : abduction, addition

8. Faire attention aux jeux de mots contraires

Exemple : externes/internes, extérieur/intérieur, supérieur/inférieur, antérieur, postérieur, postnatal, prénatal....

9. La réponse peut être fausse parce qu'elle est incomplète

Par exemple : Dans le cours on vous dit ceci : les objectifs du système de santé sont la promotion de la santé, la prévention des maladies et la restauration de la santé.

Exemple 1 : Dans le devoir on propose ceci : les objectifs du système de santé sont la promotion de la santé et la prévention des maladies.

Les éléments proposés sont justes mais la proposition n'est pas complète

10. L'erreur peut arriver par manque de vigilance sur des jeux de mots

Exemple : dans le cours on dit ceci : les objectifs du système de santé sont la promotion de la santé, la prévention des maladies et la restauration de la santé.

Dans le devoir on propose : les objectifs du système de santé sont la promotion de la maladie, la prévention de la santé et la restauration de la santé.

11. L'erreur peut se cacher dans un mot ou un nom mal écrit

Exemple : Au cours : La conférence d'Alma Ata a eu lieu du 6 au 18 septembre 1978

Au devoir : La conférence d'Ata Alma a eu lieu du 6 au 18 septembre 1978

12. L'erreur peut se loger dans un nombre ou un chiffre

Exemple : Au cours : La conférence d'Alma Ata a eu lieu du 6 au 18 septembre 1978

Au devoir : La conférence d'Alma Ata a eu lieu du 6 au 18 septembre 1987

13. L'erreur peut provenir d'une phrase dont la réciproque est fausse.

Exemple : Un système de santé peut être efficient sans être efficace. Faux

Un système de santé peut être efficace sans être efficient. Vrai

14. L'erreur peut provenir d'un simple petit signe.

Exemple : $P_t = P_0 (1-r)^t$ au lieu de $P_t = P_0 (1+r)^t$

15. L'erreur peut provenir d'un mot modifié.

Exemple : L'altération des vaccins est **irréversible**. Vrai

L'altération des vaccins est **reversible**. Faux

L'altération des vaccins est **non réversible**. vrai

16. L'erreur peut provenir de deux éléments contradictoires contenus dans la même phrase.

Exemple : Les **glacières** et les **chambres froides** produisent du froid. Faux

17. Il peut s'agir d'une phrase dont le début est juste et la fin fausse ou vis-versa

Exemple : Le BCG est un **vaccin bactérien** inactivé. Faux

18. L'usage des mots comme successivement, respectivement crée parfois la confusion

Exemple 1 : L'histoire du système de santé a connu **successivement** la période **d'après l'indépendance** et la période **d'avant l'indépendance**. Faux

Exemple : L'histoire du système de santé a connu **successivement** la période **d'avant l'indépendance** et la période **d'après l'indépendance**. Vrai

Exemple 2 : En Côte d'Ivoire les populations cibles des campagnes de VPO, de Td et de RR **sont respectivement** les **enfants de 0 à 59 mois**, les **femmes en âge de reproduction** et les **enfants de 9 mois à 14 ans**. Vrai

En Côte d'Ivoire les populations cibles des campagnes de VPO, de Td et de RR **sont respectivement** les **femmes en âge de reproduction**, les **enfants de 0 à 59 mois** et les **enfants de 9 mois à 14 ans**. Faux

19. L'erreur peut provenir d'un mot retiré d'une phrase.

Q1.Exemple : La vaccination contre les maladies infectieuses est une composante promotionnelle des SSP. Faux

La vaccination contre les principales maladies infectieuses est une composante promotionnelle des SSP. Vrai

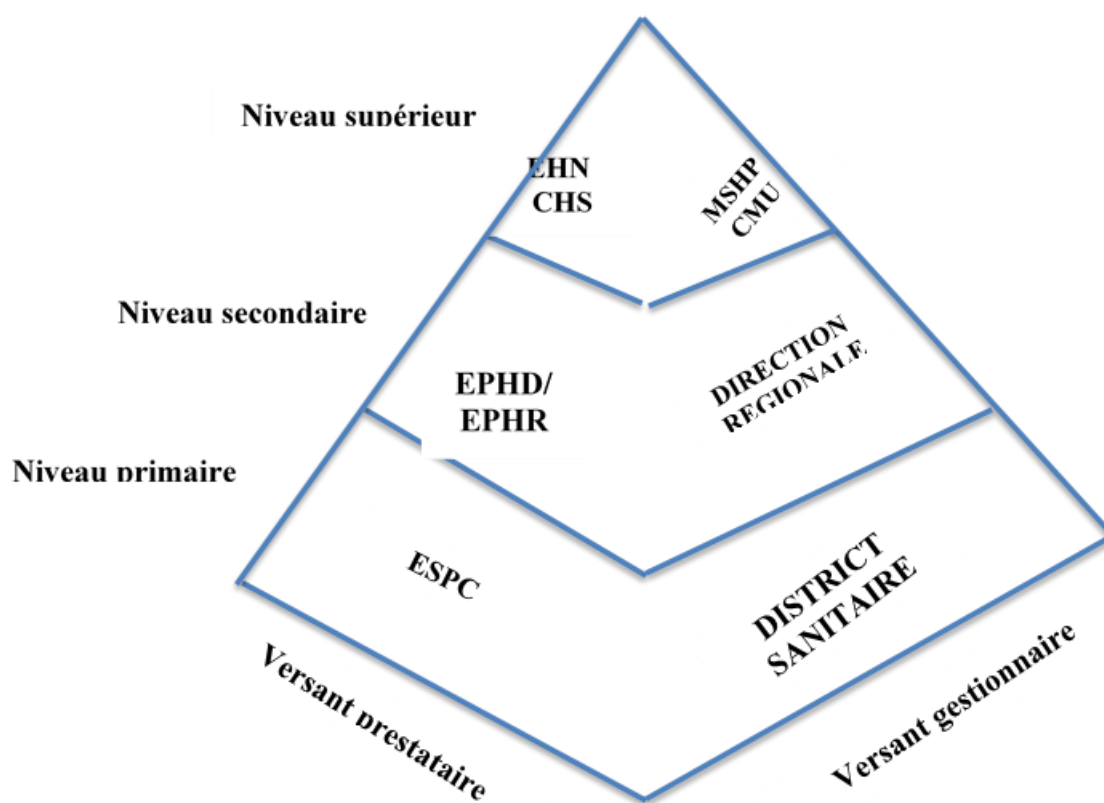
ACTUALISATION DE COURS

LICENCE 1

I.NOUVELLES APPELATIONS

SIGLE	Dénomination actuelle	Ancienne Dénomination
EPHD	Etablissement Public Hospitalier Départemental	Hôpital général (HG)
EPHR	Etablissement Public Hospitalier Régional	CHR
EPHN	Etablissement Public Hospitalier National	CHU

II.NOUVELLE PYRAMIDE SANITAIRE



SCHEMA DE LA PYRAMIDE SANITAIRE IVOIRIENNE

III.CALENDRIER VACCINAL AVEC LE VAP

Age	Vaccins	Maladies
6 mois (24 semaines)	VAP-1	Paludisme
8 mois (32 semaines)	VAP-2	Paludisme
9 mois	VAP-3	<i>Paludisme</i>
15 mois	VAP-4	<i>Paludisme</i>

IV.NOUELE POPULATION CIBLES DU PEV

- Enfant de 0 à 23 mois
- Fille de 9 ans
- Femme enceinte

LICENCE 2

Rappel des proportions des différentes populations cibles utilisées en Côte d'Ivoire

Population cible	Proportion
Enfant de 0 à 11 mois	3,5% de la population totale
Enfant de 0 à 6 mois	1,45% de la population totale
Enfant de 0 à 23 mois	6,82% de la population totale
Enfant de 12 à 23 mois	3,32% de la population totale
Enfant de 0 à 5 ans	20% de la population totale
Enfant 1 à 4 ans	17,32% de la population totale
Grossesses attendues	5% de la population totale
Femmes séropositives	4,1 % des Grossesses attendues
Naissances attendues	4,7% de la population totale
9 mois à 14 ans	45% de la population totale
Jeunes Filles de 9 ans	1,86 % de la population totale

Source : DCPEV

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A LA SANTE PUBLIQUE**QCD**

- Q1.L'identification des risques de santé est l'un des domaines de la santé communautaire. A
- Q2.La santé communautaire et la santé publique sont deux approches identiques. B
- Q3.La santé communautaire vise la protection de la population. B
- Q4.La santé publique se situe au niveau de la population. B
- Q5.La santé publique se situe au niveau de la communauté. B
- Q6.La santé publique vise la promotion de la santé. B
- Q7.Le niveau décisionnel de la santé communautaire se situe au niveau de la communauté. A
- Q8.Le niveau décisionnel de la santé publique se situe au niveau étatique. A

QCM

Q1.La 2^{ème} étape de la démarche de santé publique consiste à :

- A.Identifier des ressources **B.Définir des priorités**
- C.Formuler du problème avec la détermination de la population cible ;

Q2.Le concept de santé publique a été défini par Wilson en :

- A-1920** B- 1945 C-1946

Q3.Le concept de santé communautaire a été défini en :

- A-1920 B-1986 **C-1987**

Q4.Le concept de promotion de la santé a été défini en :

- A-1920 **B-1986** C-1987

Q5.Le mouvement de la « Santé pour tous » est apparu en :

- A-1977** B-1978 C-1980 D-1990

Q6.Quel est l'ordre normal des étapes de la démarche en santé publique

1. Définition des priorités (problème prioritaire).
2. Analyse de la situation et identification du ou des problèmes de santé.
3. Formulation du problème et détermination de la population cible.
4. Etablissement d'un plan d'action opérationnel.
5. Formulation des objectifs.
6. Suivi et évaluation du programme.
7. Choix des stratégies (activités).
8. Identification des ressources (financières, matérielles, humaines, temporelles).
9. Exécution du programme établi.

A (1,2,3,4,5,6,7,8,9) **B (2,1,3,5,7,8,4,9,6)** C (1,3,2,4,5,6,8,9,7)

Q7. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui ne constituent pas des niveaux de perception des besoins de santé

A- Le niveau des besoins non satisfaits

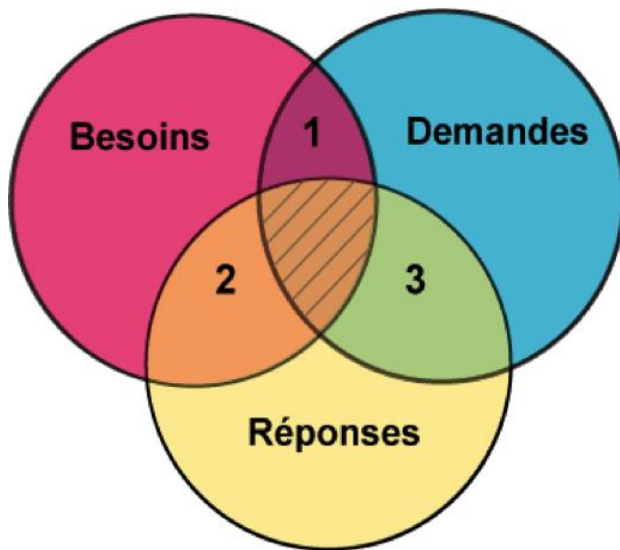
B- Le niveau des besoins latents

C- Le niveau des besoins ressentis

D- Le niveau des besoins satisfaits

E- Le niveau des besoins fondamentaux

F- Le niveau des besoins exprimés



Q8. A partir du schéma des niveaux de perception des besoins, faites correspondre les numéros aux descriptions.

1. a- Besoins existants, demande exprimée mais pas de réponse
2. b- Besoins non identifiés et réponse à des demandes.
3. c- Besoins existants, existence de réponse mais demande non exprimée

A (1,a) **D(2,a)** **B (2,c)** **C(3,b)** E(1,b) F(3,b)

Q9. Faites correspondre les caractéristiques aux concepts suivants :

1. Santé communautaire
2. Santé publique

- a. Vise la protection de la santé de la population
- b. Vise la promotion de la santé
- c. Se situe au niveau de l'état
- d. Se situe au niveau de la communauté

A (1,a,d) **B (1,a,c)** **C (2,d,b)** **D (2,b,c)**

CHAPITRE 2 : ETUDE DU MILIEU**QCD**

- Q1.L'absence d'eau courante est un facteur socio-économique favorisant la maladie. A
Q1.L'absence d'un habitat salubre est un facteur socio-économique favorisant la santé. B
Q2.L'âge et les soucis sont des facteurs biologiques favorisant la maladie. B
Q3.L'existence d'un habitat insalubre est un facteur socio-économique favorisant la maladie. A
Q4.L'existence de promiscuité est un facteur socio-économique favorisant la maladie. A
Q5.L'existence des ordures et les parasites sont des facteurs déterminant la maladie. B
Q6.L'ignorance et les soucis sont des facteurs socio-culturels favorisant la maladie. B
Q7.La présence de troubles métabolique est un facteur biologique favorisant la santé. B
Q8.La présence de troubles métabolique est un facteur physiologique favorisant la santé. B
Q9.La présence de troubles psychiques psychologiques favorisant la santé. B
Q10.Les bruits et les virus sont des facteurs déterminant la maladie. B
Q11.Les virus et les parasites sont des facteurs déterminant la santé. B

QCM

Q1.Les attitudes à développer par le personnel de santé pour mener une bonne étude du milieu sont :

A-l'observation B- la méfiance C- le dialogue D- l'ethnocentrisme

Q2.Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui favorisent la santé

A-L'ignorance B- Les soucis C- Absence de troubles psychiques D- L'âge
E-Absence de troubles métaboliques F- Environnement affectif satisfaisant

Q3.Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui favorisent la maladie

A-L'ignorance B- Les soucis D- Absence de troubles psychiques
E- Absence de troubles métaboliques F- Environnement affectif satisfaisant G- Le sexe

Q4.Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont biologiques

A-Absence de troubles psychiques B- Absence de troubles métaboliques
C-Bonne aération D- Environnement affectif satisfaisant

Q5.Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont psychologiques

A-Absence de troubles psychiques B- Absence de troubles métaboliques
C- Bonne aération D- Environnement affectif satisfaisant

Q6. Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont socio-économiques

- A- Absence de troubles psychiques B- L'existence d'un habitat salubre
C- Absence de troubles métaboliques D- Environnement affectif satisfaisant
E- L'existence d'eau courante F- L'absence de promiscuité

Q7. Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez celui qui est lié à l'environnement physique

- A- L'existence d'eau courante B- Absence de pollution C- Absence de troubles psychiques
D- Environnement affectif satisfaisant

Q8. Parmi les facteurs suivants favorisant la maladie indiquez ceux qui sont physiologiques

- A- Les bruits B- L'ignorance C- L'âge D- Le sexe E- Les soucis F- Les ordures

Q9. Parmi les facteurs suivants favorisant la maladie indiquez celui qui est psychologique

- A- L'ignorance B- Les soucis C- Le chômage D- Le bruit

Q10. Parmi les facteurs suivants favorisant la maladie indiquez celui qui est économique

- A- L'ignorance B- Les soucis C- Le chômage D- Les ordures

Q11. Parmi les facteurs suivants favorisant la maladie indiquez celui qui est d'ordre socio-culturel

- L'ignorance B- Les soucis C- Le chômage D- Les ordures

Q12. Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui sont des déterminant de la maladie

- A- L'eau polluée B- Les microbes C- Les parasites D- Les ordures E- Les virus F- Les bruits

Q13. Parmi les facteurs suivants favorisant la maladie indiquez ceux qui sont environnementaux

- A- Absence d'eau potable B- Présence d'ordures C- Présence de bruits D- Absence de pollution

CHAPITRE 4 : SYSTEME NATIONAL DE SANTE**QCD**

Q1.L'objectif principal du système post colonial était de maintenir en bonne santé la main d'œuvre destinée au développement économique. B

Q2.La prestation des services et le système d'information sur la santé sont deux des trois composantes d'un système de santé. B

Q3.Le système de santé ivoirien est sous forme pyramidale avec deux versants et trois niveaux. A

Q4.Le système de santé ivoirien est sous forme pyramidale avec trois versants et deux niveaux. B

Q5.Les objectifs d'un système de santé consistent à restaurer la santé, promouvoir la maladie et assurer la prévention de la santé. B

Q6.Les piliers d'un système de santé sont au nombre de cinq (5). B

Q7.Les ressources humaines pour la santé regroupent entre autres les travailleurs non médicaux qui assurent la gestion et le soutien dans les services de santé. A

Q8.Les soins sont acceptables lorsque leur administration tient compte des caractéristiques socioculturelles des communautés. A

Q9.Les soins sont dits essentiels lorsqu'ils portent sur les besoins prioritaires des individus, des familles et des communautés. A

Q10.Pendant la période coloniale le personnel était en nombre réduit et formées sur le tas et à l'école de médecine Jules CARDE en France. B

Q11.Un système dans lequel des activités de prévention, de soins curatifs et de sensibilisation sont menées peut être considéré comme global. A

Q12.Un système de santé efficace est toujours efficient. B

Q13.Un système de santé efficient est toujours efficace. A

Q14.Un système de santé peut être efficient sans être efficace. B

Q15.Un système de santé qui a la capacité de mesurer les résultats obtenus et d'identifier les difficultés rencontrées est dit évaluable. A

Q16.Un système de santé qui atteint ses objectifs avec les moyens disponibles est efficient. B

Q17.Un système de santé qui s'adapte constamment à l'évolution des besoins de la population est dit efficient. B

QCM

Q18. Quelles sont les bonnes combinaisons entre les nouveaux sigles et les anciennes appellations ?

- | | |
|--------|-------------------|
| 1.EPHD | a. CHU |
| 2.EPHN | b.Hôpital général |
| 3.EPHR | c.CHR |

A.(1 ;b) B (2 ;b) C(3 ;a) D.(2 ;a) E.(3 ;c) F.(1 ;c)

Q19. Parmi les Sigles suivants, indiquez celui qui correspond à la nouvelle appellation du CHR.

- A.EPHN B. EPHD **C.EPHR**

Q20. Parmi les Sigles suivants, indiquez celui qui correspond à la nouvelle appellation du CHU.

- A.**EPHN** B. EPHD C.EPHR

Q21. Parmi les Sigles suivants, indiquez celui qui correspond à la nouvelle appellation de l'hôpital général.

- A.EPHN **B. EPHD** C.EPHR

Q22. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui correspond à l'objectif principal de la CMU

A.obliger tous les ivoiriens à participer au financement des activités de soins

B.assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous les ivoiriens

C.Eviter aux pauvres de bénéficier gratuitement des soins de santé des services publics

Q23. Les objectifs ci-dessous énumérés sont les objectifs d'un système de santé, sauf un. Lequel ?

A-Restauration la santé B- Assurer la prévention de la santé C- Assurer la promotion de la santé.

Q24. La période 1960 à 1980, indiquez le volet des activités de la santé qui n'était pas mis en œuvre.

A-Un volet orienté sur les soins curatifs avec pour caractéristique essentielle, la gratuité des soins.

B-Un volet orienté sur la promotion de la santé.

C-Un volet préventif basé sur une assistance médicale visant la lutte contre les grandes endémies.

Q25. Parmi les activités suivantes indiquez celles qui sont du domaine de la prévention des maladies

A-les spots publicitaires télévisés relatifs aux problèmes de santé

B-la vaccination C-le dépistage volontaire du VIH /SIDA

D-la consultation prénatale E-la sensibilisation en vue de l'utilisation des MILDA

Q26. Parmi les milieux suivants, indiquez ceux qui étaient concernés par les activités d'hygiène collective menée pendant la période coloniale

A-les domiciles privés **B-le milieu scolaire** **C-les marchés** **D- les prisons** E- les lieux de culte

F-les cinémas

Q27. Parmi les actions de prophylaxie suivantes, indiquez celles pratiquées en période coloniale:

A-le dépistage des cas de maladies B-les consultations prénatales C- **l'isolement des cas dépistés.**

D- les stratégies avancées E- les journées nationales de vaccination

CHAPITRE 5 : GENERALITES SUR LE PEV**QCD**

- Q1.Un vaccin est une substance qui a l'avantage d'avoir un effet plus durable que celui d'un sérum.
A
- Q2.Un enfant qui suit correctement son calendrier de vaccination, reçoit le VPO1 à 10 semaines. B
- Q3.Un enfant qui suit correctement son calendrier de vaccination, reçoit le VPI-1 à 6 semaines. A
- Q4.Un enfant séropositif qui suit correctement son calendrier de vaccination, reçoit le RR-1 à 6 mois.
A
- Q5.A l'exception du BCG et du VPO,la dose à administrer pour les autres vaccins du PEV est de 0,5 ml. B
- Q6.A la 14ème semaine de vie, le nourrisson doit recevoir idéalement les doses de vaccin comme suit : DTCHevBHib + VPO+ Pcv13 + Rota et VPI. A
- Q7.Chez un enfant de 10 mois mal vacciné, le vaccin prioritaire à lui administrer le jour du rattrapage est le RR. A
- Q8.Chez un enfant de 7 mois mal vacciné, le vaccin prioritaire à lui administrer le jour du rattrapage est le Penta. A
- Q9.En matière de vaccination, l'intervalle minimum n'existe pas. B
- Q10.Entre deux doses d'un vaccin à contacts multiples, on peut observer un intervalle de plus de 4 semaines. A
- Q11.Il est possible d'oublier l'administration d'un antigène contenu dans une association combinée de vaccins. B
- Q12.La prématurité est une contre-indication du BCG. B
- Q13.La voie d'injection du BCG est la face externe du haut du bras ou épaule gauche. B
- Q14.Le BCG est un vaccin bactérien inactivé. B
- Q15.Le point d'injection du Penta est l'intramusculaire. B
- Q16.Le Rotarix est un vaccin bactérien vivant atténué qui s'administre par voie orale à raison de 2ml par dose. B
- Q17.Le Td est une anatoxine qui peut être congelée sans inconvénient. B
- Q18.Le vaccin combiné contre le tétanos et la diphtérie s'administre en intra musculaire aux femmes enceintes. A
- Q19.Le vaccin de l'hépatite B pédiatrique s'administre en sous cutané à 6 semaines aux enfant de 0 à 11mois. B

- Q20. Le VPO et le VPI protègent contre la même maladie. A
- Q21. Les associations simultanées de vaccins peuvent se faire pendant des jours différents à condition de ne pas aller au-delà d'une semaine. B
- Q22. Les différents vaccins associés de façon combinée ont toujours le même point d'injection. A
- Q23. Pour un enfant ayant abandonné la vaccination pendant une longue période, il est recommandé de reprendre son calendrier dans sa totalité. B
- Q24. Une jeune fille de 9 ans séronégative au VIH reçoit 03 doses de HPV. B
- Q25. Un enfant âgé de 2 semaines ayant été déjà vacciné avec le VPO, le BCG et la dose d'hépatite B dès la naissance est correctement vacciné. A
- Q26. Un enfant correctement vacciné est celui qui reçoit toutes les doses de vaccins inscrites dans le programme élargi de vaccination. B
- Q27. Un enfant de 0 à 23 mois correctement vacciné reçoit trois doses d'hépatite B dans son organisme. B
- Q28. Une MAPI est une manifestation indésirable qui survient avant une vaccination et qui n'est pas nécessairement liée à l'utilisation du vaccin. B
- Q29. Le matrix R21 est un vaccin conjugué. B
- Q30. Le matrix R21 est un vaccin recombiné. A
- Q31. Le matrix R21 est un vaccin liquide éligible à la politique du flacon entamé. B

QCM

Q1. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles dont la prévention se fait avec le Td.

- A. La diphtérie B. La tuberculose C. Le tétanos D. La dengue E. La diarrhée à rotavirus

Q2. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles dont la prévention se fait avec le Penta.

- A. Le tétanos B. La coqueluche C. L'hépatite B D. La rubéole E. La fièvre jaune
F. La méningite à *Haemophilus influenzae* de type B ;

Q3. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui permettent de prévenir le tétanos

- A. Td B. BCG C. PCV-13 D. Penta

Q4. Quel est l'ordre normal d'administration de des groupes de vaccins suivants ?

1. DTC-Hép B-Hib, VPO1, PCV13-1, Rota1, VPI 1
 2. Penta 2, VPO 2, PCV13-2, Rota2
 3. DN-Hép B, BCG, VPO 0
- A (1,2,3) B (2,1,3) C (1,3,2) D (2,3,1)

Q5.Un enfant séropositif qui suit correctement son calendrier de vaccination, reçoit.

- A. 01 dose de RR avant son premier anniversaire
- B. 02 doses de RR avant son premier anniversaire
- C. 03 doses de RR avant son premier anniversaire

Q6.Un enfant de 9 mois correctement vacciné selon le calendrier normal du PEV aura reçu :

- A-02 doses de RR
- B-04 doses d'hépatite B
- C-03 doses de PCV-13
- D-03 doses de VPO

Q7.Le rattrapage des vaccins chez un enfant n'ayant pas suivi correctement son calendrier de vaccination se fait au plus tard jusqu'à :

- A. 11 mois
- B-12 mois
- C-15 mois
- D-23 mois

Q8.Le rattrapage du HPV vaccins chez une jeune fille de 9 ans n'ayant pas suivi correctement son calendrier de vaccination se fait au plus tard jusqu'à :

- A. 14ans
- B-15 ans
- C-18 ans

Q9.Le rattrapage du Td vaccins chez une femme enceinte n'ayant pas suivi correctement son calendrier de vaccination se fait au plus tard jusqu'à :

- A. 03ans avant l'accouchement
- B-01 an après l'accouchement
- B. 03ans après l'accouchement

Q10.Une femme enceinte ayant une protection de 3 ans contre le tétanos aura reçu dans son organisme au moins

- A. 01 dose de Td
- B-02 dose de Td
- C-03 doses de Td
- E-04 doses de Td

Q11.Une femme enceinte ayant reçu 01 dose de Td dans son organisme aura :

- A. Aucune protection contre le tétanos
- B-03 ans de protection contre le tétanos
- C-05 ans de protection contre le tétanos
- D-10 ans de protection contre le tétanos
- B. Une protection à vie

Q12.Quel est la conduite à tenir cohérente chez un enfant de 6 semaines reçu en séance vaccination et ayant une fièvre de 38°C

- 1.Rechercher la cause de la fièvre
- 2.Faire baisser la fièvre
- 3.traiter la cause de la fièvre
- 4.Vacciner l'enfant
- 5.Reporter la vaccination

- A(1,2,3,4,5)
- B (5,4,3,2,1)
- C (2,1,3,4)
- D (2,1,3,5)

Q13. Quel est la conduite à tenir cohérente chez un enfant de 6 semaines reçu en séance vaccination et ayant une fièvre de 39°C en dehors d'une période d'épidémie

1. Rechercher la cause de la fièvre
2. Faire baisser la fièvre
3. traiter la cause de la fièvre
4. Vacciner l'enfant
5. Reporter la vaccination

A(1,2,3,4,5) B (5,4,3,2,1) C (2,1,3,4) **D (2,1,3,5)**

Q14. Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, le vaccin RR est administré aux enfants séronégatifs à :

- A. 10 semaines **B-6mois** C. **9 mois** D-11 mois E-**15 mois**

Q15. Parmi ces antigènes suivants, lequel est vivant atténué ?

- A. Td B-**VPO** C-VPI

Q16. Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :

1. BCG 2. Penta 2 3. VAA 4. VPI 5. Rota 1

A (1,2,5,4,3) **B(1,5,2,4,3)** C (1,2, 5,3,4) D (1,5,3,2,4)

Q17. Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :

1. VPO0 2. Men A 3. PCV13-1 4. Rota 2 5. Penta 3

A (1,3,4,5,2) B (1,3,5,4,2) C (1,2,3,4,5)

Q18. Combien de doses d'hépatite B doit recevoir un enfant de 0 à 23 mois complètement vacciné ?

- A. 2 doses** B-03 doses C-**04 doses**

A (1,a) B(2, d) **C(2,c)** D(3,e) **E(5,e)** **F(3,b)** G (1,c) **H(4,d)**

Q19. Cochez les bonnes correspondances entre les vaccins et les voies d'administration

- A. VPO/voie intradermique **B. VAA/voie sous-cutanée** C. RR/voie intramusculaire
D. VPI/voie orale

Q20. Cochez les bonnes réponses suivant les correspondances entre les vaccins et les doses à administrer.

- A. BCG= 0,5 ml **B. Td=0,5 ml** C. RR= 0,05 ml D. VPI/2 gouttes

Q21. Cochez les associations qui sont contre-indiquées

- A. BCG/enfant de 1 mois B. VAA/maladie avec fièvre de 38°C
C. RR/cible avec état général altéré D. VPO/ Nourrisson de 6 mois

Q22. Un enfant de 2 mois correctement vacciné aura reçu dans son organisme

- A. 11 antigènes** B. 06 antigènes C. 09 antigènes D. 08 antigènes

Q23.Chez la femme enceinte, il est recommandé de faire le premier rappel du Td :

- A. 6 mois après la première dose B. 7 mois après la première dose C. 1 mois après la 2^e dose

Q24.Parmi ces vaccins de rattrapage, indiquez la combinaison qui doit être injectée à un enfant de 11 mois non vacciné dès le 1er contact.

- A. DTC₁-HepB₁-Hib₁ + VPO₀+Rota₁+BCG B. DTC₁-HepB₁-Hib₁ + VPO₀ + RR + Rota₁
C-DTC₂-Hep₂-Hib₂ + VPO₁+ BCG+Rota₂ D.DTC₃-Hep₃-Hib₃ + VPO₂+ VAA + Rota₃

Q25.Identifier parmi ces vaccins, ceux qui sont viraux :

- A. Le RR B-BCG C-VAA D-VPI

Q26.Identifier parmi les vaccins suivants, ceux qui sont inactivés :

- A. VPI B-Penta D-VPO E. RR

Q27.Parmi Les vaccins suivants indiquez ceux qui peuvent être congelés

- A. BCG B-Penta C-VPO D-VPI E-Td

Q28.Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux que doit recevoir un enfant de 2 semaines :

- A. Penta B-VPO C-PCV13 D-BCG E-Hépatite B pédiatrique F-Rotarix

Q29.Parmi les antigènes suivants, lequel est vivant atténué ?

- A. Td B-VPI C-VPO

Q30.Parmi ces vaccins de rattrapage, indiquez la combinaison qui doit être injectée dès le 1er contact, à un enfant de 11 mois non vacciné.

- A-DTC₁-HepB₁-Hib₁ + VPO₀+Rota₁+BCG B-DTC₁-HepB₁-Hib₁ + VPO₀ + RR + Rota₁
C-DTC₂-Hep₂-Hib₂ + VPO₁+ BCG+Rota₂ D.DTC₃-Hep₃-Hib₃ + VPO₂+ VAA + Rota₃

Q31.Parmi les informations suivantes relatives au RR, indiquez celles qui sont justes :

- A.il est inactivé
B.il s'administre toujours à l'enfant à partir de 9 mois
C.il provoque des réactions indésirables D-il s'administre en sous-cutané

Q32.Un enfant âgé de 2 semaines ayant reçu une dose de BCG, sa première dose d'Hépatite B et sa première dose de VPO :

- A. est correctement vacciné B-est complètement vacciné
B.n'est ni correctement ni complètement vacciné

Q33.Pour un enfant âgé de 8 mois qui n'a jamais été vacciné, il faut lui administrer en priorité :

- A.Le BCG B-Le Penta C-Le VPO D-le RR

Q34.Parmi les vaccins suivants, identifiez ceux qui constituent une associations combinée d'antigènes

- A. Rotarix B-Td C-RR D-VPO E-PCV13 F-Penta

Q35. Parmi les antigènes suivants du PEV Ivoirien, indiquer les 03 qui sont administrés par voie parentérale :

A. PCV13 B-VPO C-BCG D-Rotarix E-HPV

Q36. Parmi les antigènes suivants, choisir les deux qui sont à série vaccinale dans le PEV Ivoirien :

A. BCG B-PCV13 C-VAA D-Penta

Q37. Chez la femme enceinte la deuxième dose de Td se fait :

A. 6 mois après le Td2 ou au cours de la grossesse suivante

B. 4 semaines après le Td1 C-1 an après le Td3 ou au cours de la grossesse suivante

C. 3 mois après le Td 1

Q38. Le calendrier vaccinal en vigueur en Côte d'Ivoire recommande qu'à l'âge de 10 semaines, l'enfant peut recevoir les antigènes suivants :

A-DTC3-HepB3-Hib3 + VPO3+ Pcv13-3+ VPI+ Rota 3 + FJ

B-DTC2-HepB2-Hib2+ VPO 3+ Pcv13-2 + Rota 2

C-DTC2-HepB2-Hib2+ VPO 2+ Pcv13-2+ Rota2

D-DTC1-HépB1-Hib1 +VPI +Rota 1 +Pcv13-1 +RR

Q39. Les populations cibles du PEV ivoirien sont :

A. Filles de 9 mois, enfants de 0-11 mois et femmes enceintes

B. Enfants de 0-12 mois, Femmes enceintes et jeunes filles de 9 ans

C. Enfants de 0-11 mois ; Femmes enceintes

D. Femmes enceintes, Filles de 9 ans et Enfants de 0-23 mois

Q40. Le PEV signifie :

A. Programme des Enfants Vaccinés B-Protection des Ecoliers Vulnérables

C-Programme Elargi de Vaccination D-Personnes Entretienues par les Vaccins

Q41. Les missions du PEV sont les suivantes :

A. Assurer la protection par la vaccination des enfants, des femmes enceintes et des jeunes filles

B. Assurer la surveillance des malades cibles du PEV

C. Organiser à l'échelle nationale, la vaccination des populations les plus vulnérables

D. Contribuer à l'éradication de la poliomyélite et de l'élimination du tétanos néonatal

Q42. Parmi les vaccins suivants, identifiez ceux qui constituent une associations combinée d'antigènes

A. Rotarix B-Td C-RR D-VPO E-PCV13 F-Penta

Q43. Que signifie le sigle DTCHepB-Hib :

A. Dysenterie-Tétanos-Coqueluche-HépatiteB-Heamophilus Influenzae de type B

B. Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B- Haemophilus Influenzae de type B

C. Drepanosytose -Tétanos-Coqueluche- Hépatite B -Haemophilus Influenzae de type B

Q44.Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :

1.VPO0 2. RR 3.VPI1 4.PCV13-2

A (1,4,3,2) **B (1,3,4,2)** C(1,4,2,3) D (1,3,2,4)

Q45.Combien de doses d'hépatite B doit recevoir un enfant de 23 mois complètement vacciné ?

A-2 doses B-03 doses C-**04 doses**

Q46.Lequel des groupes de tranches d'âge suivantes est conforme à la progression du calendrier de vaccination du PEV ivoirien chez un enfant de 0 à 23 mois ?

A. Naissance, 4 semaines, 10 semaines, 14 semaines, 9 mois

B. Naissance, 6 semaines, 12 semaines, 14 semaines, 9 mois

C.Naissance, 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines, 9 mois

Q47.Parmi les populations suivantes, identifiez celles qui sont des cibles du PEV ivoirien de routine.

A. Femme en âge de reproduction B.Enfant de 0-11 mois **C.Femme enceinte** D.Enfant de 0 à 59 mois **E.Fille de 9 ans**

Q48.Parmi les groupe d'antigènes suivants, lequel doit recevoir un enfant de 10 semaines, conformément au calendrier vaccinal en vigueur en Côte d'Ivoire ?

A.Penta 3 + VPO3+ Pcv13-3+ VPI+ Rota 3 + RR B-B.Penta 2 + VPO 3+ Pcv13-2 + Rota 2

C.Penta 2 + VPO 2+ Pcv13-2+ Rota2 D-D.Penta 3 + VPO3+ Pcv13-3+ VPI+ Rota 3 + VAA

Q49.Combien de doses de l'antigène d'hépatite B reçoit un enfant de 11 mois correctement vacciné ?

A. 1 dose B-3 doses C-**4 doses**

Q50.Un nourrisson présentant une infection à VIH avérée doit recevoir :

A- une dose de RR à 3 mois **B-une dose de RR à 6 mois** C-une dose de RR à 11 mois

D-une dose de RR à 9 mois E-aucune dose de RR **F.une dose à 15 mois**

Q51.Cochez les bonnes correspondances entre les vaccins et le nombre de doses à administrer avant les rappels

A-Meningite A/1 dose B-VAA/2 doses C-VPO/3 doses **D-Td/ 5 doses**

Q52.Identifier parmi les vaccins suivants, (celui) ceux qui (est) sont inactivé (s).

A- VPI B- RR C- Rotarix D- VPO

Q53.Identifier parmi ces vaccins, ceux qui sont injectables

A-Penta B-VPO C-Rotarix **D-PCV-13**

Q54. Un nourrisson présentant une infection à VIH avérée ou présumée et/ou des signes et des symptômes de SIDA doit recevoir le vaccin RR :

A- 6 et 9 mois B- 5 et 9 mois C- 4 et 8 mois D- 6 et 11 mois **E- 6, 9 et 15 mois**

Q55. La voie d'administration du vaccin PCV 13 est :

A- la voie orale B- la voie sous cutané **C- la voie intramusculaire** D- la voie intradermique

Q56. Identifier parmi les maladies suivantes, celles qui ne sont pas encore cibles du PEV ivoirien :

A- La tuberculose osseuse B- Le tétanos néonatal C- La coqueluche D- **L'hépatite A**

Q57. Cochez les réponses correctes en rapport avec le vaccin PCV-13 :

A- il est administré en trois doses B- il est administré en sous-cutané
C- il n'a aucune contre-indication D- **il est conservé entre 2 et 8°C** E- Il est lyophilisé

Q58. Identifier les informations qui sont justes pour le RR :

A- il est inactivé B- il s'administre toujours à l'enfant à partir de 9 mois
C- il provoque des réactions indésirables **D- il s'administre en sous-cutané**

Q59. Parmi les contre-indications vaccinales, indiquez celles qui sont erronées :

A- altération d'état général de l'enfant B- **état de malnutrition de l'enfant**
C- maladie grave nécessitant une hospitalisation D- **prématurité de l'enfant**

Q60. Un enfant âgé de 2 semaines ayant reçu sa dose de BCG, sa première dose d'Hépatite B et sa première dose de VPO :

A- est correctement vacciné B- est complètement vacciné
C- n'est ni correctement ni complètement vacciné

Q61. Un enfant de 4 mois qui n'a pas encore reçu sa 3e dose de Penta :

A- est correctement vacciné B- est complètement vacciné
C- n'est ni correctement ni complètement vacciné

Q62. Identifiez parmi les vaccins suivants, ceux qui sont éligibles au test d'agitation des anatoxines :

A- Penta B- **Td** C- VPO

Q63. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui permettent de monitorer la chaîne du froid au centre de santé :

A- **Les PCV** B- Le thermostat C- **Le thermomètre** D- L'accumulateur

Q64. Pour obtenir constamment du froid dans le réfrigérateur il faut :

A- Installer dans un local frais à une distance de 15 à 30 cm du mur
B- surélever le réfrigérateur sur des cales hautes de 5 mm ;
C- limiter les pertes de froid

Q65. Parmi les vaccins suivants indiquez celui ou ceux qui sont bactériens

A. BCG B-VPO C-VPI D-Penta E-RR F-VAA E-Td

Q66. Parmi les vaccins suivants indiquez ceux qui sont injectables.

A. Penta B-VPO C-Rotarix D-PCV-13

Q67. Parmi Les vaccins suivants indiquez ceux qui peuvent être congelés

A. BCG B-Penta C-VPO D-VPI E-Td

Q68. Cocher les bonnes réponses

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| A. A la 1 ^{ère} CPN | 1 ^{ère} dose de Td |
| B. 2 semaines après le Td1 | 2 ^{ème} dose de Td |
| C. 7 mois après le Td1 | 3 ^{ème} dose de Td |
| D. 1an après le Td3 | 4 ^{ème} dose de Td |
| E. 1an après le Td 3 | 5 ^{ème} dose de Td |

Q69. A quel rythme se fait le relevé de la feuille de température du réfrigérateur dans la gestion des vaccins et consommables ?

A. Bi quotidienne B-Quotidienne C-Hebdomadaire D-Mensuelle

Q70. Quelles sont les cibles complémentaires du PEV Ivoirien ?

A-Les jeunes filles de 9 ans B-Les enfants de 0 à 5 ans
C-Les femmes en âge de reproduction D-Les enfants de 9 mois à 14 ans
E-Les femmes enceintes F-Les enfants de 0 à 23 mois

Q71. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui sont viraux

A-BCG B-VPO C-VPI D-Hépatite B pédiatrique E-Penta F-PCV-13

Q72. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui sont bactériens

A-BCG B-Td C-Méningite A D-VAA

Q73. Parmi les vaccins suivants, indiquez celui qui est une anatoxine

A-VPI B-Td C-RR D-Rota

Q74. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui sont vivants atténués

A-VPI B-BCG C-VPO D-Td

Q75. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui sont inactivés

A-VPO B-VPI C-Penta D-PCV-13 E-BCG F-RR

Q76. Parmi les vaccins suivants, indiquez celui qui est conjugué

A-PCV-13 B-VPO C-Penta

Q77. Parmi les propositions suivantes, indiquez les populations cible de rattrapage

A-Enfants de 9 mois à 14 ans B-Enfant de 12 à 23 mois C-Jeune fille de 10 à 14 ans
D-Femmes en âge de reproduction

Q78. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont des contre-indications définitives

A. Ne pas administrer la 2^e ou la 3^e dose d'un vaccin si la première ou la deuxième a provoqué chez l'enfant des convulsions ou un choc grave

B. Altération de l'état général de l'enfant.

C. En cas de signes ou symptômes avérés de SIDA chez un nourrisson, ne pas administrer le BCG ou le vaccin anti-marijuana

D. Maladie grave nécessitant une hospitalisation

E. Une fièvre de plus de 39°C sauf en cas d'épidémie

Q79. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont des contre-indications temporaires

A. Maladie grave nécessitant une hospitalisation

B. Ne pas administrer la 2^e ou la 3^e dose d'un vaccin si la première ou la deuxième a provoqué chez l'enfant des convulsions ou un choc grave

C. Une fièvre de plus de 39°C sauf en cas d'épidémie

D. En cas de signes ou symptômes avérés de SIDA chez un nourrisson, ne pas administrer le BCG ou le vaccin anti-marijuana

E. Altération de l'état général de l'enfant.

Q80. Le vaccin R21 est un vaccin :

A. Viral, vivant atténué. B. Conjugué. C. Recombiné.

Q81. Le vaccin R21 est présenté sous forme :

A. Liquide B. Lyophilisée C. Sémi-liquide

Q82. Le vaccin R21 est présenté en :

A. Flacon d'une dose B. Flacon de 02 doses C. Flacon de 10 doses D. Flacon de 20 doses

Q83. Un enfant complètement vacciné avec le vaccin R21 reçoit :

A. 02 doses B. 03 doses C. 04 doses

Q84. Pour un enfant correctement et complètement vacciné, indiquez les moments d'administration du vaccin R21 :

A. Naissance B. 6 semaines C. 32 semaines D. 36 semaines

E. 6 mois F. 10 mois G. 15 mois

Q85. Parmi les quantités suivantes, indiquez celle qui correspond à la dose unitaire du vaccin R21

A. 0,05 ml B. 0.5 ml C. 1ml

Q86. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui correspond à la voie d'administration du vaccin R21

A. IM B. SC C. ID

Q87. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui correspond au point d'administration du vaccin R21

A. Cadran supéro-externe de la fesse gauche B. Face antérolatérale de la cuisse droite

B. Face antérolatérale de la cuisse gauche

Q88. Parmi les propositions suivantes, indiquez les trois contre-indications du vaccin R21

A. Hypersensibilité sévère à une dose antérieure du vaccin contre le paludisme

B. Hypersensibilité sévère à une dose antérieure du vaccin contre la rougeole

C. Hypersensibilité sévère à une dose antérieure du vaccin contre la fièvre jaune

D. Hypersensibilité sévère à une dose antérieure du vaccin contre l'hépatite B

E. Hypersensibilité sévère à une dose antérieure du vaccin de la poliomyélite

F. Hypersensibilité sévère à l'un des composants du vaccin

Q89. Parmi les propositions suivantes, indiquez les trois effets secondaires du Matrix R21

A. Fièvre

B. Douleur

C. Eruption cutanée

D. Convulsion

E. Vomissement

F. Diarrhée

Q90. Parmi les propositions suivantes, indiquez les actions à éviter avec le Matrix R21

A. Utiliser les doses restantes d'un flacon, 06 heures après son ouverture

B. Congeler son flacon

C. Jeter les doses restantes d'un flacon, 06 heures après son ouverture

D. Conserver son flacon entre 2 et 7°C

Q91. Parmi les éléments suivants, indiquez celui qui ne constitue pas un constituant de vaccin

A. La bactérie

B. Le virus

C. Le parasite

Q92. Parmi les éléments suivants, indiquez les deux qui sont des ingrédients d'un vaccin

A. La bactérie

B. Le virus

C. L'eau distillée

D. Les antibiotiques

Q93. Le BCG est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

E. Tué

F. Anatoxine

G. Conjugué

F. Recombiné

Q94. Le VPO est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Tué

E. Anatoxine

F. Conjugué

G. Recombiné

Q95. Le VPI est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Inactivé

E. Anatoxine

F. Conjugué

G. Recombiné

Q96. L'Hépatite B pédiatrique est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Inactivé

E. Anatoxine

F. Conjugué

G. Recombiné

Q97. Le RR est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Inactivé

Q98. Le HPV est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Inactivé

Q99. Le Td est un vaccin :

A. Anatoxine

B. Conjugué

C. Recombinée

Q100. La méningite A est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Inactivé

E. Anatoxine

F. Conjugué

G. Recombiné

Q101. Le VAA est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Inactivé

E. Anatoxine

F. Conjugué

G. Recombiné

Q102. Le VAA est un vaccin :

A. Viral

B. Bactérien

C. Vivant atténué

D. Inactivé

E. Anatoxine

F. Conjugué

G. Recombiné

Q103. Chez une fille de 9 ans séropositive, le HPV est administré à raison de :

A. 01 dose

B. 02 doses

C. 03 doses

Q104. Chez une fille de 9 ans séronégative, le HPV est administré à raison de :

A. 01 dose

B. 02 doses

C. 03 doses

Q105. Chez une fille de 9 ans séropositive, la 3e dose de HPV est administrée :

- A.1 mois après la 1^{ère} dose B.4 mois après la 1^{ère} dose C.6 mois après la 1^{ère} dose
- Q106.Selon les normes du PEV ivoirien le rattrapage de l'Hépatite B pédiatrique se fait :**
A. Jusqu'à 72 heures de vie B.Jusqu'à 11 mois C.Jusqu'à 23 mois
- Q107.La phase du programme élargi de vaccination (PEV) a démarré à :**
A. Abengourou B.Agboville C.Abidjan
- Q108.Le PEV a couvert l'ensemble du pays en :**
A. 1974 B.1978 C.1986
- Q109.Parmi les services suivants, indiquez celui qui assurait la gestion des activités de vaccination avant 1993**
A. INSP B.INHP C.ICA
- Q110.Indiquez parmi les dates suivantes, celle de la création de la DEPEV**
A. 1974 B.1978 C.1994
- Q111.En quelle année la DEPEV a-t-elle été érigée en DCPEV ?**
A. 1993 B.1994 C.2001
- Q112.Indiquez le nombre de maladies évitées par la vaccination du PEV chez l'enfant de 0 à 23 mois**
A. 11 maladies B.13 maladies C.15 maladies
- Q113.Indiquez le nombre de maladies évitées par la vaccination du PEV chez la femme enceinte**
A. 02 maladies B.03 maladies C.04 maladies
- Q114.Indiquez le nombre de maladies évitées par la vaccination du PEV chez la fille de 9 ans**
A. 01 maladie B.02 maladies C.03 maladies
- Q115.Parmi les maladies suivantes indiquez celle que le PEV ivoirien vise à éradiquer**
A. La poliomyélite B.Le tétanos néonatal C.La rougeole
- Q116.Parmi les maladies suivantes indiquez celles que le PEV ivoirien vise à éliminer**
A. La poliomyélite B.Le tétanos néonatal C.La rougeole D.Fièvre jaune
- Q117.Parmi les maladies suivantes indiquez celle que le PEV ivoirien vise à contrôler**
A. Le tétanos néonatal B.La rougeole C.Fièvre jaune

CHAPITRE 6 : PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Q1.Les centres antituberculeux sont situés au niveau périphérique du versant administratif du PNLT.

B

Q2.Les centres de Diagnostic et de Traitement de la tuberculose sont situés au niveau intermédiaires du versant administratif du PNLT. B

Q3.Les centres antituberculeux sont situés au niveau central du versant administratif du PNLT. B

Q4.Les Centre Antituberculeux sont placés sous la direction d'infirmiers chef de centre. B

Q5.Les laboratoires périphériques du PNLT sont installés dans les centres de diagnostic et de traitement (CDT) des districts sanitaires. A

Q6.Le traitement est aussi appelé traitement TDO. A

Q7.Le tuberculeux peut réaliser le traitement DOTS pendant qu'il est seul dans son environnement.

B

Q8.Le traitement du tuberculeux permet de lutter contre les résistances des bactéries aux antibiotiques. A

Q9.L'approche ENGAGE-TB consiste à mobiliser un vaste ensemble d'acteurs à participer à la lutte contre la tuberculose. A

QCM

Q1.PNLT signifie :

A-Programme National de Lutte contre la Tuberculose

B- Programme National de lutte contre la Tripanosomiase

C-Programme National de Lutte contre les Traumatismes

Q2.Le PNLT a mise en place en :

A-12 Février 1992

B-8 Aout 2001

C-04 Octobre 2007

D-06 Mai 2009

Q3.L'organisation et le fonctionnement du PNLT se font autour de :

A-deux versants

B- trois versants

C- deux niveaux

D- trois niveaux

Q4.Parmi les instituts suivants,identifier celui qui abrite les locaux du centre national de référence de la tuberculose

A-INSP

B-INHP

C- IPCI

D- ICA

E- IPR

Q5.Parmi les objectifs suivants,indiquez ceux qui relèvent du niveau central

A. Augmenter le taux de dépistage à 80% des malades attendus ;

B. Dépister au moins 70% des TPMP+;

C. Améliorer le taux de guérison à 85% des malades

D. Guérir au moins 85% des TPM+ nouvellement dépistée ;

E. Augmenter la couverture du TDO à 100% sur l'ensemble du territoire national ;

F. Réduire le taux de perdu de vue à 0%.

Q6. Parmi les objectifs suivants, indiquez ceux qui relèvent du niveau périphérique

A. Augmenter la couverture du TDO à 100% sur l'ensemble du territoire national

B. Améliorer le taux de guérison à 85% des malades dépistés ;

C. Réduire le taux de perdu de vue à 0%.

D. Dépister au moins 70% des TPMP+

E. Impliquer la communauté dans les activités de lutte contre la tuberculose.

F. Augmenter le taux de dépistage à 80% des malades attendus ;

Q7. le traitement DOTS vise à :

A. Réduire la mortalité de la tuberculose de 95% entre 2015 et 2035

B. Éviter le développement des bactéries multi résistantes aux antibiotiques et dû à des traitements anarchiques

C. Réduire la mortalité de la tuberculose de 90% entre 2015 et 2035

D. Traiter le plus grand nombre de tuberculeux à moindre coût

E. Réduire l'incidence de 90% entre 2015 et 2035

F. Réduire l'incidence de 95% entre 2015 et 2035

Q8. Parmi les éléments suivants, indique le seul qui ne constitue pas une base de la stratégie DOTS

A. Engagement des pouvoirs publics et des communautés dans la lutte contre la tuberculose.

B. Dépistage des cas au cours des examens cliniques

C. Chimiothérapie standardisée, efficace de brève durée au moyen de schémas thérapeutiques de 6-8 mois au minimum pour tous les cas à frottis positif confirmés.

D. Approvisionnement régulier et ininterrompu en tous les antituberculeux essentiels ;

Q9. Parmi les éléments suivants de la stratégie DOTS, indiquez ceux qui sont d'ordre technique :

A. Supervision et formation des personnels de santé. [SEP]

B. Dépistage des cas et diagnostic

C. Observation directe pendant la première phase du traitement (DOT)

D. Approvisionnement fiable en médicaments et produits de diagnostic

E. Enregistrement et notification des progrès et de la guérison.

F. Formulation des politiques

Q10. Parmi les éléments suivants de la stratégie DOTS, indiquez ceux qui sont d'ordre logistique :

A. Chimiothérapie standardisée de courte durée

B. Laboratoires pour l'examen microscopique ;

C. Mobilisation des ressources.

D. Approvisionnement fiable en médicaments et produits de diagnostic

E. Engagement des pouvoirs publics ;

Q11. Parmi les éléments suivants de la stratégie DOTS, indiquez ceux qui sont d'ordre politique :

A- Chimiothérapie standardisée de courte durée

B- Engagement des pouvoirs publics ;

C- Mobilisation des ressources.

D- Supervision et formation des personnels de santé.

Q12. La stratégie permet :

A- De s'assurer de la prise effective des médicaments

B- De garantir les chances de morbidité

C- D'assurer la sélection des bacilles résistants

E- De raccourcir la période de contagiosité

Q13. Parmi les actions suivantes, indiquez ceux qui sont dévolues à l'infirmier, la sage-femme ou au maïeuticien dans la lutte contre la tuberculose

A- Expliquer au malade les interdits alimentaires pendant le traitement

B- Communiquer avec le malade et sa famille

C- Choisir avec le malade le lieu de traitement

D- Les techniques de prévention des escarres

E- Expliquer au malade le plan du traitement

F- La technique de lavage des mains

Q14. Parmi les éléments suivants, ceux sur lesquels repose la communication avec le tuberculeux

A- Le régime alimentaire

B- La contagiosité

C- La gestion des conflits de famille

D- Les résultats de l'analyse

C- Le traitement et le T.D.O.

CHAPITRE 7 : HYGIENE ET ASSAINISSEMENT**QCD**

Q1. Equilibrer la composition chimique de l'eau de consommation est une méthode pour corriger les défauts chimiques de l'eau. A

Q2. L'approvisionnement en eau potable et en eau courante est un critère de salubrité de l'habitat relatif à la protection contre la contagion. A

Q3. L'eau potable est une eau qui ne contient aucun germe pathogène. A

Q4. L'eau souterraine ne contient aucune impureté à cause du pouvoir filtrant du sol. A

Q5. L'ébullition consiste à bouillir l'eau pendant au moins 10 à 15 minutes et à la laisser reposer. A

Q6. L'effondrement est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins de sécurité. A

Q7. L'évacuation des déchets solides et liquides est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins de sécurité. B

Q8. L'incinération est un procédé qui consiste à brûler les ordures ménagères stockées à l'aide d'un incinérateur ou à y mettre le feu dans un endroit choisi à cet effet. A

Q9. La correction des défauts bactériologiques de l'eau consiste à débarrasser l'eau des micro-organismes pathogènes qu'elle peut contenir. A

Q10. La distribution des moustiquaires imprégnées aux populations permet de lutter contre les piqûres des moustiques. B

Q11. La lutte contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins psychologiques. B

Q12. La protection des aliments contre toute souillure est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins physiologiques. B

Q13. Le goût de l'eau est l'un des critères pour le choix d'une source d'approvisionnement en eau potable. B

Q14. Le permanganate est un oxydant énergétique qui détruit les bactéries. A

Q15. Les eaux de lagunes sont des eaux souterraines. B

Q16. Les eaux provenant des marres sont des eaux de surface A

Q17. Les effets du bruit sur la santé peuvent aboutir à des lésions organiques de l'appareil auditif. A

Q18. Les pollutions domestiques sont provoquées par les eaux de ruissellement A

Q19. Les pollutions dues aux eaux de lavage sont des pollutions domestiques. B

Q20. Une surface par individu de 2 à 6 m² permet d'éviter la promiscuité. B

Q21. La javellisation est aussi appelée chloration. A

QCM

Q1. Quelles sont les trois phases d'évacuation des ordures ménagères mettez-vous en œuvre pour l'assainissement du milieu.

A- L'élimination B- Le stockage C- L'incinération D- Le ramassage E- Le compostage F- Le traitement.

Q2. Selon les propositions suivantes, choisissez deux méthodes de lutte contre les moustiques adultes.

A- Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide B- Comblir les flaques d'eau
C- Enlever tous les récipients pouvant contenir de l'eau D- Déposer des grillages aux portes et fenêtres
E- Drainer les endroits où l'eau peut stagner

Q3. Selon les propositions suivantes, choisissez deux méthodes de lutte contre les larves de moustiques ?

A- Réparer les fosses septiques et les caniveaux B- Pulvériser l'intérieur des maisons d'insecticides
C- Eliminer ou réduire les gîtes de reproduction D- Porter des vêtements longs et clairs à la tombée de la nuit
E- Utiliser des crèmes anti-moustiques

Q4. Quelles sont les deux méthodes de lutte contre les rongeurs

A- Méthodes de lutte défensive B- Méthodes de lutte biologique C- Méthodes de lutte offensive
D- Méthode de lutte mécanique

Q5. Identifiez parmi ces maladies hydriques, celles qui sont bactériennes :

A- Dysenterie bacillaire B- dysenterie amibienne B- Choléra C- Poliomyélite
D- Fièvre typhoïdes E- Fièvres paratyphoïdes

Q6. Identifiez parmi ces maladies hydriques, celles qui sont parasitaires :

A- dysentérie amibienne B- Poliomyélite C- helminthiases D- hépatites virales
E- schistosomiasis F- choléra

Q7. Identifiez parmi ces maladies hydriques, celles qui sont virales :

A- dysentérie bacillaire B- fièvres typhoïdes C- Poliomyélite D- schistosomiasis

Q8. Une eau dure contient:

A- un excès de magnésium B- un excès de potassium C- un excès de fluor
D- un excès calcaire E- un excès d'iode F- un excès de calcium G- un excès de chlore

Q9. Parmi ces critères de choix d'une source d'approvisionnement en eau potable, l'un est faux.

Lequel ? :

A- sa capacité à produire de l'eau indemne d'impureté

B- sa capacité à produire périodiquement un volume important d'eau ;

C- sa conception peu coûteuse

D- sa capacité à produire une eau immédiatement consommable sans traitement.

Q10. Un puits aménagé doit :

A. être situé au moins à 15 mètres de toute source de contamination

B. avoir au moins 10 mètres de profondeur

C. être placé en aval des sources de contamination en cas de pente

D. être nettoyé

E. régulièrement désinfecté

F. avoir une margelle de 70 centimètres de hauteur

G. être entouré d'une aire cimentée d'un rayon de 2 à 3 mètres.

H. avoir un cuvelage d'une hauteur minimale de 3 mètres avec les meilleurs matériaux possibles

I. avoir une clôture d'au moins 100 mètres de rayon

J. être toujours ouvert

K. être muni d'une pompe si possible

Q11. Les actions suivantes permettent de corriger la turbidité de l'eau sauf deux. Lesquelles ?

A- la décantation **B- usage du charbon activé en poudre** B- la filtration

C- la sédimentation D- **la chloration**

Q12. Parmi les actions suivantes, une seule permet d'améliorer la saveur et l'odeur de l'eau.

Laquelle ?

A- l'ébullition **B- usage du charbon de bois** C- la filtration D- la sédimentation

E- l'ionisation

Q13. Les actions suivantes permettent de corriger les défauts bactériologiques de l'eau sauf trois. Lesquelles ?

A- la décantation B- la filtration C- la chloration **D- la sédimentation** E- l'ébullition

F- l'usage du permanganate G- **usage du charbon activé en poudre**

Q14. Identifiez parmi les critères suivants, ceux qui sont relatifs aux besoins physiologiques

A- Une absence d'humidité B- La préservation de l'intimité C- L'existence de confort

D- Une protection suffisante contre les bruits E- **Un espace suffisant pour les jeux des enfants**

F- L'esthétique de l'habitat.

Q15. Identifiez parmi les critères suivants, ceux qui sont relatifs aux besoins physiologiques

A- Une aération et une ventilation suffisante

B- La possibilité d'assurer l'hygiène du logement et la propreté personnelle

C- L'esthétique de l'habitat C- Un ensoleillement adéquat

D- L'approvisionnement en eau potable et en eau courante

E- Une surface par individu de 4 à 6 m² pour éviter la promiscuité.

Q16. Les critères suivants de salubrité de l'habitat sont relatifs aux besoins physiologiques sauf deux. Lesquels ?

A- La possibilité d'assurer l'hygiène du logement et la propreté personnelle

B- Une protection suffisante contre les bruits C- La préservation de l'intimité ;

E- L'esthétique de l'habitat. F- L'approvisionnement en eau potable et en eau courante

G- L'existence de confort

Q17. Identifiez parmi les critères suivants, ceux qui sont relatifs à la protection contre la contagion

A. L'approvisionnement en eau potable et en eau courante ;

B. Les portes et fenêtres doivent être solides pour assurer la protection contre les

C. agressions.

D. Une température adéquate pour assurer le confort (21 à 22°C au niveau des

E. chambres)

F. L'évacuation des déchets solides et liquides (eaux usées) ;

G. La lutte contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles ;

H. La protection des aliments contre toute souillure.

Q18. Parmi les maladies ci-dessous, celles qui ont un lien direct avec la consommation de l'eau non potable sont :

A- le paludisme B- la dysentérie amibienne D- les infections respiratoires aiguës

E- la fièvre typhoïde F- la malnutrition

Q19. Indiquez parmi les actions ci-dessous, celles qui permettent de lutter contre le péril fécal

A- porter des chaussures fermées B- assurer la potabilité de l'eau C- se laver les mains après les repas

D- se laver les mains avant les selles E- protéger les aliments contre les moustiques

F- cuire les aliments G- désinfecter les aliments qui sont à consommer crus

F- traiter les malades atteints de paludisme G- construire des latrines

Q20. Cocher les trois (3) méthodes de désinfection chimique de l'eau à domicile contenues dans cette liste.

A-L'ionisation. B-L'ébullition. C- La javellisation. D- La filtration. E- La décantation.

Q21.Sur la liste ci-dessous, retenir les trois qualités physiques d'une eau potable.

A-Liquide B- Fraiche C- Incolore D- Indolore E- Aérée

Q22.Une décharge communale doit respecter l'une des normes de sécurité suivantes :

A. être située au moins à 20 mètres de tout habitat

B. être située en hauteur des zones d'activités humaines

C. être située au plus à 100 mètres de tout cours d'eau

D. Etre entourée d'une clôture.

Q23.La lutte contre les rongeurs repose sur au moins l'une de ces méthodes, laquelle ?

A-La méthode de lutte défensive B- La méthode de lutte répressive C- La méthode de lutte invasive

Q24.Indiquez parmi les éléments suivants, ceux qui constituent des qualités physiques d'une eau potable :

A-Limpidité B- minéralisation adéquate C- fraîcheur D- absence de germe pathologique.

E-bonne aération

Q25.Les Critères de choix d'une source d'approvisionnement en eau potable sont :

A-sa salubrité B- son irrégularité C- sa conception peu coûteuse

D- sa capacité à produire de l'eau impure F- sa capacité à produire de l'eau consommable après traitement

Q26.Indiquez parmi les actions ci-dessous, celles qui permettent de lutter contre les larves de moustiques :

A.vider et enlever tous les récipients pouvant contenir de l'eau

B.drainer et combler les flaques d'eau et autres endroits où l'eau peut stagner

C.dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide

D.déposer des grillages aux portes et fenêtres de tous les locaux d'habitations

E.pulvériser l'intérieur des maisons d'insecticides

Q27.Indiquez sur la liste proposée le moyen de lutte contre les larves de moustique :

A. dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticide

B. porter des vêtements longs et sombres à la tombée de la nuit ;

C. utiliser des crèmes antipaludiques.

D. Drainer et combler les flaques d'eau et autres endroits où l'eau peut stagner ;

Q28.Indiquez dans la liste proposée, les maladies bactériennes liées à l'eau

A-Le goitre endémique B- La dysenterie bacillaire, C- Le choléra

D- La fièvre jaune E- Les vers intestinaux F- La dysenterie amibienne

Q29.Indiquez dans la liste proposée, les maladies parasitaires liées à l'eau :

A-la dysenterie bacillaire B-la poliomyélite C- les helminthiases,

D- les schistosomiasés E- la fièvre typhoïde

Q30.Les moyens de lutte contre le péril fécal sont :

A-Ne pas utiliser d'engrais dans l'agriculture B- protéger les aliments contre les mouches

C-désinfecter les aliments à consommer crus D- construire des latrines.

E-traiter les malades atteints de gastro-entérites F- Pratiquer régulièrement des activités physiques

CHAPITRE 8 : SOINS DE SANTE PRIMAIRES**QCD**

Q1.En Côte d'Ivoire la politique des soins de santé primaires comprend deux composantes promotionnelles. B

Q2.En Côte d'Ivoire la politique des soins de santé primaires comprend trois composantes préventives et deux composantes promotionnelles. B

Q3.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes curatives. A

Q4.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend huit composantes essentielles. A

Q5.La mise en œuvre effective de la politique des soins de santé primaires en Côte d'Ivoire a débuté en 1993. A

Q6.La participation active des populations aux activités du centre de santé est une recommandation de l'initiative de Bamako. A

Q7.La pyramide sanitaire ivoirienne comporte un versant de prestation de services composé des CSU, du CHR et des instituts spécialisés. B

Q8.La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de bas en haut, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central. A

Q9.La pyramide sanitaire ivoirienne comprend trois versants. B

Q10.La vaccination contre les endémies locales est une composante essentielle des soins de santé primaires. B

Q11.Le CHR peut être considéré comme un ESPC. B

Q12.Le district sanitaire est situé au niveau secondaire de la pyramide sanitaire ivoirienne. B

Q13.Le niveau de mise en œuvre des soins de santé primaires est aussi appelé niveau primaire. A

Q14.Le niveau de mise en œuvre des soins de santé primaires est aussi appelé périphérique. A

Q15.La conférence du 6 au 12 septembre 1978 au cours de laquelle la politique des SSP a été définie par l'OMS a eu lieu à ATA-ALMA en ex URSS. B

Q16.L'hôpital général est l'une des structures prestataires du niveau périphérique de la pyramide sanitaire ivoirienne. B

Q17.L'objectif de la santé pour tous avant l'an 2000 a été défini par l'assemblée mondiale de la Santé en 1977. B

Q18.La gestion du niveau primaire est assurée par le Directeur départemental de la santé. A

Q19.La mise en œuvre de la politique des SSP en Côte d'Ivoire est axée en partie sur la participation communautaire. A

Q20.La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central. B

Q21.La vaccination contre les maladies infectieuses est une composante essentielle des SSP. B

Q22.Le début effectif de la mise en œuvre des activités des soins de santé primaires en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1991 au district sanitaire de Bouaflé. B

Q23.Le lancement officiel de la mise en œuvre des soins de santé primaires en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1993. B

Q24.Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles est une composante essentielle des SSP. A

QCM

Q1.En Côte d'Ivoire le gouvernement a adopté la stratégie des soins de santé primaires en :

A-1981 B-1991 C-1993 D-1994

Q2.En Côte d'Ivoire les districts sanitaires ont remplacé les bases de secteur de santé en :

A-1981 B-1991 C-1993 D-1994

Q3.En Côte d'Ivoire la pyramide sanitaire a été élaborée en :

A-1995 B-1996 C-2000 D-2002

Q4.Parmi les composantes essentielles des soins de santé primaire ci-dessous, cochez celles qui sont justes.

A. Vaccination contre les maladies courantes B-Fourniture en médicaments essentiels

C-Promotion de bonnes conditions d'hygiène alimentaire.

D-Prévention et lutte contre les endémies locales

Q5.La pyramide sanitaire de la Côte d'Ivoire comporte :

A-06 niveaux. B-04 niveaux. C-03 niveaux. D-05 niveaux.

Q6.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend :

A-deux composantes curatives B- deux composantes préventives et trois composantes curatives

C-deux composantes préventives et trois composantes promotionnelles

D- trois composantes préventives et deux composantes promotionnelles

E-trois composantes préventives et trois composantes promotionnelles

Q7.Parmi les établissements sanitaires suivants cochez ceux qui se trouvent au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire.

A-CSR B- EPHR C- CSU D- Direction Régionale E-District sanitaire

Q8.Dans le système national de santé, les soins de santé primaire se situent

A-Au niveau tertiaire du système de santé B- Au niveau intermédiaire du système de santé

C-Au niveau primaire du système de santé D- A tous les niveaux du système de santé

Q9. Dans quelle pays, la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie pour la première fois?

A-Italie B- **URSS** C- Suisse. D- Mali E- Zambie

Q10. Le contenu de l'initiative de Bamako préconise entre autres :

A- **un accès prioritaire des femmes et des enfants aux soins de santé**

B- **une autonomie de gestion au niveau local à travers les comités de gestion**

C- une interdiction des médicaments génériques dans les structures de santé

D- une définition des niveaux d'application des soins de santé primaires

Q11. Les trois niveaux d'applications de la stratégie des SSP ont été identifiés en :

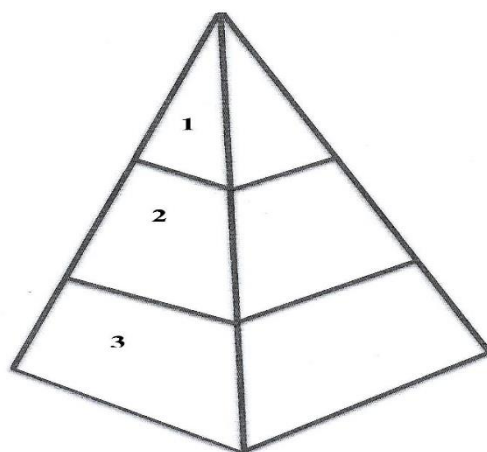
A-1978 B-1987 C-1991 D- **1985**

Q12. L'initiative de Bamako a été lancée en :

A-1987 B-1985 C-1978 D-1977

Q13. Le nombre des composantes essentielles des SSP est de :

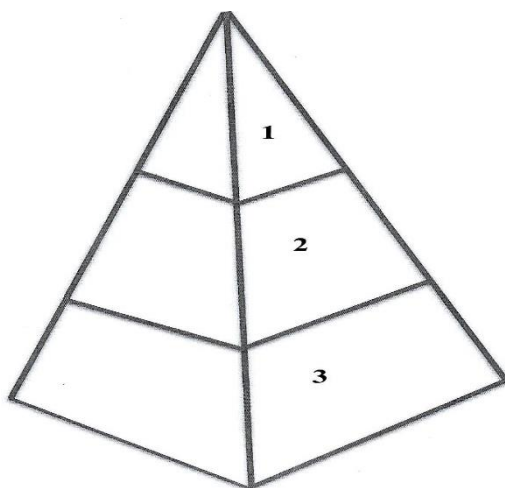
A-12 composantes. B-06composantes **C-08composantes.** D-10 composantes



Q14. A partir du schéma ci-dessus, faites correspondre les nombres avec les propositions de d'indications

1	a-District sanitaire
2	b-DR
3	c-MSHPCMU

A (1,b) **C (1,c)** **D(3,a)** E (3,c,d) **B (2,b)**



Q15.A partir du schéma ci-dessus, faites correspondre les nombres avec les propositions de d'indications

1
2
3

a- EPHR
b-EHPN
c- ESPC
d-EPHD
e- Instituts spécialisés

A (1,b,e) B (2,e,a) **C (2,a,d)** **D(3,c)** E.(1,c,d)

CHAPITRE 9 : GENERALITES SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE**QCD**

- Q1. Dans l'élimination d'une maladie, le nombre de cas est supprimé mais l'agent pathogène n'est pas entièrement éliminé dans l'environnement A
- Q2. Dans l'éradication d'une maladie, celle-ci et le germe en cause sont supprimés de la nature. A
- Q3. Épidémiologie analytique répond à la question pourquoi ? A
- Q4. Épidémiologie analytique répond aux questions : Combien ? B
- Q5. L'épidémiologie est une science qui s'intéresse à un individu et non un groupe d'individus B
- Q6. La définition de cas clinique est un de critères qui permettent de préciser les maladies qui doivent être notifiées pour la surveillance. B
- Q7. La finalité thérapeutique dans l'approche épidémiologique est la guérison du malade. B
- Q8. La notification de cas est le fait de donner l'alerte à l'autorité en vue de la riposte à une épidémie. B
- Q9. La proportion est un rapport dont le dénominateur est inclus dans le numérateur. B
- Q10. La riposte est un ensemble d'actions mises en œuvre pour résoudre un problème ou modifier une situation satisfaisante. B
- Q11. Le ratio est un rapport pour lequel le numérateur peut être supérieur au dénominateur. A
- Q12. Le ratio est un rapport qui ne comporte pas d'unité. A
- Q13. Le sujet d'intérêt en épidémiologie est le malade. B
- Q14. Une endémie est une apparition soudaine, inattendue ou brusque d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné. B

QCM**Q1. Parmi les actions suivantes, indiquez celle qui relève de l'épidémiologie descriptive**

A-Evaluer l'impact des interventions B-Expliquer l'état de santé

C-Décrire l'état de santé d'une population

Q2. Parmi les actions suivantes, indiquez celle qui relève de l'épidémiologie d'intervention

A-Evaluer l'impact des actions B-Expliquer l'état de santé

C-Décrire l'état de santé d'une population

Q3. Parmi les actions suivantes, indiquez celle qui relève de l'épidémiologie analytique

A-Evaluer l'impact des actions **B-Expliquer l'état de santé**

C-Décrire l'état de santé d'une population

Q4. Parmi les questions suivantes, indiquez celles qui relèvent de l'épidémiologie descriptive

A-Quelle est la cause ? B-Quand ? C- Où ? D- Qui ? E- Combien ? D- Pourquoi ?

Q5. Parmi les questions suivantes, indiquez celles qui relèvent de l'épidémiologie analytique

A-Quelle est la cause ? B-Quand ? C-Où ? D-Qui ? E-Combien ? F- Pourquoi ?

Q6. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui relèvent de l'approche épidémiologique de résolution des problèmes de santé

A-Vérifie la disparition des signes cliniques B- Analyse l'impact des interventions

C-Intervient pour guérir le malade D- A pour diagnostic la détermination du sujet d'intérêt clinique

E-Recherche les causes d'apparition de la maladie et de sa propagation dans la population

F-A pour sujet d'intérêt la maladie

Q7. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui relèvent de l'approche clinique de résolution des problèmes de santé

A-Analyse l'impact des interventions B-Recherche les causes d'apparition de la maladie chez le sujet

C-A pour diagnostic l'identification d'un phénomène de groupe important

D-A pour thérapie le contrôle, l'éradication, l'élimination et la maîtrise de la maladie

E-A pour sujet d'intérêt, le malade

Q8. Quel est l'ordre normal des classifications de cas suivants en vue d'un diagnostic ?

1.cas confirmé.

2.cas probables

3.cas suspects

A (1,2,3) B (2,3,1) C (3,2,1)

Q9. Une endémie est un phénomène

A-Limité dans le temps et limité dans l'espace B- Illimité dans le temps et illimité dans l'espace

C-Limité dans le temps et illimité dans l'espace D- illimité dans le temps et limité dans l'espace

Q10. Une pandémie est un phénomène

A-Limité dans le temps et limité dans l'espace B- Illimité dans le temps et limité dans l'espace

C-Limité dans le temps et illimité dans l'espace D- Illimité dans le temps et illimité dans l'espace

Q11. L'éradication d'une maladie représente :

A. L'ensemble des mesures visant à la réduction durable du nombre de nouveaux cas d'une maladie.

B. L'ensemble des mesures visant à l'élimination totale de la maladie et de son germe

C. L'ensemble des mesures visant à la réduction durable du nombre de nouveaux cas, sans pour autant éradiquer la maladie.

Q12. Dans l'approche épidémiologique des problèmes de santé, l'une des approches suivantes n'est pas juste.

A-Contrôle B- Éradication C- Élimination D- Guérison du malade

Q13. L'épidémie est un phénomène de masse

A- Limité dans le temps ou dans l'espace B- Limité dans le temps et/ou dans l'espace

C- Limité dans le temps et dans l'espace D- Limité dans le temps et illimité dans l'espace

CHAPITRE 10 : LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL CCSC**QCD**

- Q1. Dans le processus de CCC, la segmentation consiste à découper un public cible donné en groupes homogènes afin de leur adresser des messages spécifiques et adaptés. A
- Q2. La modification du comportement humain suit généralement un processus progressif. A
- Q3. Le but principal et final de la Communication pour le changement de comportement est le changement d'attitude et de comportement. A
- Q4. Améliorer le bien être de l'individu est un but de l'IEC/CCC. A
- Q5. Améliorer le bien être de la communauté est un but de l'IEC/CCC. A
- Q6. Améliorer le bien être de la société est un but de l'IEC/CCC. A
- Q7. Dans le changement de comportement, les croyances correspondent à un élément de connaissance descriptive qu'un individu entretient à l'égard d'un objet. A
- Q8. Définir et exprimer ses besoins et objectifs du groupe cible, en prenant des mesures collectives visant à les satisfaire est un but de l'IEC/CCC. B
- Q9. Eduquer consiste à collecter, traiter et diffuser des informations. B
- Q10. Eduquer consiste à communiquer pour faire adopter les bonnes attitudes. A
- Q11. Influencer le changement politique est un but du plaidoyer. A
- Q12. L'agent de santé est le responsable de l'action d'IEC/CCC. A
- Q13. L'agent de santé est le responsable de l'action de mobilisation sociale. A
- Q14. L'approche psychosociologique à l'identification d'un problème de santé fournit des données quantitatives. B
- Q15. L'individu constitue une cible de la mobilisation communautaire. B
- Q16. L'individu constitue une cible du plaidoyer. B
- Q17. L'ONG de santé est le responsable de l'action d'IEC/CCC. A
- Q18. L'ONG de santé est le responsable de l'action de mobilisation sociale. B
- Q19. La communauté constitue une cible de l'IEC/CCC. A
- Q20. La communauté constitue une cible de la mobilisation sociale. B
- Q21. La communauté est le responsable de l'action d'IEC/CCC. B
- Q22. La communauté est le responsable de l'action de mobilisation sociale. A
- Q23. La communication pour le changement de comportement est un processus statique, à double voie.

Q24. B

Q25. La culture est un facteur externe pouvant influencer le changement social de comportement. A

Q26. La culture et le milieu social sont des facteurs internes qui influencent le comportement. B

Q27. La mauvaise perception du message est un obstacle lié à l'émetteur dans un processus de communication. B

QCM

Q1.Informer consiste à :

A-Communiquer pour convaincre B-Collecter, traiter et diffuser les nouvelles

C-Communiquer pour faire adopter les bonnes attitudes

Q2.Eduquer consiste à :

A-Communiquer pour convaincre B- Collecter, traiter et diffuser les nouvelles

C-Communiquer pour faire adopter les bonnes attitudes

Q3.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont les cibles de l'IEC/CCC

A-Décideurs politiques B-Individu C- Communauté D- La société civile

E- Groupe cible de la population

Q4.Parmi les éléments suivants, indiquez celui qui constitue la cible du plaidoyer

A-Décideurs politiques B- Individu C-Communauté D-La société civile

E-Groupe cible de la population

Q5.Parmi les éléments suivants, indiquez celui qui constitue la cible de la mobilisation sociale

A-Décideurs politiques B-Individu C-Communauté D- La société civile

E-Groupe cible de la population

Q6.Parmi les éléments suivants, indiquez celui qui constitue la cible de la mobilisation communautaire

A-Décideurs politiques B- Individu C- Communauté D- La société civile

E-Groupe cible de la population

Q7.Parmi les éléments suivants, indiquez les buts de l'IEC/CCC

A-Réaliser un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous

B-Influencer le changement politique C- Améliorer le bien être de l'individu

D-Améliorer le bien être de la société E- Améliorer le bien être de la communauté

Q8.Parmi les éléments suivants, indiquez le but du plaidoyer

A-Réaliser un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous

B-Influencer le changement politique C- Améliorer le bien être de l'individu

D-Améliorer le bien être de la société E- Améliorer le bien être de la communauté

Q9. Parmi les éléments suivants, indiquez le but de la mobilisation sociale

A. Réaliser un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous

A- Influencer le changement politique B- Améliorer le bien être de l'individu

C- Améliorer le bien être de la société D- Améliorer le bien être de la communauté

Q10. Parmi les éléments suivants, indiquez le responsable de l'action d'IEC/CCC

A- Agent de santé

B- ONG de santé

C- Communauté

D- Société

Q11. Parmi les éléments suivants, indiquez le responsable de l'action de plaidoyer

A- Agent de santé

B- ONG de santé

C- Communauté

D- Société

Q12. Parmi les éléments suivants, indiquez le responsable de l'action de mobilisation sociale

A- Agent de santé

B- ONG de santé

C- **Communauté**

D- **Société**

Q13. Parmi les éléments suivants, indiquez le responsable de l'action de mobilisation communautaire

A- Agent de santé

B- Communauté

D- ONG de santé

E- Société

Q14. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des obstacles liés à l'émetteur dans un processus de communication

A- Refus de message

B- Non maîtrise du sujet

C- Mauvais accueil

D- **Non-respect des autres**

E- Mauvaise perception du message F- Message confus et imprécis

Q15. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des obstacles liés au récepteur dans un processus de communication

A- Refus de message

B- Non maîtrise du sujet

C- Message compliqué

D- **Méfiance**

E- Mauvaise perception du message

F- Mauvais accueil

Q16. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des facteurs internes pouvant influencer le changement social de comportement

A- La culture

B- Les connaissances

C- La perception

D- Les croyances

E- Les attitudes

F- Le milieu social

Q17. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des facteurs externes pouvant influencer le changement social de comportement

A- La culture

B- Les connaissances

C- La perception

D- Les croyances

E- Les attitudes

F- **Le milieu social**

CHAPITRE 11 : INDICATEURS DE SANTE**QCD**

- Q1. Dans le contrôle de la maladie, le risque de la recontamination existe. A
- Q2. L'accroissement naturel tient compte des phénomènes migratoires . B
- Q3. L'incidence et la prévalence permettent de déterminer l'ampleur du maladie dans une localité donnée. A
- Q4. L'indice est un rapport qu'on utilise lorsque le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur. A
- Q5. La finalité thérapeutique dans l'approche clinique des problèmes de santé est la guérison du malade. A
- Q6. La létalité permet d'apprécier l'ampleur d'une maladie. B
- Q7. La létalité est le nombre de décès parmi les malades. A
- Q8. La létalité permet de déterminer la gravité de la maladie dans une localité donnée. A
- Q9. La mortalité juvénile est le décès qui survient entre 0 et 4 ans. B
- Q10. La prévalence indique la gravité d'un problème. B
- Q11. La prévalence indique l'ampleur d'un problème. A
- Q12. Le but de la surveillance épidémiologique est de prévenir l'apparition de nouveaux phénomènes de masse. A
- Q13. Le ratio est un rapport dans lequel le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur. A
- Q14. Le ratio est un rapport qui ne comporte pas d'unité. A
- Q15. Le taux d'incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie enregistré dans une zone donnée au cours d'une période d'observation considérée. B
- Q16. Le taux d'incidence permet d'évaluer la qualité de la prévention d'une maladie. A
- Q17. Le taux d'incidence permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades. B
- Q18. Le taux d'incidence permet de mesurer la vitesse de propagation de la maladie. A
- Q19. Le taux de létalité permet d'évaluer la gravité de la maladie. A
- Q20. Le taux de létalité permet d'évaluer la prévention d'une maladie. B
- Q21. Le taux de létalité permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades. A
- Q22. Les décès influencent l'accroissement naturel. A
- Q23. L'accroissement naturel d'une population prend en compte les naissances et les décès survenus dans la population ainsi l'immigration et l'émigration. B
- Q24. L'épidémiologie s'intéresse à un groupe de personne et non à une seule personne. A

Q25. Un accouchement est dit assisté lorsqu'il est effectué par une personne qualifiée ou un tradipraticien. B

QCM

Q1. Parmi les indicateurs suivants, indiquez ceux qui sont à tendance positive

A- le taux de mortalité B- le taux de natalité C- le taux général de fécondité

D- le taux de morbidité

Q2. Parmi les indicateurs de santé suivants, indiquez ceux qui sont à tendance négative

A- le taux de prévalence B- le taux de natalité C- le taux de fécondité

D- le taux de morbidité E- le taux de létalité F- le taux de guérison

Q3. Cocher l'indicateur de santé à tendance négative dans cette liste :

A- Taux Brut de Natalité B- Taux d'accouchement assisté C- Taux de prévalence

D- Taux Général de Fécondité

Q4. Lesquels des indicateurs ci-après sont des indicateurs de santé à tendance positive.

A- l'accroissement naturel B- le taux brut de létalité C- le taux brut de mortalité

D- le taux général de fécondité.

Q5. Dans l'approche épidémiologique des problèmes de santé, l'une des approches suivantes n'est pas juste.

A- Contrôle B- Éradication C- Élimination D- Guérison du malade

Q6. Le taux de mortalité maternelle (T.M.M.) se calcule avec comme dénominateur :

A- le total des parturientes de l'année B- le total des femmes en âge de reproduction de l'année

C- le total des décès maternel de l'année D- le total des naissances vivantes de l'année

Q7. Le taux de mortalité néonatal tardif concerne :

A- Les décès d'enfants de 0 à moins de 08 jours B- Les décès d'enfants de 08 à moins de 28 jours

C- Les décès d'enfants de 28 jours à moins d'un an.

Q8. Le taux de mortalité néonatale tardif concerne :

A- Les décès d'enfants de 0 à moins de 08 jours B- Les décès d'enfants de 08 à moins de 28 jours

C- Les décès d'enfants de 28 jours à moins d'un an.

CHAPITRE 9 : GESTION DES VACCINS

Un enfant âgé de 2 semaines ayant déjà reçu le VPO0, le BCG et sa dose d'hépatite B à la naissance est correctement vacciné. A

Q1.Un enfant correctement vacciné est celui qui reçoit toutes les doses de vaccins inscrites dans le programme élargi de vaccination. B

Q2.Un enfant de 8 mois ayant reçu toutes ses doses de vaccins à l'exception des doses de RR1 et du VAA et du Men A est correctement vacciné. A

Q3.Un vaccin dont la PCV à virée et qui ne peut plus être utilisé est un vaccin sacrifié F

Q4.Au cours de la gestion des vaccins, la règle PEPU permet d'éviter les doses gaspillées. A

Q5.Des doses perdues à cause de non qualification du vaccinateur sont des doses sacrifiées. B

Q6.En cas de perte de doses au cours de la vaccination, le nombre de doses de vaccins utilisées est généralement supérieur au nombre de personnes vaccinées. A

Q7.En Côte d'Ivoire les populations cibles des campagnes de VPO, de Td et de RR sont respectivement les enfants de 0 à 59 mois, les femmes enceintes et les enfants de 9 mois à 14 ans. B

Q8.En Côte d'Ivoire les populations cibles du PEV d'un même antigène sont les mêmes selon qu'on soit en vaccination de routine ou en campagne de vaccination. B

Q9.En Côte d'Ivoire, l'objectif vaccinal est identique en vaccination de campagne pour tous les vaccins. A

Q10.Faire la vaccination en stratégie avancée est une solution pour réduire les populations hors de portée. B

Q11.La couverture vaccinale est la proportion de la population cible ayant reçu le nombre de doses requis de chaque antigène conformément au calendrier PEV. A

Q12.La PCV est un cercle sensible à la chaleur placé à l'intérieur d'un carré qui change de couleur sous l'influence combinée de la chaleur et du froid. B

Q13.La PCV permet de vérifier la péremption du vaccin. B

Q14.La politique des flacons entamés s'applique à tous les vaccins du PEV. B

Q15.La Politique du flacon entamé consiste à réutiliser un flacon de vaccin ouvert et duquel l'on a prélevé une ou plusieurs doses de vaccins pour la prochaine séance de vaccination jusqu'à 4 semaines minimum. B

Q16.La politique du flacon entamé ne s'applique qu'aux vaccins multidoses liquides et aux vaccins en poudre. B

Q17.La quantité à commander est souvent égale au besoin réel. A

Q18.La sortie des vaccins du réfrigérateur se fait en fonction de la date de péremption et de la date de réception. B

Q19.Le besoin théorique des vaccins représente 25% du stock de sécurité.B

Q20.Le calcul du stock de sécurité dans l'estimation des besoins en vaccins et consommable se fait avec 25% pour les consommables et 10% pour les vaccins. B

Q21.Le facteur de perte se calcule à partir du taux de perte ou du taux d'utilisation. A

Q22. Le nombre de contact vaccinal se détermine à partir du calendrier de vaccination en vigueur du PEV. A

Q23.Le nombre de contacts vaccinaux annuels qu'il faut pour un sujet cible varie d'un vaccin à un autre. A

Q24.Le nombre de seringues de dilution correspond au nombre de flacons de vaccins liquides à utiliser. B

Q25.Le taux de couverture vaccinal global est l'effectif de la population cible correctement vacciné. B

Q26.Les doses perdues ne doivent pas être prises en compte dans l'estimation des besoins en vaccins. B

Q27.Les occasions manquées de vaccination constituent une des causes des abandons vaccinaux, B

Q28.Les règles PEPU et PPPS de gestion des vaccins sont identiques. A

Q29.Plus le taux de perte est élevé, moins le facteur de perte est élevé. B

Q30.Un abandon vaccinal est toute cible qui, n'ayant jamais reçu de dose d'un vaccin donné refuse de poursuivre son calendrier de vaccination jusqu'à la fin. B

Q31.Un cas d'abandon vaccinal est toute cible venue dans la structure sanitaire pour toute autre raison que la vaccination et qui sort de la structure sans être vaccinée. B

Q32.Une population ayant accès aux services de vaccination mais qui ne les utilisent pas pour des raisons d'ordres religieux est dite hors d'accès. B

QCM**Q1.Le taux d'abandon du Penta varie:**

A.en fonction du nombre de premières doses administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de deuxièmes doses administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de premières doses et de deuxièmes doses administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de troisièmes doses administrées à la population cible

Q2.Parmi les vaccins suivants, deux sont sensibles à la congélation. Lesquels ?

A-VPI B- VAA C- RR D- Td E- VPO

Q3.Identifiez les vaccins du PEV auxquels s'applique la politique du flacon entamé

A-VPO B- RR C- BCG D- Td E- Penta F- VAA

Q4.Parmi les vaccins liquides suivants, indiquez celui qui n'est pas éligible à la politique du flacon entamé

A. VPO B.Penta C.R21

Q5.Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de Td il réunir au moins :

A.16 femmes B.18 femmes C.15 femmes D.1 femme

Q6.Identifiez parmi les vaccins suivants, ceux qui sont inéligibles au test d'agitation des anatoxines :

A-Penta B-VPO C-RR D-Td E-VPI

Q7.Un flacon de vaccin liquide déjà ouvert est réutilisable à condition :

A.qu'il ne soit pas périmé B.ait été contaminé

C.n'ait pas été exposé excessivement au froid ou à la chaleur excessive ;

D.ait été immergés dans de l'eau E.ne présente aucun trouble ou précipitation

F.ait sa PCV virée.

Q8.Un flacon de vaccin liquide déjà ouvert n'est plus utilisable :

A.lorsqu'il n'est pas périmé B.lorsqu'il a été contaminé

C.lorsqu'il a été exposé excessivement au froid ou à la chaleur excessive ;

D.lorsqu'il n'a pas été immergé dans de l'eau E.lorsqu'il présente un trouble ou précipitation ;

F. lorsqu'il n'a pas de PCV viré.

Q9.Identifiez les vaccins qui ne peuvent pas être conservés pendant plus de 6 heures après l'ouverture du flacon :

A. VAA B.Td C.BCG D.RR E. VPO

Q10.Identifiez parmi les éléments suivants, ceux qui sont des causes de faibles taux de couverture :

A.la stratégie mobile B.les occasions manquées de vaccination

C. les abandons vaccinaux D.la recherche active des cible

Q11. Parmi ces éléments, identifiez ceux qui constituent des causes d'abandon vaccinal

A. la stratégie avancée B. insuffisance de CCC C. le bon accueil

D. la longue attente sur les lieux de vaccination

E. la maîtrise des techniques vaccinales par le personnel de santé

Q12. Parmi ces éléments, identifiez ceux qui constituent des solutions aux abandons vaccinaux

A. allonger le temps d'attente des mères sur les lieux de vaccination

B. rechercher activement les cibles non vaccinées

C. planifier les séances de vaccination adaptée aux activités socioculturelles des populations

D. accentuer le mauvais accueil E. réduire les séances de CCC sur les activités de vaccination

Q13. Parmi les mesures suivantes, indiquez celles permettant de réduire les populations hors de portée:

A. Intensifier la sensibilisation

B. pratiquer la stratégie avancée

C. résoudre les conflits

D. promouvoir progressivement les considérations socioculturelles.

E. pratiquer la vaccination par la stratégie du porte à porte

Q14. Parmi les facteurs suivants, identifier ceux qui sont évitables :

A. Mauvaise gestion des stocks entraînant un approvisionnement excédentaire et la péremption des vaccins avant leur utilisation.

B. L'utilisation d'autres vaccins dans lesquelles les conditions d'application de la politique d'utilisation des flacons multidoses entamés ne peuvent être réunies.

C. Défaillance de la chaîne de froid exposant ainsi les vaccins à des températures extrêmement inacceptables (trop élevées ou trop basses).

D. Vaccins reconstitués qui doivent être jetés à la fin de la séance.

Q15. Parmi les facteurs suivants, identifier ceux qui sont évitables :

A. Administration des doses incorrectes

B. Vaccins reconstitués qui doivent être jetés à la fin de la séance.

C. Non respect de la politique du flacon entamé

Q16. Parmi les facteurs suivants, identifier ceux qui sont évitables :

A. Perte des vaccins

B. Non respect de la politique du flacon entamé

C. L'utilisation d'autres vaccins dans lesquelles les conditions d'application de la politique d'utilisation des flacons multidoses entamés ne peuvent être réunies.

D. Vaccins reconstitués qui doivent être jetés à la fin de la séance.

Q17. Parmi les doses perdues suivantes, identifier celles qui constituent des doses sacrifiées.

A. Les doses administrées à des populations hors cibles B. date de péremption passée, casses, vols etc.

C. détérioration due à la congélation D. doses jetées avec les flacons de vaccins reconstitués

Q18. Quel est l'ordre des étapes à parcourir pour commander des vaccins

1. stock de sécurité
 2. besoin réel
 3. besoin théorique
 4. quantité à commander
 5. quantité en stock
- A. (1,2,3,4,5)
B. (5,3,4,2,1)
C. (3,1,2,5,4)
D. (4,5,2,1,3)

Q19. Parmi les vaccins suivants, identifiés ceux qui sont lyophilisés :

- A. BCG** B. PCV-13 C. VPI **D. RR** **E. VAA** F. Rota G. Penta

Q20. Les éléments suivants sont à vérifier à la réception d'un stock de vaccins et de diluants sauf deux :

- A. le remplissage correcte des bordereaux de livraison
B. l'heure d'arrivée des colis au centre de santé
C. la présence des bordereaux de livraison
D. le destinataire des colis
E. la date de fabrication du vaccin

Q21. Les éléments suivants sont à vérifier à la réception d'un stock de vaccins et de diluants sauf un :

- A. l'aspect extérieur des colis
B. la conformité du contenu des colis au bordereau de livraison
C. le nombre d'accumulateurs utilisés pour assurer la chaîne du froid pendant le transport
D. la conformité entre les vaccins et les diluants

Q22. Parmi les vaccins suivants, identifier ceux qui sont sensibles à la lumière

- A. BCG **B. Td** **C. RR** D. VPI E. VPO

Q23. Parmi les vaccins suivants, identifier ceux qui sont sensibles à la congélation

- A. BCG **B. Td** C. RR **D. VPI** E. VPO

Q24. Parmi les vaccins suivants, identifier ceux qui sont sensibles à la congélation

- A. Penta** **B. PCV-13** **C. Rotarix** D. VPO E. BCG F. VAA

Q25. Dans un réfrigérateur horizontal, les vaccins suivants doivent être rangés au sommet sauf deux, lesquels:

- A. Penta **B. RR** **C. VPO** D. Td E. VPI

Q26. Parmi les éléments suivants, indiquez celles qui permettent de réduire les pertes de vaccins :

- A. les MAPI
B. le relevé biquotidien de la température du réfrigérateur

C. la politique du flacon entamé D. les occasions manquées E. la PCV F. les abandons vaccinaux

Q27. Un vaccin ayant une PVC ne peut être utilisé lorsque :

- A. Si le carré intérieur est plus sombre que le cercle extérieur.
- B. le carré intérieur est plus clair que le cercle extérieur
- C. le carré intérieur s'obscurcit, mais est toujours plus clair que le cercle extérieur
- D. le carré intérieur prend la même couleur que le cercle extérieur
- E. le carré intérieur est moins clair que le cercle extérieur
- F. le carré intérieur est moins sombre que le cercle extérieur.

Q28. Identifier parmi ces éléments, ceux qui peuvent favoriser l'augmentation du taux de couverture vaccinale :

- A. les occasions manquées de vaccination
- B. les stratégies avancées
- C. les populations hors de portée
- D. les populations hors d'accès
- E. la sensibilisation

Q29. Parmi les causes suivantes, indiquer celles qui engendrent les abandons vaccinaux :

- A. Absence ou insuffisance de CCC
- B. Réalisation des stratégies avancées
- C. Mauvais accueil des mères par le personnel
- D. Sensibilisation des populations hors de portée
- E. la longue attente des mères
- F. les occasions manquées de vaccination

Q30. Parmi les raisons suivantes identifier celles qui engendrent les populations hors de portée :

- A. les croyances religieuses
- B. l'éloignement des structures de vaccination
- C. les conflits ethniques
- D. les raisons politiques
- E. les endroits difficiles d'accès

Q31. Parmi les solutions suivantes identifier celles qui permettent de réduire les populations hors de portée

- A. Pratiquer la stratégie avancée
- B. Sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination
- C. Résoudre les conflits interethniques
- D. Pratiquer la stratégie mobile
- E. Faire la vaccination en porte à porte

Q32. Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de VPO il réunir au moins :

- A-15 enfants de 0 à 23 mois
- B-18 enfants de 0 à 23 mois
- C-16 enfants de 0 à 23 mois
- D-01 enfant de 0 à 23 mois

Q33. Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de RR il réunir au moins :

- A-12 enfants de 0 à 23 mois
- B-17 enfants de 0 à 23 mois
- C-16 enfants de 0 à 23 mois

Q34.Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de Td il réunir au moins :

A-16 femmes enceintes B-1 femme enceinte C-15 femmes enceintes

Q35.Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de BCG il faut réunir un minimum de :

A-12 enfants de 0 à 23 mois B-15 enfants de 0 à 11 moins C-18 enfants de 0 à 23 mois

Q36.Selon les normes du PEV, avec un flacon de 20 doses de VPO il faut vacciner au minimum :

A-15 enfants de 0 à 23 mois B-19 enfants de 0 à 23 mois C-16 enfants de 0 à 23 mois
D-18 enfants de 0 à 23 mois

Q37.Quel est l'ordre normal des étapes d'estimation d'une commande de vaccin ?

1. stock de sécurité
2. besoin réel
- 3.besoin théorique
- 4.quantité à commander
- 5.quantité en stock

Identifier la combinaison dont l'ordre des chiffres correspond à la logique des calculs.

A. (1,2,3,4,5) B. (5,3,4,2,1) C. (3,1,2,5,4) D. (3,4,5,2,1,)

Q38.Parmi les règles suivantes de gestion des vaccins en vue de limiter les pertes, une seule est juste. Laquelle ?

A.la règle du PEPI B.la règle de 3PS C.la règle de SPPP

Q39.Parmi les solutions suivantes identifier celles qui permettent de réduire les populations hors d'accès :

A-Pratiquer la stratégie avancée B- Sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination
C-Résoudre les conflits interethniques D- Pratiquer la stratégie mobile
E- Faire la vaccination en porte à porte

Q40.Parmi les solutions suivantes identifier celles qui sont envisageables par le district sanitaire pour augmenter la couverture vaccinale

A-Résoudre les conflits politiques B-Améliorer l'accueil des populations
C-Faire le monitoring des activités de vaccination des centres de santé
D-Renouveler le matériel roulant vétuste E- Faire la vaccination en stratégie avancée
F-Sensibiliser les populations des villages

CHAPITRE 7 : LE DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE

QCD

Q1.L'ampleur d'un problème prioritaire de santé se détermine à partir du nombre de cas de cette maladie. A

Q2.L'approche basée sur la notion épidémiologique du besoin en vue du diagnostic communautaire permet de fournir des données qualitatives. B

Q3.L'approche basée sur la notion épidémiologique du besoin en vue du diagnostic communautaire permet de fournir des données quantitatives. A

Q4.L'approche psychosociologique des besoins en vue du diagnostic communautaire permet de déterminer les perceptions de la population relatives aux problèmes de santé A.

Q5.L'approche psychosociologique des besoins en vue du diagnostic communautaire permet de fournir des données qualitatives. A

Q6.La gravité d'un problème prioritaire de santé peut se déterminer à partir des séquelles de cette maladie. A

Q7.La gravité d'un problème prioritaire de santé peut se déterminer à partir du nombre de décès provoqués par cette maladie. A

Q8.La vulnérabilité d'un problème prioritaire de santé se détermine par l'existence de mesures de contrôle efficaces du problème. B

Q9.Les différends entre les membres d'une communauté ne constituent pas un obstacle à la participation communautaire. B

QCM

Q1.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent des buts du diagnostic communautaire :

- A. Identifier les principaux problèmes de santé des individus
- B. Faire une analyse fine des ressources disponibles dans le cadre de vie des communautés
- C. Initier un processus de collaboration entre les individus et les agents de santé.

Q2.Quel est l'ordre normal des étapes de la conduite du diagnostic communautaire ?

1. Mise en œuvre des activités.
2. Définition des objectifs d'action
3. Identification des problèmes, des besoins et des ressources
4. Etablissement des priorités
5. Mise en place d'un plan d'action
6. Documentation des problèmes prioritaires
7. Choix des stratégies

8. Mise en place d'un plan d'évaluation.

A (1,2,3,5,4,6,8,7) B (1,2,3,4,5,6,7,8) C(7,4,1,2,6,3,5,8) D (5,1,2,4,6,3,8,7)

Q3.Parmi les critères suivants, indiquez ceux permettent de sélectionner un problème prioritaire

A-La population totale de la localité B- L'ampleur du problème C- La gravité du problème

D-Le niveau d'instruction des populations E- La vulnérabilité du problème

F-La durée des interventions.

Q4.L'ampleur d'un problème prioritaire de santé se détermine à partir :

A-du nombre de nombre de cas de cette maladie. B- du nombre de décès engendrés par cette maladie

C-des séquelles engendrées par cette maladie

Q5.Voici une liste de population cibles et des pondérations en vue de la sélection d'un problème prioritaire

1. Vieillards

2. Femmes enceintes

a.05 points

3. Enfants

b.02 points

4. Adultes

Identifiez les bonnes combinaisons entre les populations-cibles et les pondérations

A (b ;1,3) B (a ;2,3) C (a ;2,4) D (b ;1,4)

Q6.Voici une liste de nombre de cas et des pondérations en vue de la sélection d'un problème prioritaire

1. Entre 10 à 19 cas

a.05 points

2. 20 cas et plus

b.02 points

3. < à 10 cas

c.04 points

Identifiez les bonnes combinaisons entre les populations-cibles et les pondérations

A (b ;1) B (a ;2) C (a ;3) D (c,2) E (c ;1) F (b,3)

Q7.Voici une liste de critères de gravité et des pondérations en vue de la sélection d'un problème prioritaire

1. 5 et 14 décès ou séquelles

a.00 point

2. Ne constitue aucune menace

b.02 points

3. 15 décès ou séquelles et plus

c.04 points

4. < 4 décès ou séquelles

d.05 points

Identifiez les bonnes combinaisons entre les populations-cibles et les pondérations

A (b ;1) **B (c ;1)** **C (a ;2)** D (c,2) **E (b ;4)** **F (d,3)** G(a,3)

Q8.Voici une liste de critères de vulnérabilité et des pondérations en vue de la sélection d'un problème prioritaire

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. La solution est réalisable | |
| 2. Une solution existe | a.05 points |
| 3. La solution est acceptable | b.01 point |
| 4. La solution est applicable | |

Identifiez les bonnes combinaisons entre les populations-cibles et les pondérations

A (b ;1,3,4) B (a ;2,4,3) **C (a ;2)** D (b,3,4)

Q9.Voici une liste de critères et des pondérations en vue de la sélection d'un problème prioritaire

- | | |
|---|-------------|
| 1. La population perçoit bien le problème | a.05 points |
| 2. Le coût nécessite l'appui d'une ONG | b.02 points |
| 3. La population a une perception erronée du problème | c.03 points |
| 4. Le coût est à la portée de la population | |

Identifiez les bonnes combinaisons entre les populations-cibles et les pondérations

A (a ;1,4) B (a ;2,4,3) C (a ;2) **D (b,3)** **E (c,2)** F(c,1 ;4)

CHAPITRE 8 : LES FLEAUX SOCIAUX

- Q1.L'accoutumance est un phénomène par lequel l'organisme devient peu à peu insensible à un produit régulièrement absorbé et qui oblige souvent le toxicomane à réduire les doses. B
- Q2.L'alcoolisme est un ensemble de phénomènes pathologiques entraîné par l'abus de boissons sucrées. B
- Q3.L'effet aigu de l'alcoolisme se manifeste au cours de la phase d'euphorie par des troubles de la parole. A
- Q4.L'effet aigu de l'alcoolisme se manifeste au début par une joie excessive. B
- Q5.L'effet aigu de l'alcoolisme se manifeste pendant la phase d'incoordination par l'insensibilité. B
- Q6.La collaboration multisectorielle limite l'efficacité de la lutte contre la drogue. B
- Q7.La dépendance résulte de l'absorption continuelle et répétée de drogue ou leurs dérivés. A
- Q8.La dépendance s'exprime par un besoin excessif du consommateur lors de la prise de drogue ou certains médicaments. A
- Q9.La drogue est un produit ou une substance d'origine animale ou chimique utilisé comme principe actif dans une préparation médicamenteuse. B
- Q10.La pharmacodépendance est un état résultant de l'absorption périodique ou continuelle d'une drogue naturelle. B
- Q11.La ratification de la convention pour la lutte contre le tabagisme n'est pas appliquée en côte d'ivoire. B
- Q12.La tolérance est la propriété que possède l'organisme de supporter des doses d'une substance en manifestant des signes d'intoxication. B
- Q13.La tolérance est un état résultant de l'absorption continuelle et répétée de drogue ou leurs dérivés. B
- Q14.La toxicomanie est un état d'intoxication périodique ou chronique nuisible à l'individu et à la société engendré par la consommation d'un médicament. B
- Q15.Un stupéfiant est une substance psychotrope dont l'usage répété conduit à une indépendance. A

QCM

Q1.Parmi les facteurs suivants, identifier ceux qui favorisent l'alcoolisme :

A-Le coût exorbitant de l'alcool B- La timidité C- L'angoisse D- La pénurie d'eau

Q2.Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui constituent des effets aigus de l'alcool

A-Gastrite aiguë B- Ralentissement des réflexes C- Polynévrite D- Cardiopathie

E-Ralentissement du rythme cardiaque F- Ralentissement du rythme respiratoire

Q3. Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui constituent des effets chroniques de l'alcool

- A- Ralentissement du rythme cardiaque B- Baisse de la vigilance C- Polynévrite
C- Ralentissement des réflexes D- Bronchite E- Ralentissement du rythme respiratoire

Q4. Parmi les mesures suivantes, indiquez celles qui permettent de prévenir l'alcoolisme

- A- Interdire la vente de l'alcool dans les bars B- Réprimer l'ivresse dans les ménages
C- Dépister précocement les buveurs excessifs D- Lutter contre le chômage
E- Assurer la prise en charge dans les centres spécialisés
F- Sensibiliser les populations sur les méfaits de l'alcool

Q5. Parmi les difficultés ci-après, deux sont des problèmes sociaux causés par l'abus des drogues. Lesquels ?

- A- L'absentéisme B- Le trouble respiratoire C- Les accidents de la voie publique
D- Les idées dépressives E- L'amaigrissement.

Q6. Identifiez deux facteurs favorisant l'alcoolisme émanant de la personne.

- A- Timidité ou angoisse B- L'environnement familial C- Le milieu professionnel
E- Le chômage F- Réaction difficile face à un échec.

Q7. Quelles sont les accidents causés par l'abus des drogues chez la mère.

- A- L'endométriose B- Les fausses couches C- Le fibrome
D- Les accouchements prématurés E- Le kyste de l'ovaire.

Q8. Parmi les problèmes suivants causés par l'abus des drogues, indiquez ceux qui sont d'ordre social :

- A- L'hallucination B- L'absentéisme scolaire C- Le délire
D- Les accidents de la voie publique E- Le suicide F- L'asthénie

Q9. Parmi les problèmes suivants causés par l'abus des drogues, indiquez ceux qui sont d'ordre sanitaire :

- A- L'absentéisme scolaire B- L'hallucination D- Les accidents de la voie publique
E- Le délire F- Le suicide G- L'asthénie

Q10. Parmi les actions suivantes, indiquer celles qui permettent de lutter contre la drogue

- A. Limitation de l'accès aux drogues
B. Sensibilisation de la population sur les bienfaits sanitaires de la drogue.
C. Mobilisation de toutes les couches sociales en faveur de la consommation de la drogue
D. Association des autres secteurs d'activités aux actions de lutte dans une approche multisectorielle

Q11. Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui favorisent le tabagisme

A-Sensibilisation des fumeurs sur les bienfaits de la cigarette

B-Difficultés psychologiques

C- Les difficultés familiales

D- Le coût exorbitant du tabac

E-Les campagnes publicitaires menées par les industriels

F-L'interdiction de la vente de tabac dans les rues

Q12. Parmi les actions suivantes, indiquez ceux qui permettent de lutter contre le tabagisme

A. Encouragement du parrainage de certaines usines de tabac en faveur des sports rassemblant la jeunesse

B. Sensibilisation des fumeurs sur les dangers de la cigarette

C. Création des structures de prise en charge des jeunes et personnes en difficulté

D. Promotion de la publicité sur le tabac

CHAPITRE 10 : SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET RIPOSTE (SIMR)

Q1.Dans les cas de poliomyélite à virus de type sauvage, l'excrétion virale dans les selles augmente au-delà de deux semaines après le début de la paralysie. B

Q2.Dans les cas de poliomyélite à virus de type sauvage, l'excrétion virale dans les selles diminue au-delà de deux semaines après le début de la paralysie. A

Q3.En cas de paralysie flasque aigue une analyse et des actions correctrices se font entre J10 et J14. B

Q4.En cas de paralysie flasque aigue une classification par le CNEP se fait entre J10 et J14. B

Q5.En cas de paralysie flasque aigue une inscription du code EPID dans la Base PFA se fait après 06 mois. B

Q6.En cas de paralysie flasque aigue une investigation avec fiche se fait après 06 mois. B

Q7.En cas de paralysie flasque aigue une notification avec diagnostic provisoire se fait après 06 mois. B

Q8.En cas de paralysie flasque aigue, la proportion d'échantillons de selles prélevés dans les 14 jours après le début de la paralysie doit être $\leq$ à 80%. B

Q9.En cas de paralysie flasque aigue, la proportion d'échantillons de selles prélevés dans les 14 jours après le début de la paralysie doit être $\geq$ à 80%. A

Q10.La SIMR a été adoptée en 1998 à Hararé au Kenya par les Etats membres de la région Africaine de l'Organisation Mondiale de la Santé. B

Q11.Le taux de paralysie flasque aigue est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est ≤ 2 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans. B

Q12.Le taux de paralysie flasque aigue est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est ≥ 2 pour 10 000 enfants de moins de 15 ans. B

Q13.Le taux de paralysie flasque aigue est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est ≥ 2 pour 100 000 enfants de moins de 5 ans. B

Q14.Le taux de paralysie flasque aigue est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est ≥ 2 pour 100000 enfants de moins de 15 ans. A

Q15.Le taux de paralysie flasque aigue est dit poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est ≥ 2 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans. B

Q16.Selon le RSI,la pocédure de recueil des selles chez un cas de poliomyélite à virsu de type sauvage consiste à recueillir deux (02) échantillons de selles d'un cas de PFA dans les 14 jours avant l'apparition de la paralysie. B

Q17.Selon le RSI,la pocédure de recueil des selles chez un cas de poliomyélite à virsu de type sauvage consiste à recueillir deux (02) échantillons de selles d'un cas de PFA dans les 14 jours suivant l'apparition de la paralysie.A

Q18.Un cas présumé de poliomyélite due à un poliovirus de type sauvage est tout enfant de moins de 15 ans présentant une paralysie flasque aigue ou toute personne quel que soit son âge présentant une maladie paralytique et chez qui l'on soupçonne une poliomyélite. A

QCM

Q1.SIMR signifie :

- A-Système intégré de la maladie et la riposte B- Surveillance intégrée de la maladie et la riposte
C-Surveillance intégrée de la maladie et la riposte D- Système intégré de la morbidité et la riposte
E-Surveillance intégrée de la morbidité et la riposte

Q2.Parmi les maladies suivantes, indiquez celles qui sont sous surveillance en Côte d'Ivoire

- A-Le cholera B- Le paludisme C- La fièvre hémorragique virale D- La dracunculose
E-Les infections respiratoires aiguës F- Les infections urinaires

Q3.PFA signifie

- A-Paralysie flasque aigue B- Paralysie flasque accentuée C- Paralysie flasque accrue

Q4.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui caractérisent une PFA dans une structure sanitaire:

- A-une perte du tonus musculaire touchant un muscle du corps
B-une survenue brutale de la perte du tonus C- une survenue progressive

Q5.Parmi les gestes suivants, indiquez ceux qu'il faut mener en cas de paralysie flasque aigue :

- A. Notifier immédiatement le cas aux autorités sanitaires du district ;
B. Recueillir 2 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 12-24 heures dans les 14 jours après l'apparition de la paralysie
C. Recueillir 2 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 24-48 heures dans les 14 jours après l'apparition de la paralysie
D. Acheminer les échantillons en bon état au laboratoire de l'Institut Pasteur dans un délai de 7 jours après collection.

Q6.En cas de paralysie flasque aigue un prélèvement des selles se fait :

- A-Entre J10 et J14 B- Entre J14 et J60 C- Entre J61 ET 06 mois D- Après 06 mois

Q7.En cas de paralysie flasque aigue une notification avec diagnostic provisoire se fait :

- A-Entre J10 et J14 B- Entre J14 et J60 C- Entre J61 et 06 mois D- Après 06 mois

Q8.En cas de paralysie flasque aigue une Inscription du code EPID dans la Base PFA se fait :

- A-Entre J10 et J14 B-Entre J14 et J60 C- Entre J61 et 06 mois D-Après 06 mois

Q9.En cas de paralysie flasque aigue une classification par le CNEP se fait :

A-Entre J10 et J14 B- Entre J14 et J60 C- Entre J61 ET 06 mois D- Après 06 mois

Q10.En cas de paralysie flasque aigue une analyse et des actions correctrices se font :

A-Entre J10 et J14 B- Entre J14 et J60 C- Entre J61 ET 06 mois D- Après 06 mois

Q11.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent des indicateurs de surveillance des paralysie flasques aigues

A-L'investigation avec fiche B- Le taux de PFA

C-La proportion d'échantillons de selles prélevés dans les 14 jours après le début de la paralysie

D-La perte du tonus musculaire E- Le code EPID F- La classification par le CNEP

Q12.Un cas de paralysie flasque aigue pour lequel on ne dispose pas de deux échantillons de selles recueillis dans les 14jours suivant l'apparition de la paralysie il faut prélever des échantillons supplémentaires chez:

A-05 contacts proches B-03 contacts proches C-03 contacts proches

D-01 contact proche

Q13.Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui sont observés en cas de SRAS :

A-vertiges B- toux C- difficulté respiratoire D- essoufflement

E-épistaxis F- insomnie

Q14.Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui sont cités dans la définition de cas suspect de rougeole au niveau de la structure sanitaire

A-La Fièvre B-Présence d'IgM dans le sang C- Une éruption D- Des vertiges

E-Des selles sanguinolentes F- Une toux

Q15.Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui sont cités dans la définition de cas confirmé de rougeole au niveau de la structure sanitaire

A-La Fièvre B- une toux D- une conjonctivite E- cas suspect avec IgM positif

Q16.Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui peuvent faire suspecter la rougeole au niveau communautaire

A-La toux B- La chaleur corporelle C- L'éruption cutanée étendue sur le visage et le corps.

D-les vertiges E- les vomissements

Q17.La Suspicion d'une épidémie dans une aire sanitaire survient lorsque :

A. au moins 05 cas confirmés sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants

B. au moins (05) cas suspects sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants

C. au moins (05) cas suspects sont notifiés en un mois au sein d'une population de 10 000 habitants

D. au moins (03) cas suspects sont notifiés en un mois au sein d'une population de 10 000 habitants

Q18.L'épidémie est confirmée dans une aire sanitaire lorsque :

A.au moins 05 cas confirmés sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants avec notion de lien épidémiologique.

B.au moins (05) cas suspects sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants avec notion de lien épidémiologique.

C.au moins (03) cas suspects sont notifiés en un mois au sein d'une population de 10 000 habitants avec notion de lien épidémiologique.

D.au moins 03 cas confirmés sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants avec notion de lien épidémiologique.

Q19.Pendant l'organisation de la riposte devant un cas suspect de rougeole, le prélèvement de sang se fait entre :

A-Le 1^{er} et le 4^e jour après le début de l'éruption B- le 4^e et le 28^e jour après le début de l'éruption

C-le 14^e et le 28^e jour après le début de l'éruption C- le 4^e et le 14^e jour après le début de l'éruption

Q20.Pendant l'organisation de la riposte devant un cas suspect de rougeole, le prélèvement de gorge se fait entre :

A-Le 1^{er} et le 7^e jour après le début de l'éruption B- le 4^e et le 28^e jour après le début de l'éruption

C-le 14^e et le 28^e jour après le début de l'éruption D- le 4^e et le 14^e jour après le début de l'éruption

Q21.Parmi les actions suivantes de prévention d'une épidémie de rougeole, indiquez celles qu'il faut mener en présence d'un cas suspect :

A-Hospitalisation du cas suspect B- Traitement adéquat du cas suspect

C-Limitation de contact entre sujets vaccinés et sujet ayant fait maladie.

D-Vaccination du cas suspect

Q22.Parmi les actions suivantes de prévention d'une épidémie de rougeole, indiquez celles qu'il faut mener en présence d'un cas confirmé :

A-Vaccination du cas confirmé B- Hospitalisation du cas confirmé

C-Traitement adéquat du cas confirmé D-Isolement du cas confirmé dès apparition des 1^{ers} signes.

E-Limitation de contact entre sujets vaccinés et ayant fait la maladie.

Q23.Pour prévenir une épidémie de rougeole il faut vacciner :

A-Tout cas suspect de rougeole B- Tout cas confirmé de rougeole

C- Tout sujet contact de rougeole

Q24.Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui sont cités dans la définition de cas suspect de fièvre jaune au niveau d'une structure sanitaire

A. Présence de IgM dans le sang avec histopathologie du foie positive

B. une fièvre d'apparition brusque

C. ictère apparaissant dans les 14 jours après le début des symptômes.

D. Détection d'anticorps neutralisants spécifiques chez un sujet non vacciné dans les 30 jours

Q25 Parmi les signes suivants, indiquez celui qui est cité dans la définition de cas probable de fièvre jaune au niveau d'une structure sanitaire

A. une fièvre d'apparition brusque

B. ictère apparaissant dans les 14 jours après le début des symptômes.

C. présence de IgM dans le sang avec histopathologie du foie positive

D. présence d'anticorps neutralisants spécifiques chez un sujet non vacciné dans les 30 jours

26 Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui sont cités dans la définition de cas confirmé de fièvre jaune au niveau d'une structure sanitaire

A-une fièvre d'apparition brusque B- augmentation du titre IgG par 4

C-ictère apparaissant dans les 14 jours après le début des symptômes.

D-présence de IgM dans le sang avec histopathologie du foie positive

présence d'anticorps neutralisants spécifiques chez un sujet non vacciné dans les 30 jours

Q27 Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui sont cités dans la définition de cas de fièvre jaune au niveau communautaire

A-une fièvre d'apparition brusque

B-Jaunissement soudain de la peau de plus de deux semaines avec chaleur corporelle.

C-Jaunissement soudain de la peau de plus de deux semaines sans chaleur corporelle.

D-Ictère apparaissant dans les 14 jours après le début des symptômes.

Q28 Il y a épidémie de fièvre jaune lorsque :

A-Au moins un cas suspect est confirmé B- Au moins un cas suspect est notifié

C-Au moins un cas probable est notifié D- Plus d'un cas suspect est confirmé

Q29 Parmi les gestes suivants indiquez ceux qui sont à faire devant un cas suspect de fièvre jaune :

A-Entreprendre une investigation épidémiologique B- Identifier la zone concernée

C-Identifier les personnes sans risque D- S'abstenir de mener des actions de lutte antivectorielle

Q30 Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont cités dans la définition de cas suspect de tétanos néonatal

A. décès néonatal survenu entre le 3^{ème} et le 28^{ème} jour de la vie et dont la cause est inconnue

B. nouveau-né ayant souffert du tétanos entre le 3^{ème} et le 28^{ème} jour de la vie mais n'ayant pas fait l'objet d'une enquête.

C. décès néonatal survenu entre le 4^e et le 28^e jour de la vie et dont la cause est inconnue

D. décès néonatal survenu entre le 1^e et le 14^e jour de la vie et dont la cause est inconnue

E. nouveau-né ayant souffert du tétanos entre le 3^e et le 14^{ème} jour de la vie mais n'ayant pas fait l'objet d'une enquête.

Q31 Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont cités dans la définition de cas confirmé de tétanos néonatal

A-Nouveau-né ayant présenté une aptitude normale à téter et à crier pendant les 2 premiers jours de la vie et ne pouvant plus téter normalement entre le 3^{ème} et le 28^{ème} jour

B-Nouveau-né qui devient raide

C- Nouveau-né ayant une fièvre

D- Nouveau-né qui a des convulsions.

E-Nouveau-né ayant présenté une aptitude normale à téter et à crier pendant les 2 premiers jours de la vie et pouvant téter normalement entre le 3^{ème} et le 28^{ème} jour

Q34 Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qu'il faut rechercher au cours de l'investigation devant un cas de tétanos néonatal

A-Statut vaccinal du nouveau-né

B- Les dates des consultations postnatales

C-Le lieu d'accouchement

D- Le Responsable de l'accouchement

Q35 Parmi les gestes suivants, indiquez ceux à qu'il faut faire devant un cas suspect de tétanos néonatal

A-Notifier sans tarder au district sanitaire ou à la DCPEV

B-Faire un prélèvement de sang à l'enfant malade

C-Référer le cas à l'hôpital du district pour une prise en charge

D-Investiguer pour identifier les facteurs associés à la survenue du cas

E-Administrer une dose de Td au nouveau-né s'il est confirmé malade

Q36 Parmi les gestes suivants, indiquez ceux à qu'il faut faire devant un cas de tétanos néonatal confirmé

A-Administrer à la mère du malade et aux autres femmes et filles vivant dans la même habitation que le cas, 1 doses du vaccin antitétanique

B-Organiser dans la localité des activités de vaccination supplémentaire en deux (02) passages à l'intention de toutes les Femmes en âge de reproduction (FAR)

C-Eduquer les nouveau-nés quant à la nécessité de couper et de soigner le cordon en observant de bonnes conditions d'hygiène

D-Améliorer la couverture vaccinale de routine du Td.

CHAPITRE 12 : MONITORAGE DES ACTIVITES DE SANTE

Q1.Dans la pratique, la fiche de relevé de la température du réfrigérateur est le seul support de données utilisé pour le calcul de la couverture effective dans le monitoring de l'activité du PEV de routine. A

Q2.Dans le monitoring de l'activité de vaccination, la mauvaise estimation des besoins en vaccins est une cause probable du goulot d'étranglement situé entre la population cible et l'accessibilité géographique aux soins. B

Q3.Dans le monitoring des activités, les déterminants de couverture mesurent les indicateurs. B

Q4.Dans le monitoring du PEV, la couverture effective se calcule en multipliant la couverture adéquate par le score de la chaîne de froid. A

Q5.Il n'y a pas de différence entre un obstacle et une contrainte. B

Q6.L'accessibilité géographique aux soins dans le monitoring des consultations des soins curatifs se définit comme la population cible habitant dans un rayon de moins de 10 km. A

Q7.L'accueil humaniste des populations par les agents de santé est la stratégie pour corriger le goulot d'étranglement entre la couverture adéquate et l'utilisation de service. B

Q8.L'information des mères sur les dates de rendez-vous de vaccination est une stratégie pour lever le goulot d'étranglement entre l'utilisation de service et la couverture adéquate. A

Q9.La construction des cases de santé est une stratégie pour lever le goulot d'étranglement entre la disponibilité des ressources et l'accessibilité géographique. A

Q10.La couverture adéquate est plus orientée vers la quantité que la qualité. A

Q11.La couverture effective est plus orientée vers la mesure de la qualité. A

Q12.La fiche de relevé ou de contrôle de la température du réfrigérateur dans le monitoring de l'activité de vaccination est un support de données qui sert à mesurer la couverture adéquate. B

Q13.La formation des agents de santé sur les normes de qualité est la stratégie pour corriger le goulot d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate. B

Q14.La mauvaise estimation de la population cible est une cause probable du goulot d'étranglement situé entre la disponibilité des ressources et la population cible. A

Q15.La période du monitoring exprimée en jour est de 262 et 263 jours. A

Q16.La population cible des Consultations et soins curatifs est la population totale pendant la période monitorée. A

Q17.La population cible du monitoring de l'activité de la CPN est composée des femmes qui ont accouché pendant la période du monitoring. A

Q18.La population cible du monitoring de l'activité du PEV est composée des enfants qui ont eu un an pendant la période du monitoring. A

Q19.La population efficace dans le cadre du monitoring est la population qui vit à moins de 5 km du centre et celle des villages ayant bénéficié d'au plus trois stratégies avancées. B

Q20.La rupture du vaccin anti-méningite est la cause du goulot d'étranglement situé entre la population cible et la disponibilité des ressources dans le monitoring de l'activité de vaccination. A

Q21.Le carnet de santé mère/enfant est un support de données qui sert à mesurer la couverture effective dans le monitoring de l'activité de consultation prénatale. A

Q22.Le carnet de santé mère/enfant est un support de données qui sert à mesurer la couverture effective dans le monitoring de l'activité de vaccination. A

Q23.Le goulot d'étranglement est le problème rencontré lors du monitoring et se lit du haut vers le bas. B

Q24.Le monitoring de Décembre 2022 concerne les couvertures de Juin 2023 à Novembre 2023. A

Q25.Le monitoring de juin 2023 concerne les couvertures de Décembre 2022 à Mai 2023. A

Q26.Le monitoring des activités permet de réadapter les stratégies identifiées pour corriger les goulots d'étranglement. A

Q27.Le monitoring est une activité qui mesure les résultats. B

Q28.Le registre de consultation prénatale est un support de données utilisé dans le monitoring de l'accouchement. A

Q29.Les déterminants de couverture sont aussi appelés critères dans le cadre du monitoring. A

Q30.Les fiches de stock du FAF et de la SP sont des supports de données pertinents qui servent à mesurer la disponibilité des ressources dans le monitoring de l'activité de la CPNr. A

Q31.Pendant le monitoring de Décembre 2022, on fait la budgétisation de Décembre 2022 à Mai 2023. A

Q32.Pendant le monitoring de Juin 2022, on fait la budgétisation de Juin 2022 à Novembre 2022. A

Q33.L'indicateur de la couverture effective des activités de vaccination est la Proportion de la population cible qui a reçu une couverture adéquate avec des vaccins conservés entre +2°C et + 8°C et MILDA et VIT A bien conservés et non périmés. A

Q34.L'utilisation des services peut être définie comme le pourcentage de la population cible qui utilise le service au moins une fois au cours de la période couverte par le monitoring. A

Q35.La longue attente est une cause probable du goulot d'étranglement situé entre l'utilisation des services et la couverture adéquate. A

Q36.La mauvaise estimation de la population cible est une cause probable du goulot d'étranglement situé entre la population cible et la disponibilité des ressources. A

Q37.La période du monitoring exprimée en jour est de 262 et 263 jours. B

Q38.La population cible du monitoring de l'activité de la CPN est composée des femmes qui ont accouché pendant la période du monitoring. A

Q39.La rupture du vaccin est la cause du goulot d'étranglement situé entre la population cible et la disponibilité des ressources dans le monitoring de l'activité de vaccination. A

Q40.La stratégie avancée est une stratégie correctrice d'une cause probable du goulot d'étranglement situé entre l'accessibilité géographique et la disponibilité des ressources. B

Q41.Le goulot d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services signifie que la population a accès au service mais ne le fréquente pas. A

Q42.Le goulot d'étranglement est le problème rencontré lors du monitoring et qui se lit du haut vers le bas. B

Q43.Si des données manquent sur une feuille de température manquantes, la chaîne du froid est considérée comme rompue pour ces données manquantes. A

Q44.Sur le diagramme des couvertures du monitoring des activités, les goulots d'étranglement s'identifient à partir des points d'inflexion vers la droite. B

Q45.Un déterminant de couverture est aussi appelé caractéristique. A

Q46.Un goulot d'étranglement entre la couverture adéquate et la couverture effective signifie que la population reçoit les soins en qualité et non en quantité. B

QCM

Q1.La population cible du monitoring de la vaccination est :

A-Enfant de 0 à 23 mois B- Enfants de 9 mois à 14 ans C- Enfants de 0 à 5 ans

D-0 à 59 mois

Q2.La population cible du monitoring de la CPN est :

A. Femme en âge de reproduction de la période du monitoring

B. Femmes enceintes pendant la période du monitoring

C. Femmes ayant accouchées pendant la période du monitoring

Q3. Quel l'ordre normal d'analyse des déterminants de couverture des activités au monitoring ?

1. Population cible
2. Accessibilité géographique
3. Disponibilité des ressources
4. Utilisation des services
5. Couverture effective des soins
6. Couverture adéquate des soins

A (1,2,3,4,5,6) B (1,3,2,4,5,6) **C (1,3,2,4,6,5)** D (1,3,2,6,5,4)

Q4. Parmi les indicateurs suivants, indiquez ceux qui permettent de mesurer la disponibilité des ressources pendant le monitoring des activités de vaccination :

- A. Pourcentage de temps sans rupture en vaccins du PEV**
B. Pourcentage de temps sans rupture en feuilles de température
C. Pourcentage de temps sans rupture en seringue autobloquante
D. Pourcentage de temps sans rupture en boîtes de sécurité

Q5. Parmi les indicateurs suivants, indiquez celui qui permet de mesurer l'accessibilité géographique pendant le monitoring des activités de vaccination :

- A. Pourcentage de la population cible vivant dans un rayon de moins de 5km**
B. Pourcentage de la population cible ayant bénéficié d'au moins une stratégie avancée
C. Pourcentage de la population cible ayant bénéficié d'au moins trois stratégies avancées
D. Pourcentage de la population totale ayant bénéficié d'au moins trois stratégies avancées
E. Pourcentage de la population cible vivant dans un rayon de moins de 10 km

Q6. Parmi les indicateurs suivants, indiquez celui qui permet de mesurer la couverture adéquate pendant le monitoring des activités de vaccination :

- A. Pourcentage de la population cible ayant reçu le Penta 1, la 1ère dose de la PCV13 et du Rotarix, le VPO 0.
B. Pourcentage de la population cible ayant reçu le Penta 1, la PCV13-1, la DN de Hépatite B, le Rota1, le VPO 0.
C. Pourcentage de la population cible ayant reçu au moins une dose d'un vaccin de le Penta 1, la 1ère dose de la PCV13 et du Rotarix, le VPO 0.
D. Pourcentage de la population cible ayant reçu le BCG, la DN de l'hépatite B, le Penta 3, PCV13-3, le Rota2, le VPO-3, le RR, le VAA, le Men A, avant 1 an avec le respect d'un intervalle d'au moins 28 jours et l'âge minimum requis.
E. Pourcentage de temps de bon fonctionnement de la chaîne du froid

Q7.L'existence d'un goulot d'étranglement entre la population cible et la disponibilité des ressources signifie que :

A. Les ressources sont disponibles mais la population cible ne s'y intéresse pas.

B. Les ressources ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins de la population cible.

C. L'effectif de la population cible est très petit par rapport aux ressources disponibles.

Q8.L'existence d'un goulot d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services signifie :

A. La population ne fréquente pas le service parcequ'elle n'y accède pas

B. La population a accès au service, mais ne le fréquente pas

C. La population accède difficilement au service, mais le fréquente

Q9.L'existence d'un goulot d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate signifie :

D. La population vient une fois recevoir un soin, mais ne revient plus pour terminer la série de soins souhaitée pour avoir l'effet escompté.

E. La population vient pour recevoir les soins mais n'y parvient pas.

F. La population bénéficie des soins en quantité mais pas en qualité.

Q10.L'existence d'un goulot d'étranglement entre la couverture adéquate et la couverture effective signifie :

A. La population reçoit les soins en qualité et non en quantité

B. La population reçoit les soins en quantité sans qualité

C. La population ne reçoit les soins ni en qualité ni en quantité

Q11.Parmi les sources suivantes, indiquez celles qui sont des sources de la population cible du monitoring des activités de vaccination :

A-Registre de recensement général de la population et de l'habitat

B-Registre de consultation

C- Document monographique

D- Registre de vaccination

E-Carnet mère-enfant

F- Registre de pesées et mensurations

Q12.Parmi les sources suivantes, indiquez celles qui sont des sources de la disponibilité des ressources dans le monitoring de la vaccination :

A-Registre de vaccination

B- Fiche de commande des vaccins et consommables

C-Bordereaux de Livraison des vaccins et des consommables

D-Fiches de stock des vaccins et consommables

E- Registre de consultation

F-La feuille de température

Q13. Parmi les sources suivantes, indiquez celles qui sont des sources de l'accessibilité géographique au cours du monitoring de la vaccination :

A- Cartographie de l'aire sanitaire B- Rapports de vaccination C- Registre de vaccination

D- Registre de données démographiques

Q14. L'existence d'un goulot d'étranglement entre la couverture adéquate et la couverture effective signifie :

A- La population reçoit les soins en qualité et non en quantité

B- La population reçoit les soins en quantité sans qualité

C- La population ne reçoit les soins ni en quantité ni en qualité

Q15. Parmi les causes suivantes, identifiez deux causes susceptibles de justifier l'existence d'un goulot d'étranglement entre la couverture adéquate et la couverture effective :

A- Non maîtrise des techniques de soins par les agents de santé

B- Mauvais accueil des patients C- Attente trop longue pour les patients

D- Absence ou insuffisance de supervision

Q16. Parmi les stratégies suivantes, identifiez deux susceptibles de lever le goulot d'étranglement entre la couverture adéquate et la couverture effective :

A- Formation de l'IDE/SF sur les techniques des soins indiqués

B- Réduction du temps d'attente par une bonne organisation du service

C- Respect rigoureux de l'asepsie pendant les soins

D- Organisation ou intensification des supervisions

Q17. L'existence d'un goulot d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate signifie :

A. La population vient une fois recevoir un soin, mais ne revient plus pour terminer la série de soins souhaitée pour avoir l'effet escompté.

B. La population vient pour recevoir les soins mais n'y parvient pas.

C. La population bénéficie des soins en quantité mais pas en qualité.

Q18. Parmi les causes suivantes, identifiez trois susceptibles de justifier l'existence d'un goulot d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate:

A- Méconnaissance des normes exigées pour la qualité des soins

B- Rupture des ressources C- Attente trop longue pour les patients

D- Apparition des MAPI E- Mauvais accueil des patients D- Considérations socioculturelles

Q19. Parmi les stratégies suivantes, identifiez deux susceptibles de lever le goulot d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate :

A- Information de la population sur les activités du centre

B- Respect rigoureux de l'asepsie pendant les soins

C- Réduction du temps d'attente par une bonne organisation du service

D-Mention et explication des dates des RDV E- Organisation des stratégies avancées

F-Formation de l'IDE/SF sur les techniques des soins indiqués

Q20.L'existence d'un goulot d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services signifie :

A. La population ne fréquente pas le service parcequ'elle n'y accède pas

B. La population a accès au service, mais ne le fréquente pas

C. La population accède difficilement au service, mais le fréquente

Q21.Parmi les causes suivantes, identifiez deux susceptibles de justifier l'existence d'un goulot d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services

A-Intervalle de commande trop long B- Considérations socioculturelles

C-Manque ou insuffisance d'informations de la population sur les activités du centre de santé

D-Rupture des ressources

Q22.Parmi les stratégies suivantes, identifiez deux susceptibles de lever le goulot d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services :

A-Sensibilisation de la population sur l'importance de fréquenter les services de santé en cas de besoin tout en respectant leurs coutumes

B-Organisation des stratégies avancées D-Approvisionnement en ressources

E-Information de la population sur les activités du centre

Q23.L'existence d'un goulot d'étranglement entre la disponibilité des ressources et l'accessibilité géographique signifie :

A-Les ressources manquent ou sont insuffisantes pour la population cible

B-La population cible refusent d'utiliser les ressources mises à sa disposition

C-Les ressources sont disponibles, mais la population n'y a pas accès

Q24.L'existence d'un goulot d'étranglement entre la population cible et la disponibilité des ressources signifie :

A-La population cible est présente, mais manque de ressources

B-La population cible n'a pas accès aux ressources du fait de leur éloignement du centre

C-La population cible refuse d'utiliser les ressources mises à sa disposition

Q25.Parmi les informations à recueillir pour mesurer la couverture adéquate, une n'est pas exacte

A-Fiche de stock

B. Les rapports de supervision

C- Le carnet mère enfant

Q26.En côte d'Ivoire, le rythme des activités de monitoring est :

A-Annuel

B- Semestriel

C- Trimestriel

D- Bimensuel

Q27.Parmi les mois suivants, indiquez ceux qui sont choisis en Côte d'Ivoire pour effectuer le monitoring

A-Janvier

B- Mars

C- Juin

D- Juillet

E- Decembre

Q28.Au monitoring de juin :

A. on évalue les couvertures de décembre à mai précédent

B. on évalue les couvertures de juin à novembre précédent

C. On fait le budget de juillet à décembre suivant

D. on fait le budget de janvier à juin suivant.

Q29.Au monitoring de décembre

A-on évalue les couvertures de juin à novembre précédent

B-on fait le budget de janvier à juin suivant. C- On fait le budget de juillet à décembre suivant

D-on évalue les couvertures de décembre à mai précédent

Q30.Au monitoring de juin 2025

A-on évalue les couvertures de décembre 2024 à mai 2025

B-on évalue les couvertures de juin 2025 à novembre 2025

C- On fait le budget de juillet 2025 à décembre 2025

D-on fait le budget de janvier 2025 à juin 2025.

Q31.Au monitoring de décembre 2024

A-on évalue les couvertures de juin 2023 à novembre 2023

B- on fait le budget de janvier 2025 à juin 2025 C- On fait le budget de juillet 2024 à décembre 2024

D-on évalue les couvertures de décembre 2024 à mai 2024

Q32.Parmi les durées suivantes, indiquez celle qui correspond au monitoring de Juin

A-180 jours B- 181 jours C-182 jours D-183 jours

Q33.Parmi les durées suivantes, indiquez celle qui correspond au monitoring de Décembre

A-180 jours B-181 jours C-182 jours D-183 jours

Q34.Parmi les supports de données suivants, lequel sert à mesurer la couverture adéquate dans le cadre du monitoring.

A-Registre du personnel B- Livrets de bord des véhicules

C- Registre de consultation soins curatifs D- Fiche de stock des médicaments

Q35.Un indicateur est valable lorsqu'il :

A-Permet de mesurer effectivement ce qu'il est censé mesurer

B-Sa valeur est la même si deux personnes la mesurent C-Est adapté au contexte local

D-Peut être mesuré à partir de données et d'instrument simple

Q36.La population cible du monitoring de la vaccination est :

A-Enfants de 0 - 11 mois B- Enfants de 0-23 mois C- Enfants de 0-59 mois

D-Enfants de 9 mois à 14 ans

Q37.La population cible du monitoring de de la CPNr est :

- A. Femmes en âge de reproduction pendant la période du monitoring
- B. Femmes enceintes pendant la période du monitoring**
- C. Nombre de grossesses attendues dans la période monitorée**
- D. Nombre de naissances attendues pendant la période du monitoring
- E. Femmes dont l'âge est compris entre 15 et 49 ans dans la période monitorée

Q38.La population cible du monitoring des consultations de soins curatifs est :

- A. Les malades enregistrés pendant la période du monitoring
- B. Population totale desservie par l'ESPC pendant la période du monitoring**
- C. Populations fréquentant l'ESPC

Q39.L'accessibilité géographique pour le monitoring de la vaccination est :

- A. Proportion de la population cible qui vit à moins de 5 km d'un centre fixe et dans les localités où il y a eu au moins trois stratégies avancées pendant la période y compris les campements dépendants**
- B. Proportion de la population cible qui vit à moins de 5 km d'un centre fixe et dans les localités où il y a eu au moins deux stratégies avancées pendant la période y compris les campements dépendants
- C. Proportion de la population cible qui vit à moins de 5 km d'un centre fixe et dans les localités où il y a eu au moins une stratégie avancée pendant la période y compris les campements dépendants

Q40.L'accessibilité géographique pour le monitoring des consultations de soins curatifs est :

- A. Proportion de la population totale vivant dans un rayon de 10 km de l'ESPC.**
- B. Proportion de la population cible qui vit à moins de 5 km de l'EPSPC
- C. Proportion de la population cible qui vit à moins de 5 km d'un centre fixe et dans les localités où il y a eu au moins trois stratégies avancées pendant la période y compris les campements dépendants

Q41.Les sources de données de la disponibilité des ressources pour le monitoring de la vaccination sont :

- A-Les fiches de température du réfrigérateur des vaccins
- B-Bordereaux de livraison des vaccins et du matériel de vaccination**
- C-Fiches de stock des vaccins et du matériel de vaccination**
- D- Les fiches de pointage de vaccination

Q42.Les sources de données de l'accessibilité géographique pour le monitoring de la vaccination sont :

- A-La population cible du PEV
- B- Rapports de vaccination en stratégie avancée**
- C-Données démographiques**
- D- Le nombre de village de l'aire sanitaire

Q43.Les sources de données de l'utilisation des services pour le monitoring de la vaccination sont

- A-Les fiches de stock des vaccins B- **Registre de vaccination** C- **Rapport mensuel SIG**
D-Fiche de pointage de vaccination E- Les carnets mère/enfant

Q44.Les sources de données de la couverture adéquate pour le monitoring de la vaccination sont

- A-Registres de vaccination PEV** B- Les carnets mère/enfants C- La PCV

Q45.Les sources de données de la couverture effective pour le monitoring de la vaccination sont

- A-Feuille de relevé de température** B- Les carnets mère/enfant C- Les registres de vaccination
D-La PCV

Q1.Quel est l'ordre normal des étapes du chronogramme des activités pour la réalisation du monitoring ?

- 1.Choisir les Aires de santé
- 2.Fixer la date
- 3.Sélectionner les interventions
- 4.Mobiliser les ressources
- 5.Informer et sensibiliser les acteurs

- A (1,2,3,4,5) B (2,1,4,3,5) **C (2,4,1,3,5)** D (5,4,3,1,2)

Q2.Quelle est la période de fixation de la date du monitoring se fait ?

- A. **Pendant la planification initiale des stratégies ou monitoring en cours**
B. Deux semaines avant le monitoring
C. Six mois avant le monitoring

Q3.Quelle est la période de mobilisation des ressources pour réaliser le monitoring ?

- A. Pendant la planification initiale des stratégies ou monitoring en cours
B. Deux semaines avant le monitoring
C. Six mois avant le monitoring

Q4.Quelle est la période de choix des aires de santé pour réaliser le monitoring ?

- A. Pendant la planification initiale des stratégies ou monitoring en cours
B. Deux semaines avant le monitoring
C. Six mois avant le monitoring

Q5.Quelle est la période de sélection des activités à monitorer ?

- A. Pendant la planification initiale des stratégies ou monitoring en cours
B. Deux semaines avant le monitoring
C. **Six mois avant le monitoring**

Q6. Quelle est la période d'information et de sensibilisation des acteurs du monitoring ?

A. Pendant la planification initiale des stratégies ou monitoring en cours

B. Deux semaines avant le monitoring

C. Six mois avant le monitoring

Q7. Pendant quel mois se fait le premier monitoring de l'année en Côte d'Ivoire ?

A. Novembre

B. Décembre

C. Mai

D. Juin

Q8. Pendant quel mois se fait le deuxième monitoring de l'année en Côte d'Ivoire ?

A. Novembre

B. Décembre

C. Mai

D. Juin

Q9. Quelle est la période concernée par le premier monitoring de l'année en Côte d'Ivoire ?

A. Novembre à Juin de l'année en cours

B. Janvier à Juin suivant

C. Décembre de l'année précédente à Mai de l'année en cours

D. Janvier à Juillet de l'année en cours

Q10. Quelle est la période concernée par le deuxième monitoring de l'année en Côte d'Ivoire ?

A. Mai à Novembre de l'année en cours

B. Janvier à Juin suivant

C. Décembre de l'année précédente à Mai de l'année en cours

D. Juillet à décembre de l'année suivante

Q11. Quelle est la durée de la période du premier monitoring d'une année pendant laquelle le mois de Février compte 28 jours

A-181 jours B-**182 jours** C-183 jours

Q12. Quelle est la durée de la période du deuxième monitoring d'une année pendant laquelle le mois de Février compte 28 jours

A-181 jours B-182 jours C-**183 jours**

Q13. Pendant le premier monitoring d'une année, on fait la budgétisation pour la période de :

A. **Juillet de l'année en cours à décembre de l'année suivant**

B. Décembre de l'année précédente à Mai de l'année en cours

C. Mai à Novembre de l'année en cours

D. Janvier à Juin suivant

Q14. Pendant le deuxième monitoring d'une année, on fait la budgétisation pour la période de :

A. Juillet de l'année en cours à décembre de l'année suivant

B. Décembre de l'année précédente à Mai de l'année en cours

C. Mai à Novembre de l'année en cours **D- Janvier à Juin suivant**

Q15. Pendant combien de fois la température du réfrigérateur des vaccins est-elle relevée pendant la période du premier monitoring d'une année au cours de laquelle le mois de Février compte 28 jours

A-182 fois B-183 fois C-364 fois D-366 fois

Q16. Pendant combien de fois la température du réfrigérateur des vaccins est-elle relevée pendant la période du deuxième monitoring d'une année au cours de laquelle le mois de Février compte 28 jours

A-182 fois B-183 fois C-364 fois D-366 fois

CHAPITRE 13 : BUDGETISATION DES RESSOURCES D'UN ESPC

- Q1. Dans le cadre des SSP, le budget des structures sanitaires rurales se compose de l'investissement et le fonctionnement. A
- Q2. Il n'y a pas de différence entre les ressources propres et les ressources brutes d'une structure de santé. B
- Q3. La budgétisation se fait dans la même période que le monitoring des activités. A
- Q4. La somme à budgétiser est aussi appelée le fonds de réserve dans la budgétisation des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP. B
- Q5. La somme à budgétiser est égale aux recettes issues de la vente des médicaments essentiels plus celles issues du coût des actes de santé. A
- Q6. La somme allouée aux imprévus dans la budgétisation des ressources propres d'un centre de santé rural ne doit pas excéder 15% des recettes brutes. B
- Q7. Le budget couvre les dépenses de la structure sanitaire rurale pour les 6 prochains mois à partir de la période du monitoring. A
- Q8. Le budget de l'ESPC représente les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring. A
- Q9. Le budget des centres de santé est prévisionnel. B
- Q10. Le budget du centre de santé est toujours disponible. A
- Q11. Le budget est composé de l'intéressement et du fonctionnement. B
- Q12. Le fond de réserve du centre correspond à la somme réellement à la banque après le monitoring. B
- Q13. Les ressources propres dans la gestion financière d'un ESPC constituent 55% des recettes du livret de recettes et de dépenses. A
- Q14. Tous les dépôts d'argent à la PSP y compris ceux non justifiés par des reçus de versements sont pris en compte dans la somme à budgétiser. B

QCM

Q1. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent les recettes brutes des ESPC

- A- La vente des vaccins B- Les actes de santé C- La vente des carnets de santé
D- La vente des seringues de vaccination E- La vente des médicaments essentiels
F- La vente des TDR de paludisme

Q2. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des actes réguliers faisant droit à des recettes brutes

- A- Les consultations et soins curatifs B- Les consultations prénatales
C- Les accouchements D- Les pansements E- Les injections
F- La vente des seringues de vaccination G- La vente des boîtes de sécurité
H- La vente des tests de grossesse

Q3. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont exclus des ressources propres d'ESPC

- A- Les dons B- Le fond d'aide social C- L'intéressement du personnel
D- Le salaire du personnel de soutien E- Les legs F- Le coût des actes de santé

Q4. Le FAS signifie :

- A- Fonds d'aide social B- Fonds d'action sociale C- Fonds d'aide sanitaire

Q5. Le FAS représente

- A- 10% des recettes brutes B- 10% des ressources propres C- 10% du fonds de réserve

Q6. Le FAS des ESPC est transmis au district sanitaire :

- A- Chaque mois B- Chaque trimestre C- Chaque semestre

Q7. Le FAS des ESPC est :

- A. Une sorte d'impôt prélevé sur les recettes brutes des ESPC
B. Une motivation que le comité de gestion verse au personnel fonctionnaire
C. C'est la paie du personnel d'aide et de soutien recruté par le COGES

Q8. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont inclus dans l'investissement

- A- Salaire du personnel journalier B- Achat de mobylettes C- Achat de réfrigérateur
D- Entretien des courants des locaux E- Construction d'un hangar pour la vaccination
F- Achat de fournitures et administratives

Q9. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont inclus dans le fonctionnement

- A- Entretien du matériel et du mobilier B- Achat de mobylettes
C- Construction d'un hangar pour la vaccination D- Paiement des factures d'eau et d'électricité.
E- Achat de bouteilles de gaz pour les réfrigérateurs F- Achat de réfrigérateur

Q10. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent des rubriques d'élaboration du budget d'un ESPC

- A- Les ressources brutes B- Le fonds de réserve C- Les agios D- Les intérêts
E- La somme à budgétiser F- Les dépenses obligatoires
G- Les dépenses de fonctionnement locales

Q11. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent des dépenses obligatoires d'un ESPC

- A- Frais d'entretien des locaux B- Achat des médicaments génériques
C- Achat des outils de collecte des données D- Frais d'entretien de la moto du centre
E- Paiement des factures d'électricité F- Achat de chaises

Q12. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent des dépenses de fonctionnement local d'un ESPC

- A- Frais de savon pour l'hygiène B- Achat des médicaments génériques
C- Achat des outils de collecte des données D- Achat d'emballage du petit matériel
E- Paiement des factures d'électricité F- Achat de serrures

Q13. Les dépenses définies pour l'immeuble ne doivent pas excéder :

- A. 10% des fonds alloués à la rubrique des dépenses obligatoires.
B. 10% des fonds alloués à la rubrique des dépenses de fonctionnement local.
C. 5% des dépenses de fonctionnement local.

Q14. Les dépenses définies pour les imprévus ne doivent pas excéder :

- A. 10% des fonds alloués à la rubrique des dépenses obligatoires.
B. 10% des fonds alloués à la rubrique des dépenses de fonctionnement local.
C. 5% des dépenses de fonctionnement local.

Q15.La somme à budgétiser est composée :

- A-Des dépenses obligatoires B-Du fond de réserve
C- Des dépenses de fonctionnement local D-Des intérêts

Q16.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui relèvent de l'investissement

- A-achat de mobylette B-paiement du salaire du personnel non pris en charge par l'Etat ;
C-achat de réfrigérateur D-entretien courant des locaux E-contruction de préau pour la vaccination
F-achat des fournitures techniques et administratives

Q17.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui relèvent du fonctionnement

- A-achat de mobylette B-achat de réfrigérateur C- entretien courant des locaux

D-paiement du salaires du personnel non pris en charge par l'Etat ;

E-contruction de préau pour la vaccination

achat des fournitures techniques et administratives

Q18.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui entrent dans l'élaboration du budget d'un ESPC :

- A-la somme à budgétiser B- les dépenses incompressibles C-les agios

D-les dépenses de fonctionnement local E-les intérêts

Q19.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont les composantes du budget d'un ESPC

- A-L'investissement B- Les dons C- Les legs D- Le fonctionnement

Q20.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent la rubrique de l'investissement

A. Paiement des salaires du personnel non pris en charge par l'Etat

- A-Achat de mobylette B- Achat de réfrigérateur C- Entretien courant des locaux

D- Paiement de facture d'eau

Q21.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent la rubrique de fonctionnement :

A. Construction d'un hanger pour la vaccination par exemple.

B. Achat de fournitures techniques et administratives

C. Achat de bouteille de gaz pour les réfrigérateur

Q22.Le fond de réserve :

A. Ne contient pas les intérêts liés au revenu de l'ESPC

B. Contient les agios liés au revenu de l'ESPC

C. est le solde du centre à la date du monitoring non compris les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring.

Q23.Lorsque la somme à la banque comprend les agios et les intérêts, pour calculer le montant du fond de réserve :

- A-On n'y ajoute rien B- On y retire les agios C- On y ajoute les intérêts

D- On y ajoute les agios E- On n'y retire rien

Q24.Lorsque la somme à la banque comprend les agios sans les intérêts, pour calculer le montant du fond de réserve :

- A-On y retire les intérêts B- On y retire les agios C- On y ajoute les intérêts

D- On y ajoute les agios E- On n'y retire rien F- On n'y ajoute rien

Q25. Lorsque la somme à la banque comprend les intérêts sans les agios, pour calculer le montant du fond de réserve :

A- On n'y ajoute rien B- On y retire les intérêts C- On y retire les agios

D- On y ajoute les intérêts E- On y ajoute les agios F- On n'y retire rien

Q26. Lorsque la somme à la banque ne comprend ni les intérêts ni les agios, pour calculer le montant du fond de réserve :

A- On n'y ajoute rien B- On y retire les intérêts C- On y retire les agios

D- On y ajoute les intérêts E- On y ajoute les agios F- On n'y retire rien

CHAPITRE 14 : ORGANISATION DE LA REFERENCE/CONTRE REFERENCE**QCD**

Q1.L'ESPC est aussi appelé établissement de premier recours. B

Q2.la référence est le fait que le prestataire de soins d'un établissement sanitaire de premier recours amène le malade dans un établissement Sanitaire de Premier Contact (ESPC) quand son état nécessite un plateau plus fourni. B

Q3.La contre-référence est le retour du patient dans l'établissement de premier recours pour la poursuite de son traitement. B

Q4.Le but de la référence est d'assurer la prise en charge la plus adéquate du malade en vue de lui offrir des soins les plus adaptés et les plus qualifiés.

Q5.Pour décider de la contre-référence, le prestataire de soins se sert de l'ordinogramme pour décider de la référence. B

Q6.Au retour du malade dans le centre d'origine, le prestataire de soins de l'ESPC se base sur les informations mentionnées sur la fiche de référence pour continuer les soins. B

Q7.Si l'état de santé du malade requiert un plateau technique plus élevé (CHR ou CHU), un autre système de contre-référence est organisé au niveau de l'hôpital. B

QCM

Q1.Parmi les actions suivantes, indiquez celles que doit mener le prestataire de l'ESPC

- A. Informer le malade de la nécessité de la référence
- B. Convaincre les accompagnants du malade de la nécessité de la contre-référence
- C. Remplir la fiche de référence tout en mentionnant le caractère **urgent ou non** de la référence
- D. Remettre au malade ou aux accompagnants la fiche de contre-référence avec des consignes
- E. Inscrire dans la colonne conduite à tenir du registre de consultation la date de la référence
- F. Inscrire dans la colonne conduite à tenir du registre de consultation l'heure de la contre-référence.
- G. Avertir en cas de référence urgente, le service de premier recours.

Q2.Parmi les actions suivantes, indiquez celles que doit mener le prestataire de l'établissement sanitaire de référence

- A. Remplir la partie référence de la fiche
- B. Détacher la partie contre-référence de la fiche et la remet au malade ou à ses compagants
- C. Rassurer le malade sur la prise en harge et sa probable guerison
- D. Demander au malade de retourner au centre de premier recours pour poursuivre le traitement.
- E. remplir le dossier de synthèse du malade à l'aide des informations de la fiche de référence.

Q3. Parmi les facteurs suivants indiquez ceux à prendre en compte en cas de référence

A- l'environnement socioculturel du malade.

B- la capacité financière du malade ou de ses accompagnants pour faire face aux dépenses imprévues

C- le sexe du malade D- l'ethnie du malade E- le lieu d'habitation du malade

F- le temps à mettre pour atteindre le centre de référence

Q4. Pour décider de la référence, le prestataire de soins tient compte :

A- de l'ordinogramme B- moyens financiers dont dispose son supérieur hiérarchique

C- de l'avis de son supérieur hiérarchique D- de la capacité du service d'accueil

E- Au registre de consultation

CHAPITRE 15 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COGES

- Q1. Dans son rôle de gestion en dehors du centre de santé, le COGES doit promouvoir la participation financière de l'Etat. A
- Q2. Dans son rôle de gestion des ressources humaines, le comité de gestion doit veiller au savoir-faire du personnel de santé. B
- Q3. La participation aux activités du COGES est intéressée par le versement d'émoluments mensuels aux membres. B
- Q4. Les membres du COGES sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable. B
- Q5. Dans son rôle de gestion financière, le COGES décide du montant de la participation financière des communautés villageoises jusqu'à la hauteur qu'il juge utile. A
- Q6. L'infirmier, la sage-femme ou le travail social sont membres de droit de santé du COGES. A
- Q7. La durée maximale du mandat d'un membre du COGES est de 3 ans. A
- Q8. La participation aux activités du COGES n'est pas rémunérée. A
- Q9. Le cahier des comptes rendus des différentes réunions du COGES fait partie des outils de gestion des responsables de la gestion administrative et technique du comité de gestion. A
- Q10. Le comité de gestion est composé de 12 à 20 personnes représentant les communautés villageoises bénéficiaires des prestations de la structure sanitaire. A
- Q11. Le paiement du salaire du personnel de la structure de santé est inscrit dans les dépenses du comité de gestion. B
- Q12. Les legs sont des sources de revenus du COGES. A
- Q13. Les membres du COGES sont pris en compte par les primes d'intéressement de la structure de santé. B
- Q14. Tous les membres du COGES sont issus de la communauté. B

QCM

Q1. Le membre du bureau du COGES qui n'est pas élu est :

- A- Le président B- Le trésorier C- Les commissaires aux comptes D- **Le secrétaire général**

Q2. Le mandant des membres du COGES d'un établissement sanitaire de premier contact est de :

- A- Deux ans renouvelables B- **Trois ans renouvelables** C- Quatre ans renouvelables
D- Cinq ans renouvelable

Q3. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez deux sources de revenus du COGES.

- A- Les subventions de l'Etat B- **Le coût des actes de santé** B- **Les dons**
C- Le budget général de fonctionnement

Q4.Les recettes du comité de gestion d'un ESPC sont issues :

- A-des dons et legs B- de la vente des médicaments C- des coûts des actes de santé
D-des subventions de l'Etat

Q5.Quel est le membre du bureau du COGES qui n'est pas élu ?

- A-Le président B- Le trésorier C- Les commissaires aux comptes.
D- Le secrétaire général

Q6.Le comité de gestion d'un ESPC est composé de :

- A.10 à 20 personnes représentant les communautés bénéficiaires des prestations.
B.12 à 20 personnes représentant les communautés bénéficiaires des prestations.
C.10 à 15 personnes représentant les communautés bénéficiaires des prestations.

Q7.Parmi les outils de gestion ci-dessous présentés, indiquez trois utilisés par le responsable de la gestion administrative et technique :

- A.les registres du système d'informations et de gestions
B.le cahier de versement journalier du centre ;
C.les reçus des sommes confiées au président du COGES
D.le plan des bâtiments du centre de santé ;
E.le cahier des comptes rendus des différentes réunions du COGES.
F.l'inventaire de tous les produits utilisés au centre

Q8.Parmi les outils de gestion ci-dessous présentés, indiquez trois utilisés par le responsable de la gestion financière.

- A.un livret d'ouverture de compte d'épargne;
B.le livret de caisse pour noter chaque fois les entrées et les sorties de fonds ;
C.les carnets mères-enfants vendus ;
D.les justificatifs des fonds déposés dans le compte ;
E.le budget de fonctionnement assuré par l'état.

Q9. Parmi les activités proposées indiquez deux qui relèvent du responsable de la gestion financière du COGES.

A. recueillir à la fin de chaque journée de travail, les sommes d'argent collectées par le personnel de santé ;

B. enregistrer les dépenses du centre de santé dans le livret de caisse ;

C. faire à la fin de chaque journée le cumul des sommes versées à la banque ainsi que celui des dépenses effectuées ;

D. établir le bilan de la gestion financière du centre de santé, donner une copie au président et déposer une autre copie au district

E. diriger les activités de supervision avec les autres membres du comité gestion

Q10. Parmi les activités proposées, indiquez outre sa fonction, deux qui relèvent du Responsable de la gestion administrative et technique du COGES.

A. Assurer les tâches du secrétariat du COGES

B. Convoquer les réunions du comité de gestion en accord avec le trésorier et rédige les procès-verbaux

C. Établir avec le comité de gestion, les priorités d'investissement et de fonctionnement en tenant compte des problèmes sanitaires de la localité et des activités planifiées

D. Élaborer le budget du centre de santé à partir des ressources propres.

GESTION DE L'INFORMATION SANITAIRE

- Q1. Chaque mois, les prestataires de soins des CSU remplissent deux exemplaires des rapports mensuels d'activités qu'ils déposent au district sanitaire dont ils dépendent. B
- Q2. Dans la gestion de l'information sanitaire, le rapport de type A est le rapport annuel des structures sanitaires rurales. B
- Q3. L'analyse des données sanitaires est un jugement de valeur porté sur les données collectées. A
- Q4. L'information est produite à partir des indicateurs. A
- Q5. L'information sanitaire est gérée par le personnel de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire nationale sauf le niveau central. B
- Q6. L'information sanitaire est toute donnée qui se rapporte aux différentes composantes du système de santé. B
- Q7. L'information sanitaire peut être utilisée pour assurer la surveillance épidémiologique. A
- Q8. L'information sanitaire peut être utilisée pour mener le monitoring des activités des structures de santé. A
- Q9. L'interprétation des données sanitaires consiste à donner une explication aux tendances que présentent les données collectées. A
- Q10. L'usage de la fiche de rapport de morbidité hebdomadaire permet de gagner du temps. A
- Q11. L'usage de la fiche de rapport de morbidité quotidienne dans la gestion de l'information sanitaire permet de réduire les erreurs. A
- Q12. La collecte des données sanitaires consiste à enregistrer toutes les données sanitaires dans les fiches de rapports. B
- Q13. La collecte des données sanitaires consiste à enregistrer toutes les données sanitaires dans les registres d'activités. A
- Q14. La collecte des données sanitaires est aussi appelée compilation des données. B
- Q15. La fiche de rapport est un outil de compilation des données sanitaires individuelles. B
- Q16. La gestion de l'information sanitaire est le système par lequel l'information sanitaire est produite à chaque niveau de la pyramide sanitaire. B
- Q17. La prévalence du paludisme est une donnée sanitaire. A
- Q18. La promptitude dans la transmission des données consiste à faire parvenir les rapports d'activités aux services destinataires avant la date limite de transmission fixée. B
- Q19. La rétro information est le retour de l'information produite exclusivement vers les structures de prestation de soins. B

- Q20.La transmission des rapports d'activités sanitaires au district sanitaire se fait suivant deux délais précis et différents. A
- Q21.La transmission des rapports d'activités sanitaires se fait du versant gestionnaire au versant prestataire de la pyramide sanitaire ivoirienne. B
- Q22.La transmission des rapports mensuels d'activités sanitaires au district sanitaire se fait suivant un seul délai bien précis. B
- Q23.Le nombre de consultations prénatales constitue une donnée sanitaire. A
- Q24.Le rapport annuel A3 du CSU est mensuellement transmis au district sanitaire avant le 30 janvier de l'année suivante. B
- Q25.Le rapport annuel C2 du CHR est mensuellement transmis à la direction régionale de la santé au plus tard le 30 janvier de l'année suivante. B
- Q26.Le rapport mensuel B1 de l'Hôpital général est transmis chaque mois à la Direction régionale de la santé avant le 10 du mois suivant. B
- Q27.Le système de gestion de l'information sanitaire ivoirien se nomme SIGE. B
- Q28.Le taux d'incidence est un indicateur de santé. A
- Q29.Le taux de promptitude est d'autant moins important que les services de santé envoient les rapports hors délais . A
- Q30.Le taux de complétude peut être important même si les services ne transmettent pas les rapports dans les délais requis. A
- Q31.Le taux de promptitude est d'autant moins important que les services transmettent les rapports dans les délais requis. B
- Q32.Le traitement des données consiste à se servir des données pour prendre des décisions de gestion. B
- Q33.Le traitement des données ne peut se faire qu'avec les outils informatiques. B
- Q34.Les archives des rapports d'activités peuvent être détruites dès que leur année de production est écoulée. B
- Q35.Les délais de transmission des rapports A et A3 sont respectivement le 5 du mois suivant et le 30 janvier de l'année en cours. B
- Q36.Les données sanitaires peuvent être des proportions. B
- Q37.Les premiers rapports D1 de l'année 2020 ont été transmis par les directions départementales de la santé à leurs directions régionales sanitaires respectives au plus tard le 10 Avril 2021. B
- Q38.On peut enregistrer un taux de complétude de 0% et avoir 100% de promptitude. B
- Q39.Un bon taux de promptitude n'augure pas forcément d'un bon taux de complétude. B
- Q40.Un bon taux de promptitude traduit forcément un bon taux complétude. A

Q41.Un indicateur est une variable quantitative et qualitative simple qui mesure un aspect d'une intervention de santé. B

Q42.Un système d'information sanitaire est un processus par lequel la production de l'information sanitaire se fait. B

QCM

Q1.RASS signifie :

- A.rapport annuel sur le système de santé B.résumé annuel de la situation sanitaire
C.rapport annuel sur la situation sanitaire D.rapport annuel sur le système sanitaire

Q2.Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des supports individuels de gestion de l'information sanitaire:

- A.le carnet de santé B.le registre de CPN C.la fiche de rapport mensuel
D.la fiche de référence et de contre référence E.les fiches de comptage des doses de vaccins

Q3.Parmi les éléments suivants identifier ceux qui sont des fonctions du registre

- A.un aide-mémoire du praticien B.un outil d'analyse des données
C.un outil de traitement des données D.une base de données. E.un outil de compilation des données

Q4.Quel est l'ordre normal du processus de gestion de l'information sanitaire ?

- 1.Collecte des données 2. traitement des données 3. compilation des données
4.Analyse et interprétation des données 5. Utilisation des données 6. Transmission des données
7.Retro-information 8.Diffusion de l'information
A.(1,2,3,4,5,6,7,8) B.(1,3,2,5,4,6,7,8) C(1,3,6,2,4,5,7,8) D.(1,3,4,2,5,6,7,8)

Q5.Parmi les éléments suivants, identifiez ceux qui sont des d'outils de traitement des données sanitaires :

- A-Les carnets individuels de santé B-les ordinateurs C- Les registres d'activités
D-les calculatrices E- les logiciels F- les fiches de rapports mensuels et annuels

Q6.Parmi les éléments suivants identifiez ceux qui sont des supports d'information individuelle

- A-les fiches de rapport mensuels d'activités B- le carnet de santé
C- la fiche de référence et de contre référence D- les registres d'activités ;
E- les fiches de rapports mensuels d'activité

Q7. Parmi les étapes suivantes, indiquez celles qui ne concernent pas la gestion des données dans un centre de santé rural :

A- Enregistrer les données dans les registres d'activités

B- Commander les fiches de rapport B1 au district sanitaire

C- Transmettre les fiches de rapports à la direction régionale de la santé

D- Traiter les données sanitaires E- Analyser et interpréter les données sanitaires

F- Utiliser l'information produite pour prendre des décisions

Q8. CSE signifie :

A. Centre de secours épidémiologique B. Centre de surveillance épidémique

D. Centre de secours épidémiologique **E. Centre de surveillance épidémiologique**

Q9. Le taux de promptitude de transmission des fiches de rapport d'un centre de santé au 25 avril 2024 est :

A. Le nombre de fiches de rapports A transmis à la Direction régionale au plus tard le 10 Avril 2024

B. Le nombre de fiches de rapports A transmis au District sanitaire au plus tard le 10 Avril 2024

C. Le nombre de fiches de rapports B1 transmis au district sanitaire au plus tard le 10 mars 2024

D. La proportion des fiches de rapport A transmis au district sanitaire au plus tard le 5 Avril 2024.

Q10. Indiquer l'ordre normal le circuit de l'information sanitaire produite dans un CSU :

1. CSU

2. Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique

3. DIS

4. District sanitaire

5. Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et la Couverture Maladie Universelle

A. 12435 **B. 14235** C. 14325 D. 12354

Q11. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des indicateurs quantitatifs

A- le taux de mortalité infantile B- le nombre de malades de paludisme

C- le sexe D- l'ethnie E- **le taux de natalité**

Q12. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des outils de compilation des données

A- Registre d'accouchement B- **Fiche de rapport annuel** C- **Fiche de rapport mensuel**

D- Registre de vaccination E- Carnet individuel de consultation

Q13. L'utilisation des données vise à :

A. porter un jugement de valeur sur les données collectées ;

B. identifier les causes des goulots d'étranglement

C. proposer des solutions pour lever les goulots d'étranglement

Q14. Parmi les actions suivantes, identifier ceux qui concerne l'utilisation de l'information sanitaire :

A- porter un jugement de valeur sur les données collectées

B- planifier les activités pour améliorer une situation C- assurer la surveillance épidémiologique

D- vérifier la qualité des données collectées

Q15. Parmi les services suivants, identifiez ceux qui assurent l'enregistrement des données sanitaires.

A- EPHD B- Dispensaire Rural C- District sanitaire E- Direction régionale

F- EHPR G- EPHN H- DIS

Q16. Parmi les services suivants, identifiez ceux qui transmettent les fiches de rapports mensuels avant le 15 du mois suivant

A- Direction régionale B- EPHD C- Direction départementale D- CSU

E- Dispensaire Rural F- EPHR

Q17. Parmi les services suivants, identifiez ceux qui transmettent les fiches de rapports mensuels après le 10 du mois suivant

A- Direction régionale B- EPHD C- Direction départementale

D- Dispensaire Rural E- CSU F- EPHR

Q18. Parmi les tranches d'âges suivantes, identifiez celles qui concernent la compilation des données sanitaires pendant le remplissage des fiches de rapport :

A- 0 à 23 mois B- 1 à 3 ans C- 4-14 ans D- 15 ans et plus

Q19. Parmi les fiches suivantes, identifiez celles qui sont remplies par semaine :

A- La fiche de comptage de morbidité B- La fiche de comptage de l'accouchement

C- La fiche de comptage des consultations pré et post-natales D- La fiche de comptage du cabinet dentaire

Q20. Parmi les fiches suivantes, identifiez celles qui sont remplies journalièrement :

A- La fiche de comptage de morbidité B- La fiche de comptage de la réhydratation

B- La fiche de comptage du cabinet dentaire C- La fiche de comptage pour la CCC

Q21. Le système de gestion de l'information sanitaire ivoirien utilise :

A- 2 fiches de rapports d'activités B- 6 fiches de rapports d'activités

C- 8 fiches de rapports d'activités D- 9 fiches de rapports d'activités

Q22. Le système de gestion de l'information sanitaire ivoirien utilise :

A- 2 types de fiches de rapports d'activités B- 4 types de fiches de rapports d'activités

C- 6 types de fiches de rapports d'activités

Q23.Le système de gestion de l'information sanitaire ivoirien utilise :

- A-2 fiches de rapports mensuels d'activités B-3 fiches de rapports mensuels d'activités
C-6 fiches de rapports mensuels d'activités D-8 fiches de rapports mensuels d'activités

Q24.Le système de gestion de l'information sanitaire ivoirien utilise :

- A-1 fiche de rapport annuel d'activités B-3 fiches de rapports annuels d'activités
C-2 fiches de rapports trimestriels d'activités D-6 fiches de rapports mensuels d'activités

Q25.Parmi les propositions ci-dessous, cochez celles qui font pas partir des étapes du processus de génération de l'information sanitaire

- A-La complétude des données B-la compilation des données sanitaires
C-La collecte des données sanitaires D-La promptitude des rapports

Q26.Le nombre de fiche de rapports mensuels que chaque structure de santé doit commander par trimestre est de :

- A-12 B-24 C-02 D-06

Q27.Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des outils de compilation des données

- A-Les fiches de rapports mensuels et annuels B- Les carnets de consultation
C-les logiciels D- Les registres d'activités E- les fiches de rapports annuels d'activités
F-les calculatrices

Q28.Indiquer l'ordre normal des étapes de gestion de l'information sanitaire :

- 1.Enregistrer les données sanitaires dans les registres
2. compiler les données sanitaires sur les fiches de rapport
3. analyser et interpréter les données sanitaires
- 4.transmettre les données aux différents niveaux concernés de la pyramide sanitaire
- 5.traiter les données sanitaires
6. diffuser l'information sanitaire
7. faire la rétro-information
- 8.utiliser l'information produite

- A.12345678 B.1245687 C.12453867 D.12358467 E.12354687

Q29. Le circuit de l'information sanitaire entre le CSR et la DIS est :

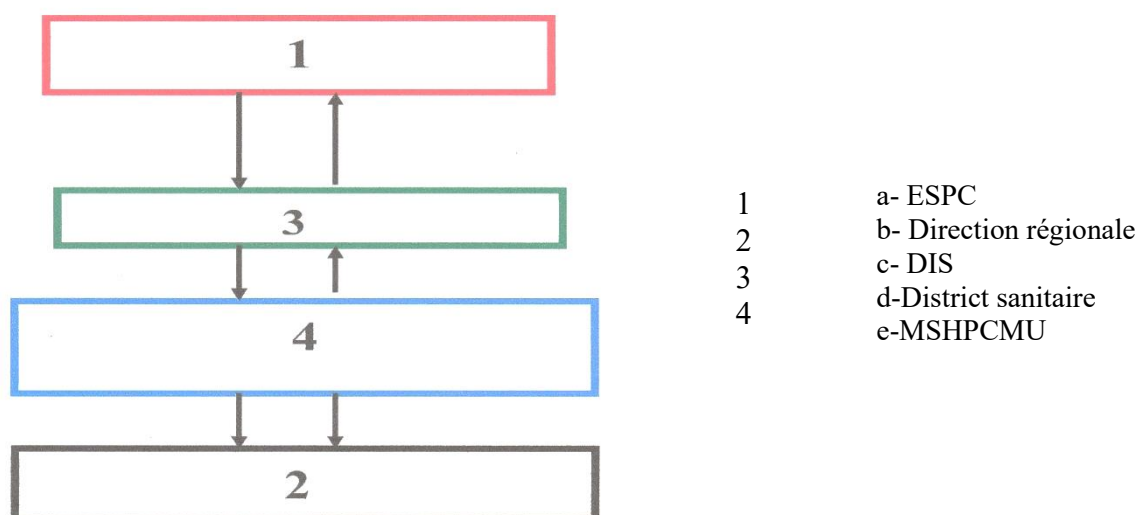
1. CSR
2. Direction régionale
3. District sanitaire
4. DIS

Quelle est la bonne réponse ?

- A. (1,2,3,4) **B. (1,3,2,4)** C. (1,2,4,3)

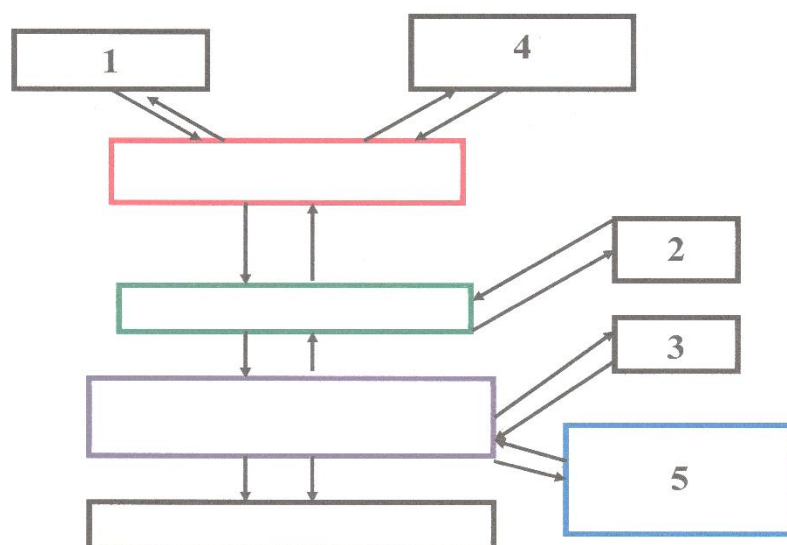
Q30. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des outils de collecte des données :

- A- Les fiches de rapports mensuels et annuels B- **Les carnets de consultation**
C- les logiciels D- **Les registres d'activités**; E- les ordinateurs D- les calculatrices



- A (1,c) **B(3,d)** C (2,e) D **(2,c)** E**(1,a)** E(1,b) **F(4,b)**

Q31. A partir du schéma du circuit de l'information sanitaire du CSR ci-dessus, faites correspondre les numéros aux lettres indiquant les structures.



Q32. A partir du schéma du circuit de l'information sanitaire ci-dessus, faites correspondre les numéros aux lettres indiquant les structures.

- | | |
|---|---------|
| 1 | a- EPHR |
| 2 | b- EPHD |
| 3 | c- ONG |
| 4 | d- EPHN |
| 5 | e- ESPC |

A (1, c) B(4, b) C (1,e) D (4,e) E(2,a) F(3,d) G(5,c) H(2,e) I(3,d)

CHAPITRE 17 : GESTIONS DES CATASTROPHES NATURELLES/EPIDEMIES

- Q1. Apporter un soutien psychologique à la communauté victime de la catastrophe est un rôle de l'infirmier ou de la sage-femme dans la gestion d'une catastrophe. A
- Q2. Construire des habitats aux sinistrés est un rôle de l'infirmier ou de la sage-femme dans la gestion d'une catastrophe. B
- Q3. Donner rapidement l'alerte au directeur départemental de la santé est un rôle de l'infirmier ou de la sage-femme dans la gestion d'une catastrophe. A
- Q4. L'épidémie est une conséquence sociale des catastrophes. B
- Q5. La détérioration des infrastructures est une conséquence sociale des catastrophes. A
- Q6. La gestion des catastrophes vise à réduire l'effet négatif ou les conséquences d'événements indésirables contre lesquels l'homme peut maîtriser les effets néfastes. B
- Q7. La guerre est une catastrophe naturelle. B
- Q8. La vulnérabilité est la probabilité selon laquelle il y aura des pertes en conséquence d'un événement défavorable. B
- Q9. Le cyclone est une catastrophe naturelle. A
- Q10. Le génocide n'est pas une catastrophe naturelle. A
- Q11. Le grave accident de la voie publique est une catastrophe naturelle. B
- Q12. Le risque est le point auquel l'organisation d'une collectivité, d'un environnement et de services va probablement subir des dommages ou être perturbés par l'impact d'un danger. B
- Q13. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. A
- Q14. Le tsunami n'est pas une catastrophe naturelle. B
- Q15. Les maladies nutritionnelles sont des conséquences sociales des catastrophes. B
- Q16. Les pertes d'habitation sont des conséquences sociales des catastrophes. A
- Q17. Perturbation du mode de vie des populations est une conséquence sanitaire des catastrophes. B
- Q18. Prendre des photos du site de la catastrophe est un rôle de l'infirmier ou de la sage-femme dans la gestion d'une catastrophe. B
- Q19. Toute situation d'urgence est une catastrophe. B
- Q20. Un danger est le potentiel d'un événement causé par l'homme capable d'entraîner des conséquences négatives A
- Q21. Un danger est le potentiel d'un événement naturel capable d'entraîner des conséquences négatives. A
- Q22. Un décès consécutif aux inondations est une conséquence sanitaire des catastrophes. A

Q23. Une catastrophe est une situation d'urgence. A

Q24. Une catastrophe qui dépasse le contrôle devient une situation d'urgence. B

Q25. Une situation d'urgence est une situation où la société ne peut pas faire face à un événement indésirable. B

Q26. Une situation d'urgence qui dépasse le contrôle de la population, devient une catastrophe. A

Q27. Une situation de catastrophe est une situation dans laquelle la société est capable de faire face à un événement indésirable. B

QCM

Q1. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui constituent des différentes catastrophes naturelles :

A- La guerre B- Les cyclones C- Les tremblements de terre D- Le tsunami

E- Les graves accidents de circulation F- Les génocides

Q2. Parmi les éléments suivants, identifiez les rôles de l'infirmier ou la sage-femme dans la gestion d'une catastrophe dans son aire sanitaire

A. Construire des habitats aux sinistrés

B. Donner rapidement l'alerte au directeur départemental de la santé

C. Prendre des photos du site de la catastrophe

D. Apporter un soutien psychologique à la communauté victime de la catastrophe

E. Décrire aux sinistrés, la différence entre une situation de catastrophe et une situation d'urgence.

Q3. Le rôle de l'infirmier et de la sage-femme dans la gestion des catastrophes dans leur aire de santé consiste à :

A- Donner l'alerte en informant les secours d'urgence.

B- Apporter un soutien psychologique à la communauté victime de la catastrophe.

C- Apporter un soutien médical à la communauté.

D- Donner l'alerte en informant le Directeur Départemental pour organiser les secours.

CHAPITRE 18 : LA SUPERVISION

- Q1.En matière de supervision, la correction peut se faire en différé. A
- Q2.L'acteur qui exécute la supervision est un collègue. B
- Q3.L'acteur qui exécute la supervision est un supérieur hiérarchique. A
- Q4.La correction immédiate vise à corriger les déficiences constatées. A
- Q5.La correction immédiate vise à proposer un plan de formation au supervisé . B
- Q6.La supervision a pour cible le matériel. B
- Q7.La supervision a pour cible le personnel en activité. A
- Q8.La supervision a pour entre autres issues, l'amélioration de la compétence du personnel. A
- Q9.La supervision a pour entre autres issues, l'harmonisation de l'exécution des activités. B
- Q10.La supervision permet au supervisé d'être stimulé. A
- Q11.La supervision permet au supervisé de se rendre compte de la manière dont les tâches déléguées sont exécutées. B
- Q12.La supervision permet au superviseur de se rendre compte de la manière dont les tâches déléguées sont exécutées. A
- Q13.La supervision se fait à l'improviste. B
- Q14.La supervision se fait de façon annoncée. A
- Q15.La supervision se fait de façon périodique. A
- Q16.La supervision se fait de façon ponctuelle. B
- Q17.Le style laisser-faire de supervision favorise l'esprit d'initiative. B
- Q18.Le style autocratique de supervision aide à prendre des décisions. B
- Q19.Le style autocratique de supervision induit une sensation de frustration chez le supervisé. A
- Q20.Le style autocratique de supervision induit une sensation de manque de confiance chez le supervisé. A
- Q21.Le style autocratique de supervision induit une sensation de satisfaction chez le supervisé. B
- Q22.Le style autocratique de supervision s'applique aux situations d'urgence qui exigent une prise de décision sans délai. A
- Q23.Le style autocratique de supervision s'applique aux situations de recherche en présence d'un agent compétent. B
- Q24.Le style démocratique de supervision aide à prendre des décisions. A
- Q25.Le style démocratique de supervision favorise la négligence des tâches importantes. B
- Q26.Le style démocratique de supervision s'applique à toutes les situations. B

- Q27. Le style laisser-faire de supervision aide à prendre des décisions. B
- Q28. Le style laisser-faire de supervision favorise la négligence des tâches importantes. A
- Q29. Le style laisser-faire de supervision s'applique aux situations d'urgence. B
- Q30. Le style laisser-faire de supervision s'applique aux situations de recherche en présence d'un agent consciencieux. A
- Q31. Le superviseur ayant le style autocratique cherche à tout comprendre. A
- Q32. Le superviseur ayant le style autocratique délègue les responsabilités. B
- Q33. Le superviseur ayant le style démocratique a pour soucis de contenter tout le monde. A
- Q34. Le superviseur ayant le style démocratique a pour soucis de contenter tout le monde. B
- Q35. Le superviseur ayant le style laisser-faire cherche à tout voir. B

QCM

Q1. La supervision permet :

- A. de déceler chez l'agent supervisé des insuffisances
- B. de mesurer les résultats obtenus par l'agent supervisé
- C. d'améliorer la qualité du travail accompli par l'agent supervisé
- D. d'apprécier la conscience professionnelle de l'agent supervisé

Q2. Les actions suivantes relèvent de la supervision sauf une seule, laquelle ?

- A. à former l'agent de santé
- B. soutenir les initiatives de l'agent de santé
- C. décourager les initiatives de l'agent de santé

Q3. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui constituent des buts de la supervision :

- A. La vérification de la ponctualité du personnel de santé au service
- B. La promotion de l'amélioration continue de la performance du personnel de santé
- C. L'assiduité du personnel de santé au service
- D. La promotion de l'esprit de stimulation de l'agent de santé
- E. La vérification de la possibilité l'atteinte des objectifs définis par un programme
- F. La courtoisie du personnel de santé avec les malades
- G. La vérification de la compétence du personnel de santé

Q4. Dans le style autocratique de supervision, le superviseur :

- A- cherche à tout voir B- cherche à tout savoir C- cherche à tout comprendre
- D- délègue pas de responsabilité E- ne confond pas autorité et domination
- F- donne des instructions générales G- surveille de près l'exécution des tâches.

Q5. Dans le style démocratique ou participatif

A- fait participer ses collaborateurs à la planification des activités et des projets.

B- aide à prendre des décisions. C- fait confiance à ses collaborateurs

D- reconnaît et encourage certaines initiatives prise par le supervisé. E- cherche à tout voir

F- surveille de près l'exécution des tâches.

Q6. Dans le style « laisser-faire » de supervision, le superviseur :

A- est autocratique B- fait confiance à ses collaborateurs

C- ne laisse pas faire les collaborateurs D- a pour souci de contenter tout le monde.

Q7. La supervision proprement dite comprend essentiellement :

A- L'observation B- La correction. C- La sanction D- Le contrôle

CHAPITRE 19 : SUIVI&EVALUATION DES PROGRAMMES/PROJET**QCD**

- Q1.L'acquisition de nouvelles connaissances font partie des effets des projets ou des programmes. A
- Q2.L'évaluation est un processus continu qui permet de mesurer les résultats obtenus. B
- Q3.L'évaluation initiale permet d'identifier les ressources disponibles pour réaliser le projet ou le programme. A
- Q4.L'évaluation initiale permet de décrire les facteurs de risque de la population. A
- Q5.L'évaluation permet d'identifier les goulots d'étranglement qui freine l'avancée du projet ou programme. B
- Q6.La diminution du taux de transmission d'une maladie est un indicateur d'effet. B
- Q7.Le budget alloué aux activités est un indicateur de résultats. B
- Q8.le nombre de motos achetées pour les activités est un indicateur d'extrants. B
- Q9.le nombre de sessions de formation organisées est indicateur d'extrants. B
- Q10.Le suivi d'un projet est un processus discontinue qui permet d'identifier les difficultés en vue de les corriger. B
- Q11.Le suivi est une activité qui permet de mesurer les résultats à court terme. B
- Q12.Le suivi et l'évaluation sont des démarches identiques mais complémentaires. B
- Q13.Les registres de gestion des stocks contiennent les données permettant de calculer les indicateurs d'intrants. A

QCM

Q1.Parmi les éléments suivants, identifier celui qui peut constituer un intrant en matière de suivi et évaluation des activités de soin :

A-le personnel soignant B- le nombre de séances de vaccination organisées

C- le nombre de kit d'IST distribuées

D-le nombre de femmes utilisant les méthodes contraceptives

Q2.Parmi les éléments suivants, identifiez les deux qui indiquent un processus

A-le taux d'utilisation des contraceptifs B- le dénombrement des populations cible

C-la commande des contraceptifs D- le nombre de femmes sensibilisées

E-le nombre de sages-femmes recrutées F- les fiches de stock des contraceptifs

Q3.Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des intrants :

A-Le personnel soignant B- Le nombre de séances de vaccination organisées

C- Le nombre de kit d'IST distribuées D- Le budget de réalisation du projet/programme

E- Le nombre de femmes utilisant les méthodes contraceptives

Q4. Parmi la question suivante, identifiez celle qui indique le suivi du processus

A. L'intervention prévue est-elle en cours de réalisation ?

B. Les bénéficiaires ont-ils changé de comportements ?

C. Les ressources ont-elles été bien utilisées ?

Q5. Parmi les éléments suivants, identifiez ceux qui indiquent un processus

A- le programme des activités B- le taux de couverture vaccinale

C- le taux d'abandon global de la vaccination D- la sensibilisation de la population

E- le dénombrement des populations cible F- la commande des vaccins

Q6. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui indiquent l'impact

A- le taux de natalité de la population B- L'intervalle intergénérisique

C- le nombre de séances de ccc D- le nombre de personnes sensibilisées

Q7. Le suivi des intrants permet de répondre aux questions suivantes :

A. Quelle est la valeur de l'argent qui a été dépensée ?

B. Combien de personnes ont-elles été dénombrées ?

C. Combien d'individus ont-ils travaillé pendant le projet ?

D. Combien de doses de vaccins ont-elles été commandées ?

E. Combien de doses de vaccins ont-elles été utilisées pendant le projet ?

Q8. Le suivi du processus permet de répondre aux questions suivantes :

A. L'intervention prévue a-t-elle été exécutée ?

B. L'activité a-t-elle été menée au moment prévu ?

C. Le chronogramme des activités a-t-il été bien suivi ?

D. les bénéficiaires sont-ils satisfaits ?

E. Les bénéficiaires ont-ils changé de comportements ?

A. les registres de consultations

Q9. Parmi les éléments suivants, identifiez ceux qui sont des extrants :

A- le nombre de séances de formation réalisées B- le nombre de femmes sensibilisées

C- le nombre de préservatifs distribués C- le budget de réalisation du projet

D- les registres de consultations

Q10. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des extrants :

A- Le nombre de séances de formation réalisées B- Le nombre de femmes sensibilisées

C- Les registres de consultations D- Le nombre de préservatifs distribués

E- Le budget de réalisation du projet

Q11. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui indiquent les effets

A- La couverture vaccinale mensuelle B- Le taux de prévalence des maladies cible du PEV

C- Le taux d'utilisation mensuelle des contraceptifs D- Le nombre de contraceptifs distribués

E- Le nombre de séances de consultations foraines

Q12.Le suivi des extrants permet de répondre aux questions suivantes :

A.Quels sont les services qui ont été fournis?

B.Combien d'individus ont-ils été servis?

C.Combien d'individus ont-ils travaillé pendant le projet?

D.Combien de doses de vaccins ont-elles été commandées ?

CHAPITRE 20 : ORGANISATION D'UNE SEANCE DE VACCINATION

- Q1.La détermination des stratégies vaccinales mise en œuvre dans une aire sanitaire se fait en fonction des moyens de déplacement du personnel de santé. B
- Q2.La stratégie mobile se fait par le personnel des centres de santé pour les populations vivant à plus de 15 kilomètre de leur structure sanitaire. B
- Q3.La zone d'attente d'un poste de vaccination est aussi appelée zone entrée. A
- Q4.La zone d'entrée doit être différente de la zone de sortie. A
- Q5.La zone d'entrée est le lieu où on administre les vaccins. B
- Q6.Le choix des jours, heures et lieux de vaccination se fait exclusivement par la population bénéficiaire. B
- Q7.Le dispositif de lavage des mains doit être disposé loin de la table de vaccination. B
- Q8.Le nombre de villages de l'aire sanitaire d'une structure de santé donnée où l'infirmier pratique la vaccination correspond au nombre de postes de vaccination de cette structure. B
- Q9.Le poste de travail doit permettre de travailler avec rapidité et gérer le flux des femmes. A
- Q10.Les données des différentes séances de vaccination effectuées pendant les stratégies mobiles sont prises en compte dans le calcul des différents taux de couverture du centre de santé le plus proche des localités où la vaccination a été faite. B
- Q11.Un vaccin ou un solvant ne doit pas être utilisé le jour où sa date de péremption est atteinte . B
- Q12.Un village où l'on pratique la vaccination peut être considéré comme un site de vaccination. A
- Q13.Sur un poste de vaccination, la zone d'attente n'est pas différente de la zone de sortie. B

QCM**Q1.Quel est l'ordre normal des étapes d'exécution d'une séance de vaccination ?**

1.IEC /CCC sur les MAPI 2.Enregistrement 3.tri 4.administration de vaccin

A.(1,2,3,4) B.(2,3,4,1) **B.(3,2,4,1)** C(2,4,3,1)

Q2.Les différentes stratégies vaccinales du PEV ivoirien sont :

A-La stratégie fixe **B- La stratégie avancée** C-la stratégie hyper avancée

D- la stratégie du porte à porte E- **La stratégie mobile.**

Q3.Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des outils d'administration des vaccins :

A-les accumulateurs de froid congelés **B-les seringues autobloquantes**

C-les seringues de 5 ml

D-le coton E- **les flacons compte-gouttes pour le VPO** F- le porte vaccin

Q4. Identifier parmi les tâches suivantes, celles qu'il faut exécuter à l'évaluation d'une séance de vaccination

- A. compter le nombre de doses de chaque type de vaccin administré B. détruire les déchets.
C. ranger les vaccins non utilisés D. Etiqueter les flacons ouverts et réutilisables
E. compter le nombre de doses restantes pour chaque type de vaccin
F. établir la liste de ceux qui n'ont pas répondu à leur rendez-vous.

Q5. Parmi les tâches suivantes, indiquez celles qui se déroulent au moment du tri au cours d'une séance de vaccination :

- A. la vérification des rendez-vous B. l'identification des cas de contre-indication vaccinales
C. IEC/CCC D. la fixation des rendez-vous E. la prise en charge des cas de MAPI

Q6. Identifier parmi les tâches suivantes, celles qu'il faut exécuter à la clôture d'une séance de vaccination :

- A. évaluer la séance de vaccination B. ranger les flacons utilisés dans le réfrigérateur
C. étiqueter les flacons ouverts et non réutilisables D. détruire les déchets

Q7. Les principaux canaux courants d'information des populations rurales sont :

- A-les groupes associatifs B-les groupes religieux C-les griots
D-les radios locales E-les radios étrangères F-les réseaux sociaux d'internet

Q8. Quels sont les éléments qui sont indispensables pendant l'information des populations avant l'organisation d'une séance de vaccination ?

- A- Les jours de la vaccination B- Les rôles des membres de l'équipe de vaccination
C- Les heures de vaccination D- Les noms des membres de l'équipe des vaccinateurs
E- Les lieux de vaccination F- La liste des matériels de vaccination

ETUDES DE CAS

ETUDE DE CAS N°1

Vous êtes en service au centre de santé rural de Djézoukro et pour améliorer vos activités de soins, vous avez mené une étude du milieu à l'issue de laquelle vous avez noté les informations suivantes :

- les populations ne disposent pas de latrines pour éliminer les selles et c'est la broussaille qui leur sert de lieu de défécation ;
- les femmes de la localité contractent les grossesses de façon trop rapprochée sans respect de l'intervalle intergénésiq ue requis ;
- 04 cas de rougeole ont été notifiés pendant les premier trimestre de l'année en cours ;
- Le centre de santé a connu une semaine de rupture en paracétamol.

Questions :

A partir des données du texte, cochez les bonnes réponses.

Q1.Quelles sont les composantes des SSP qui vont orienter vos actions pour améliorer la santé de la population de Djézoukro :

A.Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de santé auxquels la population est confrontée.

B.Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.

C.Approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base.

D.Protection maternelle et infantile y compris la santé de la reproduction et la planification familiale.

E.Vaccination contre les principales maladies infectieuses.

F.Prévention et la lutte contre les endémies locales.

G.Traitement des maladies et lésions courantes.

H.Fourniture en médicaments essentiels (modernes et traditionnels)

Q2.Que signifie intervalle intergénésiq ue

A. Le temps qui sépare l'accouchement d'un enfant à la reprise des rapports sexuels par la mère

B. Le temps qui sépare l'accouchement d'un enfant au retour des menstrues chez la mère

C. Le temps qui sépare deux grossesses consécutives

Q3.Quel est l'intervalle intergénésiq ue recommandé chez la femme en Côte d'Ivoire ?

A. 2 ans 4 ans 6 ans

ETUDE DE CAS N°2

A l'occasion d'un stage communautaire du 15 Mars au 20 Juin 2025 au CSR de Kongobo, vous entreprenez une étude du milieu dans ce village en vue d'établir un diagnostic communautaire. Cette étude du milieu vous révèle les informations suivantes :

- les habitants du village ne disposent pas de latrines et c'est la broussaille autour du village qui sert de lieu de défécation ;
- les ordures ménagères jonchent le village par manque de dépotoirs aménagés ;
- les habitats ne respectent pas toutes les conditions de salubrité recommandées ;
- les pathologies prédominantes enregistrées dans les rapports mensuels d'activités du CSR de Plibo sont le paludisme, la dysenterie amibienne, la dysenterie bacillaire, les infections respiratoires aiguës, le choléra, la fièvre jaune, l'onchocercose, la malnutrition, le goitre endémique, la carie dentaire, le saturnisme, la fluorose, fièvre typhoïde, les helminthiases, la poliomyélite,

Questions

Q1.Parmi les affections suivantes identifiez celles qui ne sont pas liées à un défaut de la composition chimique de l'eau :

- A. Carie dentaire B. Paludisme C. Saturnisme D. Fluorose
E. Fièvre jaune F. Choléra

Q2.Parmi les affections suivantes identifiez celles qui sont liées à la mauvaise qualité bactériologique de l'eau ?

- A. Carie dentaire B. Dysenterie bacillaire C. Onchocercose D. Dysenterie amibienne
E. Fièvre jaune F. Choléra

Q3.Parmi les maladies hydriques suivantes, identifiez celles qui sont des maladies parasitaires.

- A. La poliomyélite B. Les helminthiases C. La dysenterie amibienne
D. La dysenterie bacillaire

Q4.Parmi les maladies hydriques suivantes, identifiez celles qui sont des maladies virales :

- A. la poliomyélite B. Les helminthiases C. L'hépatite A D. la dysenterie bacillaire

Q5.Parmi les maladies suivantes, citez celles dont l'eau intervient dans le développement des vecteurs.

- A. Fièvre jaune B. Paludisme C. Onchocercose D. Choléra E. Fièvre typhoïde
F. Helminthiases

ETUDE DE CAS N°3

Vous êtes en service au Dispensaire rural de Sionfan dont la population totale de l'aire sanitaire est estimée à 10000 habitants au 31 Décembre 2024. Le taux d'accroissance annuel constant de cette population est de 2%.

Q1. Quel est l'effectif des enfants devant bénéficier du RR à la fin de l'année 2024 au dispensaire rural de Sionfan ?

- A. 400 B. 350 **C. 682**

Q2. Quel est le besoin théorique en RR pour la vaccination en routine en 2024 ?

- A. 890 B. 779 **C. 1517**

Q3. Quel est le besoin théorique en RR pour la vaccination en routine au premier trimestre de 2024 ?

- A. 380** B. 223 C. 195

Q4. Quel est le stock de sécurité en RR pour la vaccination en routine au premier trimestre de 2024 ?

- A. 49 B. 56 **C. 95**

Q5. Quel est le besoin réel en RR pour la vaccination en routine au premier trimestre de 2024 ?

- A. 474** B. 244 C. 278

Q6. Quelle est la quantité de vaccins RR à commander pour le premier trimestre de 2024 sachant qu'il reste dans votre réfrigérateur 40 doses de Penta au 31 Décembre 2023 ?

- A. 238 B. 204 **C. 434**

Q7. Quel est le nombre de flacons de RR commandés pour mener les activités de vaccination en routine au premier trimestre de 2024 sachant qu'un flacon de RR compte 10 doses ?

- A. 24 B. 21 **C. 44**

Q8. Quel est le nombre de seringues de 5cc nécessaires diluer les flacons de RR commandées au premier trimestre de 2024 ?

- A. 44** B. 24 C. 21

Q9. Quel est le besoin théorique en seringues de 2cc nécessaire pour administrer les vaccins de RR en routine pendant le premier trimestre de 2024 ?

- A. 185 B. 210 **C. 360**

Q10. Quel est le stock de sécurité en seringues de 2cc nécessaire pour administrer les vaccins de RR en routine pendant le premier trimestre de 2024 ?

- A. 36** B. 22 C. 19

Q11. Quel est le besoin réel en seringues de 2cc nécessaire pour administrer les vaccins de RR en routine pendant le premier trimestre de 2024 ?

- A. 232 B. 203 **C. 396**

Q12. Quel est la quantité de seringues de 2cc à commander pour administrer les vaccins de RR en routine pendant le premier trimestre de 2024 sachant que vous avez 5 seringues de 2cc en stock ?

- A. 391** B. 227 C. 198

Q13. Quel est le nombre seringues nécessaires pour réaliser les activités de vaccination de routine avec le RR au premier trimestre de l'année 2024 ?

- A. 219 B. 251 **C. 435**

Q14. Quel est le nombre de boîtes de sécurité nécessaire pour collecter les seringues utilisées pour administrer les vaccins en routine avec le RR au premier trimestre de l'année 2024 sachant qu'il reste en stock 02 boîtes de sécurité ?

- A. 4** B. 2 C. 1

ETUDE DE CAS N°4

Le CSR de Myan dessert une population de 6000 habitants en 2024.

Vous décidez d'évaluer les performances des agents de santé du CSR de Myan en matière de gestion des stocks de vaccins en 2024. Pour cela vous ciblez votre étude sur les stocks de RR et Penta. Le tableau ci-dessous présente les données de cette structure sanitaire au cours de l'année 2022.

Vaccins	CSR Myan	
	Doses sorties	Doses administrées
Penta1	230	225
Penta 2	220	215
Penta 3	210	205
RR1	200	198

Q1. Quel est le taux d'utilisation en Penta du CSR de Myan en 2024 ?

- A. 98,02% B. 97,61% **C. 97,72%**

Q2. Quel est le facteur de perte du Penta au CSR de Myan en 2024 ?

- A. 1,02** B. 1,11 C. 1,05

Q3. Quel est le taux d'abandon du Penta au CSR de Myan en 2024 ?

- A. **8,88%** B. 8,69% C. 8,90 %

Q4. Quel est l'effectif des enfants de 0 à 23 mois en 2024 à Myan ?

- A. 210 **B. 410** C. 420

Q5. Quel est le taux de couverture en Penta pour le centre de santé de Myan en 2024 ?

- A. 50,09%** B. 51,31% C. 48,38%

Q6. Quel est l'effectif des enfants à vacciner pendant une campagne de RR à Myan en 2024 ?

- A. 410 B. 1200 **C. 2700**

Q7. Quel est le taux d'utilisation du RR au niveau du centre de vaccination du CSR de Myan en 2024 ?

- A. 99%** B. 97,61% C. 97,72%

Q8. Quel est le facteur de perte du RR au niveau du centre de vaccination du CSR de Myan en 2024 ?

- A. 1,02 **B. 1,01** C. 1,17

Q9.Quel est le besoin théorique en doses de RR pour un mois de campagne de vaccination à Myan ?

- A. 3159 doses B.3161 doses **C.2727 doses**

Q10.Sachant qu'un flacon de RR compte 20 doses, quel est le nombre de flacons de RR correspondant à son besoin théorique pour la campagne d'un mois à Myan ?

- A. 159 flacons B. 158 flacons **C. 137 flacons**

Q11.Combien de seringues doit-on commander pour reconstituer les flacons de RR correspondant au besoin théorique à utiliser pendant la campagne à Myan ?

- A.137 Seringues** B. 158 Seringues C. 159 Seringues

Q12.Quel est le besoin théorique des seringues pour administrer les doses de RR pendant la campagne de vaccination à Myan ?

- A.2727seringues **B. 2997 seringues** C.3159 seringues

Q13.Quel est la quantité de seringues nécessaire pour réaliser l'activité de vaccination en campagne de RR pendant la campagne de vaccination à Myan ?

- A. **3134 Seringues** B.2885 Seringues C.3318 Seringues

Q14.Quel est le nombre de boîte de sécurité nécessaires pour éliminer les seringues à utiliser pendant la campagne de vaccination à Myan ?

- A. 29 boites **B.32 boites** C. 34 boites

ETUDE DE CAS N°5

Vous êtes en stage au CSR de Allekro dont l'aire sanitaire compte une population de 25000 habitants au 31 Décembre 2024. Le taux de perte du vaccin VPO dans ce centre de santé est estimé à 5% en 2024. Par ailleurs le personnel du centre envisage atteindre au cours de l'année 2024, un objectif vaccinal de 98% de la population cible de vaccination en routine.

Au terme des activités de vaccination de l'année 2024, le taux de couverture annuel du CSR Allekro chez les enfants de 0 à 23 mois a été estimé à 97%.

Par ailleurs les données du tableau ci-dessous ont été enregistrés.

Vaccin	Nombre de doses administrées en 2023
VPO0	1070
VPO2	1067
VPO3	1065
Penta1	1062
Penta3	1060
RR1	1058

Questions

Q1. Quel est le facteur de perte du VPO pour le CSR d'Alle Kro en 2024 ?

A. 1,02 **B-1,05** C-1,11

Q2. Quel est l'effectif des enfants devant bénéficier du VPO en routine dans l'aire de santé du CSR d'Allèkro en 2024 ?

A. 875 B- 1000 **C-1075**

Q3. Calculez le besoin théorique en VPO pour ce centre de vaccination en 2024.

A. **4425 doses** B-4678 doses C-4535 doses

Q4. Quel est l'effectif des enfants de l'aire sanitaire du CSR d'Alle Kro devant bénéficier du vaccin RR en campagne pendant l'année 2024 ?

A. **11250 doses** B-11500 C-11700

Q5. Quel est l'effectif de la population cible de l'aire sanitaire du CSR d'Alle Kro devant bénéficier du Td en routine pendant l'année 2024 ?

A. 1000 **B-1250** C-1350

Q6. Quel est le taux d'utilisation en VPO pour ce centre de vaccination en 2024 ?

A. 85% B-90% **C-95%**

Q7. Quel est le taux d'abandon du VPO au CSR d'Allèkro en 2024?

A. 0,53% B-0,56% **C-0,46%**

Q8. Quel est le taux d'abandon du Penta au CSR d'Allèkro en 2024 ?

A. 0,13% B-0,16% **C-0,18%**

Q9. Quel est le nombre d'enfant de 0 à 23 mois ayant été complètement vacciné au CSR d'Allèkro en 2024 ?

A. **1043** B-1045 C-1047

Q10. Quel est l'effectif de la population cible de l'aire sanitaire du CSR d'Alle Kro devant bénéficier du Td en vaccination en campagne pendant l'année 2024 ?

A. **5000** B-2500 C-1000

ETUDE DE CAS N°6

Baya est une localité peuplée de 20000 habitants au 01/01/2024. Au cours de l'année 2024, 50 décès et 200 naissances vivantes ont été enregistrés au sein de la population de ce village. On note par ailleurs que cette localité a accueilli 25 personnes en provenance de localités voisines et 15 autres personnes l'ont quitté pour s'installer dans des villes du pays.

QUESTIONS

Q1. Quelle est la balance migratoire de la population de Baya 2024 ?

A. 40 B.25 **C. 10**

Q2. Quel est l'accroissement naturel de la population de Baya en 2024 ?

A. **150** B. 250 C. 0,74%

Q3. Quel est l'accroissement annuel de Baya en 2024 ?

A. 150 **B.160** C.0,79%

Q4. Quelle est la population de Baya au 31/12/2024 ?

A. 19935 **B. 20160** C. 20200

Q5. Quel est la population moyenne de Baya en 2024 ?

A.20080 B.20100 C.19968

Q6. Quel est le taux d'accroissement naturel de Baya en 2024 ?

A.0,79% **B.0,74%** C.150

Q7. Quel est le taux d'accroissement annuel de Baya en 2024 ?

A.0,79% B.0,74% C.160

Q8. Quel est le taux brut de mortalité de la population de Baya en 2024 ?

A.0,22% **B.0,24%** C.0,25%

Q9. Quel est le taux brut de natalité de la population de Baya en 2024 ?

A.0,98% **B.0,99%** C.1%

Q10. En combien d'année la population de Baya va-t-elle se dédoubler ?

A.71 ans B.70 ans C.69 ans

Q11. Partant de l'année 2024, déterminer en quelle année la population de Baya doit se dédoubler ?

A.2093 B.2094 **C.2095**

ETUDE DE CAS N°7

Une enquête socio-démographique et épidémiologique effectuée au sein du village de Nonlara a donné les informations suivantes :

-Population totale de la localité au 31/12/2022 : 15000 habitants

-Population totale de la localité au 1^{er}/01/2024 : 15450 habitants.

Pendant l'année 2024, les données sanitaires suivantes ont été relevées à Nonlara

-740 naissances dont 30 mort-nés ;

-Enfants de 1 à 4 ans : 20% de la population totale ;

-Nombre total de décès toutes causes confondues, enregistrés dans la localité : 500 ;

-Nombre de décès d'enfants dans la tranche de 0 à 27 jours : 25 dont 15 dans la tranche de 0 à 7 jours.

-Nombre de décès dans la tranche de 1 à 11 mois :30 dont 25 dus aux IRA et 05 à la rougeole.

-Nombre de décès dans la tranche de 12 à 48 mois : 20 dont 10 dus aux IRA, et 05 au paludisme.

QUESTIONS

Q1.Quel est le taux d'accroissement annuel de la population de Nonlara ?

- A. 0,03% **B.3%** C.0,3 %

Q2.Quelle est la population totale de Nonlara en 2024 ?

- A. 15450 **B.15914** C.15460

Q3.Quelle est la population moyenne de Nonlara en 2024 ?

- A. **15682** B. 15230 C.15225

Q4.Quel est le taux brut de natalité à Nonlara en 2024 ?

- A. 4,86% B.4,85% **C.4,52%**

Q5.Quel est le taux de mortalité néonatale précoce à Nonlara en 2024 ?

- A. ,52% **B.2,11%** C.2,02%

Q6.Quel est le taux de mortalité néonatale tardive à Nonlara en 2024 ?

- A. **1,40%** B.1,35% C.1,25%

Q7.Quel est le taux de mortalité néonatale à Nonlara en 2024 ?

- A. 3,27, % B.3,61% **C.3,51%**

Q8.Quel est le taux de mortalité post-néonatale à Nonlara en 2024 ?

- A. **4,22%** B.4,05% C.3,52%

Q9.Quel est le taux de mortalité infantile de Nonlara en 2024 ?

- A. 7,43% **B.7,74%** C.7,85%

Q10.Quel est l'effectif de la population juvénile de Nonlara en 2024 ?

- A.2638 B.2676 **C.2757**

Q11.Quel est le taux de mortalité juvénile de Nonlara en 2024 ?

- A. **0,72%** B.0,74% C.0,75%

ETUDE DE CAS N°8

Vous êtes en service dans un établissement public hospitalier départemental qui dessert une population totale de 20000 habitants au 31 décembre 2023 avec un TAA de 2%.

Au cours de l'année 2024, les rapport d'activité de cette structure de santé a permis de noter les données suivantes :

-920 naissances vivantes ;

-60% des femmes en âge de reproduction utilisent des moyens de contraception ;

-08 décès des femmes enceintes dont 01 des suites d'une chute de la table d'accouchement par manque de surveillance de la part du personnel et 02 à la suite d'accident de la voie publique.

-05 décès dont 2 dans l'intervalle de 7 semaines après avoir accouché et 3 dans l'intervalle de 35 jours après l'accouchement.

-05 décès des enfants de 0 à 11 mois ont également été mentionnés dans le rapport annuel.

-10 cas de rougeole chez les enfants de 0 à 5 ans dont 05 décès.

Questions

Q1. Quelle est la population totale desservie par cet établissement en 2024 ?

A. 20400

B. 20300

C. 20200

Q2. Quel est le nombre de femme en âge de reproduction desservies par cet établissement en 2024 ?

A. 4040

B. 4080

C. 4020

Q3. Quel est le nombre de femme en âge de reproduction qui utilisent les moyens de contraception dans cet établissement en 2024.

A. 2448

B. 2412

C. 2424

Q4. Quel est le taux global de fécondité au niveau de cette population en 2024 ?

A. 22,77%

B. 22,88 %

C. 22,54 %

Q5. Quel est le taux de mortalité maternelle enregistré au niveau de cet établissement en 2024 ?

A. 1,41%

B. 1,08%

C. 0,86%

Q6. Quel est le nombre d'enfants de 0 à 11 mois en 2024 ?

A. 714

B. 711

C. 707

Q7. Quel est le taux de mortalité infantile enregistré au niveau de cet établissement en 2024 ?

A. 0,35%

B. 0,54%

C. 0,65%

Q8. Quel est le nombre d'enfant de 0 à 5 ans en 2024 ?

A. 4040

B. 4060

C. 4080

Q9. Quel est le taux de morbidité de la rougeole chez les enfants de 0 à 5 ans en 2024 ?

A. 0,24 %

B. 0,26 %

C. 0,28%

Q10. Quel est le taux de mortalité de la rougeole chez les enfants de 0 à 5 ans en 2024 ?

A. 0,13 %

B. 0,14 %

C. 0,12%

Q11. Quel est le taux de létalité de la rougeole en 2024 au niveau de cet établissement ?

A. 50%

B. 40%

C. 30%

ETUDE DE CAS N°10

Vous êtes en service au CSR de Lolobo dont l'aire sanitaire compte 20000 habitants au 01/01/2024 avec un taux d'accroissement annuel constant de 2%.

Au plan épidémiologique, les données suivantes ont été enregistrées en 2024 :

-5000 paludéens ;

-60 diabétiques dont 1/3 déclarés avant 2024

-5000 cas d'infections respiratoires aiguës

-50 décès liés au paludisme

-40 décès liés aux infections respiratoires aiguës

-05 décès des suites du diabète

QUESTIONS

Q1. Quelle est la population totale de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo au 31 Décembre 2024 ?

A. 20100

B. 20200

C. 20400

Q2. Quelle est la population moyenne de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo en 2024 ?

A. 20200

B. 20100

C. 20050

Q3. Quelle est la prévalence du diabète au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo en 2024 ?

A. 60

B. 40

C. 20

Q4. Quel est le taux de prévalence du diabète au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo en 2024 ?

A. 0,09%

B. 0,10%

C. 0,11%

Q5. Quelle est l'incidence du diabète au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo en 2024 ?

A. 40

B. 60

C. 20

Q6. Quel est le taux d'incidence du diabète au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo en 2024 ?

A. 0,10%

B. 0,20%

C. 0,19%

Q7. Quel est le taux de mortalité du paludisme au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo en 2024 ?

A. 0,24%

B. 0,25%

C. 1%

Q8. Quel est le taux de mortalité du diabète au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo ?

- A. 0,01% **B. 0,02%** C. 0,03%

Q9. Quel est le taux de mortalité des infections respiratoires aiguës au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo ?

- A. 0,01% B. 0,02% **C. 0,19%**

Q10. Quelle est le taux de létalité du paludisme au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo ?

- A. 0,8% **B. 1%** C. 8,33%

Q11. Quelle est le taux de létalité du diabète au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo ?

- A. 0,8% B. 1% **C. 8,33%**

Q12. Quelle est le taux de létalité des infections respiratoires aiguës au niveau de l'aire sanitaire du CSR de Lolobo ?

- A. 0,8%** B. 1% C. 8,33%

ETUDE DE CAS N°11

Après votre formation, vous êtes affecté dans un centre de santé urbain.

Dès votre prise de service le 20 Mars 2025, vous mener une étude du milieu dans votre aire sanitaire et commandez vos outils de travail auprès de vos supérieurs hiérarchiques pour assurer correctement vos activités de soins.

Au cours d'une réunion bilan du premier semestre de l'année 2025, le responsable du CSE se plaint du fait qu'il a pour cette période, 54 rapports mensuels d'activités transmis dans le délai requis sur 72 attendus.

QUESTIONS

Q1.Parmi les structures de gestion suivantes, laquelle doit satisfaire vos commandes d'outils de gestion de l'information sanitaire ?

A.Direction régionale

B.Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle

C.District sanitaire

Q2 Parmi les fiches suivantes, indiquez celles qui vous serviront pour gérer l'information sanitaire au niveau de votre centre de santé

A.Fiche A1

B.**Fiche A**

C.**Fiche A3**

D.Fiche B1

Q2.Combien de fiches mensuelles de rapport d'activités devez-vous commander pour assurer la gestion de l'information sanitaire au niveau de votre centre de santé au cours de l'année 2025 ?

A.24

B.20

C.10

Q3.Quel est le taux de promptitude du district au deuxième trimestre de l'année 2025 ?

A.75 %

B. 45%

C.25%

Q4.Parmi les activités suivantes , indiquez celles qui concernent la gestion de l'information sanitaire dans votre structure de santé :

A. Enregistrer les données dans les registres d'activités

B. Commander les fiches de rapport B1

C. Transmettre les fiches de rapports mensuelles à la direction régionale de la santé

D.Traiter les données sanitaires

E. Analyser et interpréter les données sanitaires

F.Archiver chaque mois un exemplaire de la fiche B1 au niveau du centre de santé

Q5. Quel est le circuit de l'information sanitaire produite dans votre CSU ?

1. CSU

2. Direction régionale de la santé

3. DIS

4. District sanitaire

5. Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle

A. 12435 **B. 14235** C. 14325 D. 12354

Q6. CSE signifie :

A. Centre de secours épidémiologique

B. Centre de surveillance épidémique

C. Centre de secours épidémiologique

D. **Centre de surveillance épidémiologique**

Q7. A partir des statistiques du responsable du CSE, indiquez le nombre de structures de santé dont il reçoit les rapports par mois.

A. 72

B. 12

C. 10

D. 6

Q8. Combien de rapports mensuels d'activités le responsable CSE doit-il recevoir en fin d'année 2025 ?

A. 144

B. 142

C. 12

Q9. Combien de rapports annuels d'activités le responsable CSE doit-il recevoir en fin d'année 2025 ?

A. 12

B. 10

C. 08

ETUDE DE CAS N°1

Les données du tableau ci-dessous sont celles relatives à la gestion de l'information sanitaire au niveau des structures sanitaires d'une région sanitaire de la santé en 2024.

Selon le responsable du centre de surveillance épidémiologique de cette région sanitaire, toutes les structures sanitaires ont bien fonctionné et réalisé chacune 100% de taux de complétude dans la transmission des rapports d'activités au cours de l'année 2024.

N°	Type de fiches de rapport	Nombre de Fiches attendues au premier trimestre de 2024
1	Fiche B1	12
2	Fiche A	96
3	Fiche D1	2
4	Fiche C1	3

QUESTIONS

Q1.Combien d'ESPC compte cette région sanitaire ?

A. 32

B. 8

C. 4

Q2.Quel est le nombre d'EPHD de cette région sanitaire ?

A. 4

B. 2

C. 1

Q3.Quel est le nombre d'EPHR de cette région sanitaire ?

A. 4

B. 2

C. 1

Q4.Combien de Direction départementales compte cette région sanitaire ?

A. 4

B. 2

C. 1

Q5.Combien de fiches de rapports d'activité A3 doivent être déposées dans l'ensemble des districts sanitaires de cette région sanitaire en 2024 ?

A. 32

B. 24

C. 4

Q6.Quel est le nombre de rapports d'activité B2 qui doivent être déposés dans l'ensemble des districts sanitaires de cette région sanitaire en 2024 ?

A. 4

B. 6

C. 8

Q7.Combien de fiches de rapports d'activité C2 doivent être déposés dans cette région sanitaire en 2024 ?

A. 1

B. 2

C. 4

Q8.Combien de rapports E1 doit-on produire dans cette Direction régionale en 2024 ?

A. 1

B. 2

C. 4

Q9.Combien de centres de surveillance épidémiologiques compte cette région sanitaire ?

A. 4

B. 3

C. 2

ETUDE DE CAS N°13

Les dates de dépôt des rapports mensuels de morbidité du second semestre de l'année 2024 de l'EPHD de Béoumi et du CSR de Lolobo sont consignés dans le tableau ci-dessous

Structures Sanitaires	Date de dépôt du rapport mensuel de morbidité					
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
CSR Lolobo	05/08/2024	02/09/2024	08/10/2024	03/11/2024	04/12/2024	Non transmis
EPHD Béoumi	13/08/2024	08/09/2024	12/10/2024	15/05/2022	10/06/2022	11/01/2025

Q1.Quelles sont les fiches de rapport d'activités utilisées pour la gestion de l'information sanitaire au niveau du CSR de Lolobo ?

A. Fiche A1

B. Fiche A

C. Fiche B1

D. Fiche A3

Q2.Quelles sont les fiches de rapport d'activités utilisées pour la gestion de l'information sanitaire au niveau de l'EPHD de Béoumi ?

A. Fiche C2

B. Fiche B1

C. Fiche C1

D. Fiche B2

Q3.A quelle structure de gestion doit-on transmettre les fiches de rapports d'activités du CSR de Lolobo après leur remplissage ?

A. **District sanitaire**

B. Direction régionale

C. DIS

D. Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle

Q4.A quelle structure de gestion doit-on transmettre les fiches de rapports mensuels du CHR de Daloa après leur remplissage ?

A. District sanitaire

B. Direction régionale

C. DIS

D. Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle

Q5.Combien de rapports mensuels d'activité ont-ils été déposés dans le temps requis par le personnel du CSR de Lolobo ?

A.6

B.4

B.2

Q6. Quel est le taux de promptitude de la transmission des rapports du CSR de Lolobo au second semestre de l'année 2024 ?

A. 66,66%

B. 50,66%

C. 33,33%

Q7. Quel est le taux de promptitude de la transmission des rapports d'activités de l'EHPD de Béoumi au second trimestre de l'année 2024 ?

A. 33,33%

B. 16,66%

C. 100%

Q8. Quel est le taux de complétude de la transmission des rapports d'activités du CSR de Lolobo au second semestre de l'année 2024 ?

A. 100%

B. 83,33%

C. 41,66%

Q9. Quel est le taux de complétude de la transmission des rapports d'activités de l'EHPD de Béoumi au second semestre de l'année 2024 ?

A. 100%

B. 75%

C. 50%

ETUDE DE CAS N°14

Le tableau ci-dessous présente des données concernant le fonctionnement de la chaîne du froid et la disponibilité des vaccins au niveau du CSR de Pinvoro en 2023.

Ces données ont servi à conduire les activités de monitoring pour les activités de ce centre.

Mois	Juin 2023	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023
Nombre de jours sans rupture de la chaîne du froid	29	31	30	27	29	30
Temps avec rupture de stock de vaccins	05	01	05	00	01	00

Questions

Q1. A partir des données du tableau, indiquez la durée de la période monitorée.

A. 180 jours

B. 181 jours

C. 182 jours

D. 183 jours

Q2.Pendant quel mois se déroulera ce monitoring ?

A. Juin 2023

B. Décembre 2023

C. Novembre 2023

D. Décembre 2024

Q3.Quel est le nombre de jours avec rupture de la chaîne du froid pendant la période monitorée ?

A. 176 jours

B. 175 jours

C. 07 jours

Q4.Quel est le score de la chaîne du froid au niveau de la structure pendant cette période monitorée ?

A. 96,17%

B. 95,62%

C. 96,72%

Q5.Quel est le nombre de jours sans rupture de stock de vaccins pendant la période monitorée ?

A. 11 jours

B. 170 jours

C. 171 jours

Q6.Quel est la disponibilité des vaccins au niveau de la structure pendant cette période monitorée ?

A. 92,89%

B. 93,44%

C. 93,95%

Q7.Parmi les outils suivants, indiquez ceux qui sont des sources de données permettant de calculer l'indicateur de la disponibilité des vaccins

A. Bordereaux de livraison des vaccins et du matériel de vaccination

B. Fiches de stock des vaccins et du matériel de vaccination

C. Le registre de vaccination

D. Le carnet de vaccination des enfants

Q8. Parmi les outils suivants, indiquez celui qui est une source de données permettant de calculer l'indicateur de la couverture effective des activités de la vaccination

A. Feuille de relevé de température

B. Les fiches de stocks des vaccins

C. Le cahier d'inventaire des vaccins

ETUDE DE CAS N°15

Kasséré est une localité la région sanitaire de la Bagoué dotée d'un centre de santé urbain où exercent trois infirmiers, deux sages-femmes, un médecin et deux auxiliaires de santé. La population totale de l'aire sanitaire de ce centre de santé au 31/12/2025 est de 15000 habitants.

On note que 60 % et 30% des habitants résident respectivement dans un rayon de moins de 5 km et entre 5 et 15 km. Toutes les localités de l'aire sanitaire du CSU de Kasséré concernées par la stratégie avancée ont bénéficié d'au moins trois séances de vaccination pendant la période du premier monitoring de l'année 2025. On précise que le mois de Février 2025 compte 28 jours.

Par ailleurs, pendant cette période du monitoring, il y a eu 3 jours et 1 soirée sans relevé de la température du réfrigérateur et 05 jours de rupture en vaccins.

La collecte des données a permis de noter que :

-451 enfants issus de la population cible du PEV ont reçu au moins une dose de vaccin pendant la période monitorée ;

-430 enfants issus de la population cible du monitoring ont reçu pendant la période monitorée, toutes les doses requises de chaque vaccin avec respect du calendrier vaccinal en vigueur.

QUESTIONS

Q1.Quelle est la durée de la période monitorée dans ce texte ?

A.181 jours

B.182 jours

C.183 jours

Q2.Selon le rythme des activités du monitoring en Côte d'Ivoire, précisez le mois pendant lequel a eu lieu ce monitoring.

A. Mai 2025

B. Juin 2025

C. Novembre 2025

D. Décembre 2026

Q3.Selon le rythme des activités du monitoring en Côte d'Ivoire, précisez la période monitorée.

A. Décembre 2024 à Mai 2025

B. Janvier 2025 à Juin 2025

C. Juin 2025 à Novembre 2025

D. Juillet 2025 à Décembre 2025

Q4. Pendant ce monitoring, précisez la période dont les dépenses seront budgétisées.

A. Décembre 2024 à Mai 2025

B. Juin 2025 à Novembre 2025

C. Juillet 2025 à Décembre 2025

D. Janvier 2025 à Juin 2025

Q5. Quelle est l'effectif de la population totale de l'aire sanitaire dont les enfants bénéficient des activités de vaccination du CSU de Kasséré en 2025 ?

A. 15000

B. 13500

C. 9000

Q6. Quelle est l'effectif des enfants concernés par les activités de vaccination du centre de santé en 2025 ?

A. 1023 enfants

B. 921 enfants

C. 525 enfants

Q7. Quel est l'effectif des enfants concernés des activités de vaccination du centre de santé pendant le premier monitoring en 2025 ?

A. 263 enfants

B. 461 enfants

C. 512 enfants

Q8. Quel est l'effectif de la population totale de l'aire sanitaire dont les enfants bénéficient des activités de vaccination du CSU de Kasséré en stratégie fixe en 2025 ?

A. 15000

B. 9000

C. 4500

Q9. Quel est l'effectif des enfants concernés des activités de vaccination du centre de santé en stratégie fixe ?

A. 307

B. 1023

C. 614

Q10. Quel est l'effectif des enfants concernés par les activités de vaccination en stratégie fixe pendant le premier monitoring en 2025 ?

A. 512

B. 307

C. 154

Q11. Quel est l'effectif de la population totale de l'aire sanitaire dont les enfants bénéficient des activités de vaccination du CSU de Kasséré en stratégie avancée en 2025 ?

A. 15000

B. 9000

C. 4500

Q12. Quel est l'effectif des enfants concernés par les activités de vaccination du centre de santé en stratégie avancée en 2025 ?

A. 1023

B. 614

C. 307

Q13. Quel est l'effectif des enfants concernés par les activités de vaccination du centre de santé en stratégie avancée pour le premier monitoring en 2025 ?

A. 154

B. 307

C. 512

Q14. Quelle est l'effectif de la population efficace de ce monitoring de la vaccination en 2025 ?

A. 461

B. 307

C. 154

Q15. Quelle est l'accessibilité géographique de la population cible aux activités de vaccination pendant ce monitoring ?

A. 100%

B. 90,03%

C. 59,96%

Q16. Pendant combien de demi-journées la chaîne du froid a-t-elle mal fonctionné ?

A. 4

B. 5

C. 7

Q17. Pendant combien de demi-journées la chaîne du froid a-t-elle bien fonctionné sur la période monitorée ?

A. 178

B. 357

C. 359

Q18. Quel est le score de qualité de la chaîne du froid pendant la période monitorée ?

A. 95,62%

B. 96,15%

C. 96,17%

Q19. Quel est le nombre de jours sans rupture en vaccins pendant la période du monitoring ?

A. 177 jours

B. 178 jours

C. 179 jours

Q20. Quelle est la disponibilité du vaccin pour cette période monitorée ?

A. 96,72 %

B. 97,25 %

C. 91,80%

Q21. Quelle est l'utilisation du service de vaccination du centre de santé pendant la période monitorée ?

A. 100%

B. 97,83%

C. 93,27%

Q22. Quelle est la couverture adéquate des activités de vaccination pendant la période monitorée ?

A. 93,03%

B. 97,83%

C. 93,27%

ETUDE DE CAS N°16

Le tableau ci-dessous présente les données du suivi de la température du centre de santé rural de Kôfré durant la période allant du 1^{er} Juin 2024 au 30 Novembre 2024. A partir des données suivantes, répondez aux questions qui suivent.

Mois	Juin 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Novembre 2024
Nombre de jours de relevé de la température du réfrigérateur	30	31	31	30	31	30
Nombre de jours avec rupture de la chaine du froid	01	00	01	00	Fiche perdue	00
Temps avec rupture de stock de vaccins et de matériel de vaccination	05	01	04	00	01	00

Questions

Q1. Quel est le nombre de jours sans rupture de stock de vaccins et de matériel de vaccination pendant la période de suivi ?

A. 172 jours

B. 170 jours

C. 175 jours

Q2. Quelle est la disponibilité des vaccins au niveau de la structure pendant cette période de suivi ?

A. 92,89%

B. 93,98%

C. 95,78%

Q3. Quel est le nombre de jours sans rupture de la chaine du froid pendant la période de suivi ?

A. 150 jours

B. 181 jours

C. 175 jours

Q4. Quel est le score de la qualité de la chaine du froid au niveau de la structure pendant cette période monitorée ?

A. 81,96%

B. 90,62%

C. 95,72%

ETUDE DE CAS N°17

Le centre de santé d’Affotobo est une structure rurale de santé dont la somme à la banque à la veille d’un monitoring est estimée à 2.500.000 FCFA y compris les intérêts et les agios dont les montants communiqués par le gérant du compte bancaire sont respectivement de 50500 et 25000 FCFA.

Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels de la période du monitoring sont égales à 500.000 FCFA et celles du coût des actes de santé estimées à 300500 FCFA.

Les dépenses obligatoires du dispensaire et de la maternité sont estimées à 520.400 FCFA.

Questions

A partir des données financières du centre de santé fournies par l’infirmier et la sage-femme, calculez :

Q1.Le fonds de réserve du centre de santé est :

- A. 1674000 FCFA
- B. 1725000 FCFA
- C. 1624000 FCFA

Q2.La somme à budgétiser du centre de santé est de

- A. 800.500 F
- B. 865.600 F
- C. 855.600 F

Q3.Quelles sont les dépenses de fonctionnement local du centre de santé ?

- A. 280300 F
- B. 280200 F
- C. 280100 F

Q4.Quelle est la valeur maximale des dépenses réservées aux imprévus ?

- A. 14.005 F
- B. 14.010 F
- C. 14.020 F

Q5.Quelle est la valeur maximale des dépenses réservées à l’immeuble ?

- A. 28015 F
- B. 28010 F
- C. 28005 F

ETUDE DE CAS N°18

La somme à la banque à la veille d'un monitoring des activités du centre de santé rural de KATALI est égale à 900.000f, non compris les agios et les intérêts dont les montants sont respectivement estimés à 16.000f. et 35.000 f

Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels de la période du monitoring sont égales à 1/3 de la somme à la banque à la veille du monitoring et celles issues du coût des actes de santé estimées au 2/5 de la somme à la banque après mouvement bancaire.

Les dépenses de fonctionnement local sont égales à 250.000 F.

Questions

Q1.Quel est la valeur des recettes de la vente des médicaments essentiels du centre de santé rural de KATALI ?

A. 320000 fcfa

B. 330000 fcfa

C. 300.000 fcfa

Q2.Quel est la valeur de la somme à la banque du centre de santé rural de KATALI après les mouvements bancaires ?

A. 935000 fcfa

B. 919000 fcfa

C. 951000 fcfa

Q3.Quelle est la valeur des recettes issues du coût des actes de santé du centre de santé rural de KATALI ?

A. 360 000 fcfa

B. 370000 fcfa

C. 374000 fcfa

Q4.Quelle est la somme à budgétiser du centre de santé rural de KATALI ?

A. 674000 fcfa

B. 680000 fcfa

C. 690000 fcfa

Q5.Quel est le fonds de réserve du budget du centre de santé rural de KATALI ?

A. 277000 fcfa

B. 261000 fcfa

C. 245000 fcfa

Q6. Quelle est la valeur des dépenses obligatoires du budget du centre de santé rural de KATALI ?

A. 440000 fcfa

B. 430000 fcfa

C. 424000 fcfa

Q7. Quelle est la valeur maximale des dépenses allouées à l'immeuble au niveau du centre de santé rural de KATALI ?

A. 25000 fcfa

B. 12500 fcfa

C. 42400 fcfa

Q8. Quelle est la valeur maximale des dépenses allouées aux imprévus au niveau du centre de santé rural de KATALI ?

A. 25000 fcfa

B. 12500 fcfa

C. 42400 fcfa

ETUDE DE CAS N°19

A la veille du monitoring des activités du centre de santé rural de Kpafonon, le compte bancaire de cette structure de santé contenait une somme de 3.000.000 fcfa, y compris les intérêts et non compris les agios qui représentent respectivement de 10500 fcfa et 27000 fcfa.

Les recettes issues du coût des actes de santé sont estimées à 350.500 Fcfa. Le trésorier du COGES affirme avoir versé à la banque, la somme 800000 F au titre de la valeur de la vente des médicaments essentiels.

Les dépenses obligatoires sont estimées à 515.000 Fcfa.

QUESTIONS

Q1. Quelle est la somme à la banque du centre de santé rural de Kpafonon après mouvement bancaire ?

A. 3000000 Fcfa

B. 3016500 Fcfa

C. 2983500 Fcfa

Q2. Quelle est la somme à budgétiser du centre de santé rural de Kpafonon ?

A. 865500fcfa

B. 1315000 fcfa

C. 1150500 fcfa

Q3. Quel est le fonds de réserve du centre de santé rural de Kpafonon ?

A. 1849500 Fcfa

B. 1866000 Fcfa

C. 1668500 Fcfa

Q4. Quelles sont les dépenses de fonctionnement local du centre de santé rural de Kpafonon ?

A. 305500 Fcfa

B. 800000 Fcfa

C. 635500 Fcfa

Q5. Quelle est la valeur maximale des dépenses réservées aux imprévus du centre de santé rural de Kpafonon ?

A. 31775 Fcfa

B. 40000Fcfa

C. 15275 Fcfa

Q6. Quelle est la valeur maximale des dépenses réservées à l'immeuble du centre de santé

A. 30500 Fcfa

B. 80000 Fcfa

C. 63550 Fcfa

ETUDE DE CAS N°20

Le centre de santé de Monongo dispose à la banque la somme de 1500 000 fcfa, y compris les agios et non compris les intérêts qui sont respectivement de 50500 fcfa et 30000 fcfa. Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels se chiffrent à 250.000 fcfa. La somme à budgétiser du centre de santé est de 800000 fcfa. Les dépenses obligatoires sont estimées à 150.000 fcfa.

A partir des données financières de ce centre, déterminez les éléments ci-dessous

Q47. Quelle est la somme à la banque après les mouvements bancaires du centre ?

A. 1520500 Fcfa

B. 1500000 Fcfa

C. 1479500 Fcfa

Q48. Quelle est la valeur des recettes issues du coût des actes de santé ?

A. 450000 fcfa

B. 550000 fcfa

C. 650000 fcfa

Q49. Quel est le fond de réserve du centre de santé rural de Monongo ?

A. 700000 fcfa

B. 720500 cfa

C. 679500 fcfa

Q50. Quelle est la valeur des dépenses de fonctionnement du centre de santé rural de Monongo ?

A. 650000

B. 550000

C. 450000

Q51. Quelle est la valeur maximale des dépenses allouées aux imprévus au niveau du centre de santé rural de Monongo ?

A. 22500 fcfa

B. 27500 fcfa

C. 32500 fcfa

Q52. Quelle est la valeur maximale des dépenses allouées aux dépenses de l'immeuble au niveau du centre de santé rural de Monongo ?

A. 65000 fcfa

B. 55000 fcfa

C. 45000 fcfa

ETUDE DE CAS N°21

Vous êtes en activité au CSR de Gbalo dont la population des enfants de 0 à 23 mois de l'aire sanitaire est de 1023 enfants au 31/12/2024. La valeur de l'intéressement du personnel est estimée à 75 000 Fcfa pour l'année 2024.

Questions

Q1. Quelle est la population totale de l'aire sanitaire du CSR de Gbalo ?

A. 5000

B. 10000

C. 15000

Q2. Quelle est la valeur des recettes brutes enregistrées dans cette structure de santé ?

A. 500000 f

B. 750000 f

C. 250000 f

Q3. Quel est la valeur du FAS payé au cours de l'année 2024 par cette structure de santé. ?

A. 75000 f

B. 25000 f

C. 50000 f

Q4. Quel est la valeur du salaire du personnel journalier du CSR de Gbalo ?

A. 100000 f

B. 150000 f

C. 50000 f

Q5. Quel est la valeur des ressources propres du CSR de Gbalo ?

A. 275000 f

B. 350000 f

C. 550000 f

ETUDE DE CAS N°22

Vous êtes en activité au CSR de Boyo. La valeur annuelle du Fonds d'action sanitaire de cette structure sanitaire est estimée à 70000 fcfa à la fin de l'année 2024.

Questions

Q1. Quelle est la valeur des recettes brutes enregistrées dans cette structure de santé ?

A. 700000 f

B. 500000 f

C. 250000 f

Q2. Quelle est la valeur de l'intéressement du personnel journalier du CSR de Boyo ?

A. 125000 f

B. 105 000 f

C. 115000 f

Q3. Quelle est la valeur du salaire du personnel du CSR de Boyo ?

A. 120000 f

B. 130000 f

C. 140000 f

Q4. Quelle est la valeur des ressources propres de la structure ?

A. 385000 f

B. 375000f

C. 370000 f

ETUDE DE CAS N°23

Vous êtes en activité au CSR de Kofré. La valeur annuelle du salaire du personnel journalier est de 500000 fcfa.

QUESTIONS

Q1. Quelle est la valeur des recettes brutes enregistrées dans cette structure de santé ?

A. 2500000 f

B. 2250000 f

C. 2150000 f

Q2. Quel est la valeur de l'intéressement du personnel journalier du CSR de Kofré ?

A. 350000 f

B. 375000 f

C. 325000 f

Q3. Quel est la valeur du FAS payé au cours de l'année 2021 par cette structure de santé. ?

A. 187000 f

B. 185000 f

C. 180000 f

Q4. Quel est la valeur des ressources propres de la structure. ?

A. 1438000 f

B. 1435000 f

C. 1550000 f

ETUDE DE CAS N°24

Vous êtes affecté au CSR de Pinvoro le 14 Juin 2024 pour y mener les activités de soins de santé. Pour mener la première budgétisation des dépenses de votre centre de santé demandé par le Directeur départemental, vous mentionnez les éléments de dépenses suivants :

- achat de carburant pour la stratégie avancée
- salaires du personnel non pris en charge par l'Etat ;
- Achat de réfrigérateur ;
- Entretien du matériel et du mobilier ;
- construction d'un hanger pour la vaccination par exemple ;
- Paiement de l'intéressement du personnel
- Fournitures de bureau
- paiement des factures d'eau

A la fin de la période prévue pour la budgétisation vous notez le montant alloué au fonds d'action sociale est de 25000 et que le coût des actes de santé est de 80000.

1. Quel est le rythme d'élaboration du budget d'un centre de santé rural en Côte d'Ivoire ?

- A. Chaque mois
- B. Chaque trimestre
- C. Chaque semestre

2. Parmi les éléments de dépenses suivants énumérés pour votre budgétisation, indiquez ceux qui relèvent du fonctionnement

- A. achat de carburant pour la stratégie avancée
- B. salaire du personnel non pris en charge par l'Etat ;
- C. achat de réfrigérateur ;
- D. entretien du matériel et du mobilier ;
- E. construction d'un hanger pour la vaccination
- F. paiement des factures d'eau

3. Partant des données du texte, le montant des recettes brutes du CSR de Pinvoro est :

- A. 300000
- B. 250000
- C. 150000

4. Quel est le montant de l'interressement du personnel du CSR de Pinvoro :

A. 37500

B. 35500

C. 45500

5. Quel est le montant du salaire du personnel non fonctionnaire du CSR de Pinvoro ?

A. 50000

B. 45000

C. 35000

6. Quel est le montant des ressources propres du CSR de Pinvoro ?

A. 150500

B. 145500

C. 137500

7. Parmi les éléments suivants,indiquez ceux qui constituent des rubriques entrant dans l'élaboration du budget d'un ESPC

A. **Le fonds de réserve**

B. Le FAS

C. L'intéressement du personnel

D. **La somme à budgétiser**

E. **Les dépenses obligatoires**

F. Les recettes brutes

ETUDE DE CAS N°25

Vous êtes en activité au CSR de Pinvoro qui désert une population de 15000 habitants en 2024. A la veille du monitoring des activités du premier semestre de cette année 2024, le solde du compte bancaire du comité de gestion du centre de santé est chiffré à 2000000 F.CFA, non compris les intérêts et les agios qui s'élèvent respectivement à 3500 F.CFA et 30000 F.CFA. Par ailleurs, les ressources financières issues des activités de cette structure sanitaire sont présentées dans le tableau I ci-dessous :

Tableau N°I : Ressources financières

N°	Désignation	Montant
1	Carnet individuel de santé	40000
2	Carnet mère-enfant	37500
3	Injection	25000
4	Pansement	15000
5	Vente des médicaments PSP	1500000
6	Consultation en soins curatifs	50000
7	Mise en observation	15000
8	Petite chirurgie	20000

1. Quelle est la somme à budgétiser du CSR de Pinvoro pendant les activités de ce premier monitoring de l'année 2024 ?

A. 1702500

B. 1700500

C. 1500000

2. Calculez le solde à la banque après les mouvements bancaires.

A. 2030000

B. 2003500

C. 1970000

3. Quel est le fond de réserve disponible sur le compte du COGES de ce CSR pendant ce premier semestre de l'année 2024 ?

A. 301000

B. 304000

C. 305000

4. Quelle est la valeur des ressources brutes recueillies au CSR de Pinvoro pendant ce premier semestre de l'année 2024 ?

A. 252500

B. 203500

C. 202500

5. Calculez le montant du FAS à payer au district sanitaire pour ce premier semestre de l'année 2024.

A. 25250

B. 20350

C. 20250

6. Quel est le montant correspondant à l'intéressement du personnel du CSR de Pinvoro pendant ce premier semestre de l'année 2024 ?

A.30375

B. 30525

C.37875

7. Calculez le montant du salaire du personnel de soutien du centre de santé pour ce premier semestre de l'année 2024.

A. 40500

B. 40700

C. 50500

8. Quelle est la valeur des ressources propres de ce CSR au cours du premier semestre de l'année ?

A.138875

B.111925

C.111375

Bonne chance à toutes et à tous au Diplôme d'Etat 2024-2025.